

Buku Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK KOMPREHENSIF PENDEKATAN PRAKTIS BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Annisa Febriana • I Gede Putu Darma Suyasa • Resa Livia Nica
Ignatus Djuniarto • Riris Friandi • Imran Yaman
Nurhayati • Deli Maria P • Arneliwati

Editor: Heru Ginanjar Triyono



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK KOMPREHENSIF: PENDEKATAN PRAKTIS BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Penulis:

Annisa Febriana, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D.

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.

Drh. Ignatus Djuniarto, S.Kep., M.M.R.

Ns. Riris Friandi, M.Kep.

Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.

Nurhayati, SKM., MPH.

Ns. Deli Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Ns. Arneliwati, M.Kep.

Editor:

Heru Ginanjar Triyono, M.Kep., Ns.

**Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Gerontik Komprehensif: Pendekatan Praktis
Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)**

Penulis: Annisa Febriana, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.
I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D.
Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.
Drh. Ignatus Djuniarto, S.Kep., M.M.R.
Ns. Riris Friandi, M.Kep.
Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nurhayati, SKM., MPH.
Ns. Deli Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Ns. Arneliwati, M.Kep.

Editor: Heru Ginanjar Triyono, M.Kep., Ns.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-80-7

Cetakan Pertama: Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku bunga rampai yang berjudul "Asuhan Keperawatan Gerontik Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu keperawatan gerontik, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks perawatan lansia yang semakin meningkat di era globalisasi ini.

Perkembangan populasi lansia yang terus meningkat di Indonesia dan dunia membawa implikasi penting dalam bidang keperawatan. Dibutuhkan suatu pendekatan komprehensif, ilmiah, dan praktis dalam memberikan asuhan keperawatan bagi lansia, yang tidak hanya berorientasi pada penanganan penyakit tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, buku ini disusun dengan tujuan utama menyediakan panduan praktis berbasis bukti (Evidence-Based Practice) bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, serta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan gerontik.

Buku bunga rampai ini membahas berbagai topik penting dalam keperawatan gerontik, dimulai dari pemahaman mengenai konsep dasar keperawatan gerontik, proses keperawatan yang sistematis dan terintegrasi, serta strategi komunikasi efektif yang sangat penting dalam interaksi dengan lansia. Selain itu, dibahas pula asuhan keperawatan khusus bagi lansia dengan penyakit kronis, kesehatan mental lansia, serta manajemen nutrisi dan hidrasi yang esensial dalam mempertahankan kesehatan fisik dan kognitif lansia.

Tidak kalah penting, buku ini juga menyajikan topik mengenai pencegahan cedera dan keselamatan lansia, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan kemandirian lansia di lingkungan tempat tinggal mereka. Terakhir, topik mengenai promosi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup lansia diulas secara mendalam, menggarisbawahi peran aktif perawat dalam menciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukung kesejahteraan lansia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang keperawatan gerontik, baik di lingkungan akademis maupun di lingkungan praktis pelayanan kesehatan. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada edisi selanjutnya.

Agustus 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN GERONTIK 1

Annisa Febriana, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Keperawatan Gerontik	2
C. Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Gerontik dan <i>Evidence Based Practice</i>	4
D. Referensi	10
E. Glosarium	12

CHAPTER 2 PROSES KEPERAWATAN GERONTIK..... 15

I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D.	15
A. Pendahuluan	15
B. Langkah-Langkah Proses Keperawatan Gerontik	16
C. Teknik Pengkajian Lansia Secara Komprehensif (Fisik, Mental, Sosial)	23
D. Penyusunan Diagnosa Keperawatan pada Lansia.....	26
E. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan Lansia Berbasis Bukti.....	29
F. Evaluasi Efektivitas Asuhan Keperawatan Gerontik.....	33
G. Referensi	35

CHAPTER 3 KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM KEPERAWATAN GERONTIK 37

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.....	37
A. Pendahuluan/Prolog	37
B. Prinsip Dasar Komunikasi Efektif dengan Lansia.....	38
C. Teknik Komunikasi Terapeutik dengan Lansia	40
D. Hambatan Komunikasi pada Lansia	42
E. Dokumentasi Hasil Komunikasi dan Interaksi Efektif dalam Keperawatan Gerontik	44
F. Simpulan.....	46
G. Referensi	47
H. Glosarium	48

CHAPTER 4 PROSES KEPERAWATAN GERONTIK.....51

Drh. Ignatus Djuniarto, S.Kep., M.M.R.....	51
A. Pendahuluan/Prolog.....	51
B. Konsep Dasar Sindrom Geriatri.....	52
C. Teknik Pengkajian dan Deteksi Dini Sindrom Geriatri.....	54
D. Intervensi Keperawatan Efektif pada Sindrom Geriatri.....	55
E. Pencegahan Sindrom Geriatri Melalui Edukasi Keluarga dan Lansia.....	57
F. Studi Kasus Penanganan Sindrom Geriatri Berbasis Bukti.....	59
G. Evaluasi Keberhasilan Asuhan Keperawatan pada Sindrom Geriatri.....	61
H. Tantangan dalam Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Sindrom Geriatri.....	63
I. Simpulan.....	65
J. Referensi.....	66
K. Glosarium.....	67

CHAPTER 5 ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN PENYAKIT KRONIS.....71

Ns. Riris Friandi, M.Kep.	71
A. Pendahuluan/Prolog.....	71
B. Konsep Dasar Sindrom Geriatri (Jatuh, Inkontinensia Urin, Delirium).....	72
C. Teknik Pengkajian dan Deteksi Dini Sindrom Geriatri.....	75
D. Intervensi Keperawatan Efektif pada Sindrom Geriatri.....	76
E. Pencegahan Sindrom Geriatri Melalui Edukasi Keluarga dan Lansia.....	78
F. Studi Kasus Penanganan Sindrom Geriatri Berbasis Bukti.....	80
G. Simpulan.....	82
H. Referensi.....	83
I. Glosarium.....	84

CHAPTER 6 KESEHATAN MENTAL PADA LANSIA87

Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.....	87
A. Pendahuluan/Prolog.....	87
B. Hubungan antara Sindrom Geriatri dengan Kesehatan Mental.....	88
C. Konsep Dasar Sindrom Geriatri (Jatuh, Inkontinensia Urin, Delirium).....	90
D. Teknik Pengkajian dan Deteksi Dini Sindrom Geriatri.....	92
E. Intervensi Keperawatan Efektif pada Sindrom Geriatri.....	94
F. Pencegahan Sindrom Geriatri melalui Edukasi Keluarga dan Lansia.....	96
G. Studi Kasus Penanganan Sindrom Geriatri Berbasis Bukti.....	99
H. Strategi Penguatan Kesehatan Mental Lansia.....	101
I. Evaluasi Keberhasilan Intervensi terhadap Kesehatan Mental Lansia.....	103
J. Tantangan dalam Menjaga Kesehatan Mental pada Lansia dengan Sindrom Geriatri.....	106
K. Simpulan.....	108

L. Referensi	110
M. Glosarium	111

CHAPTER 7 MANAJEMEN NUTRISI DAN HIDRASI PADA LANSIA 113

Nurhayati, SKM., MPH.....	113
A. Pendahuluan/Prolog	113
B. Pentingnya Manajemen Nutrisi dan Hidrasi pada Lansia	114
C. Teknik Pengkajian Status Gizi dan Hidrasi pada Lansia.....	116
D. Intervensi Keperawatan untuk Mengatasi Gangguan Nutrisi dan Hidrasi pada Lansia	118
E. Edukasi Keluarga tentang Pola Makan Sehat dan Kebutuhan Hidrasi Lansia.....	120
F. Pencegahan Malnutrisi dan Dehidrasi pada Lansia di Rumah dan Komunitas	121
G. Evaluasi Keberhasilan Manajemen Nutrisi dan Hidrasi Lansia.....	123
H. Studi Kasus Implementasi Manajemen Nutrisi dan Hidrasi yang Efektif pada Lansia	125
I. Simpulan	127
J. Referensi	128
K. Glosarium	129

CHAPTER 8 PENCEGAHAN CEDERA DAN KESELAMATAN LANSIA 131

Ns. Deli Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom.	131
A. Pendahuluan	131
B. Konsep dasar pencegahan cedera pada lansia.....	131
C. Teknik pengkajian risiko cedera di lingkungan rumah.....	135
D. Tes Berdiri dari Kursi	137
E. Intervensi keperawatan dalam meningkatkan keamanan lingkungan rumah lansia	138
F. Program Latihan Fisik Sederhana untuk Mencegah Jatuh pada Lansia.....	140
G. Edukasi keluarga tentang pentingnya keamanan dan pencegahan cedera lansia di rumah.....	144
H. Kesimpulan	145
I. Referensi	146

CHAPTER 9 PROMOSI KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA..... 147

Ns. Arneliwati, M.Kep.....	147
A. Pendahuluan	147
B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan pada Lansia	148
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lansia	150
D. Strategi Promosi Kesehatan untuk Lansia.....	152

E. Program-Program Promosi Kesehatan Lansia	153
F. Evaluasi dan Monitoring Program.....	154
G. Tantangan dan Peluang	155
H. Kesimpulan	155
I. Referensi	156
J. Glosarium	158
PROFIL PENULIS	161

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN GERONTIK

Annisa Febriana, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

A. Pendahuluan

Pertambahan populasi lanjut usia merupakan fenomena global yang membawa berbagai implikasi terhadap sistem pelayanan kesehatan. Di Indonesia, populasi lanjut usia diproyeksikan meningkat pesat dalam beberapa tahun yang mendatang. Menurut Data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk lansia telah mencapai lebih dari 12% dari total populasi, menjadikan Indonesia memasuki era "*aging population*" (Badan Pusat Statistik, 2024). Tren ini menggambarkan adanya pergeseran demografis yang signifikan sehingga menuntut sistem kesehatan untuk dapat beradaptasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya pada populasi lansia.

Pelayanan keperawatan gerontik yang efektif dan komprehensif sangat dibutuhkan terutama yang berbasis pada pendekatan *evidence-based practice* (EBP). EBP yang dijalankan dalam proses implementasi keperawatan gerontik akan memudahkan keluarga dengan lansia untuk melakukan pengambilan keputusan klinis didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, dan nilai yang dianut pasien sehingga pelayanan keperawatan mampu meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan (Yulistanti., 2023). Pendekatan ini penting dalam menangani kompleksitas pada kondisi kesehatan lansia yang sering mengalami multi morbiditas dan polifarmasi.

Asuhan keperawatan gerontik di komunitas tidak hanya berfokus pada individu lansia sebagai penerima layanan tetapi juga memerlukan kolaborasi antar tenaga kesehatan, termasuk perawat, dokter, ahli gizi, apoteker, pekerja sosial, dan masyarakat setempat sebagai mitra aktif. Kolaborasi interprofesional terbukti dapat meningkatkan koordinasi layanan, mengurangi hospitalisasi berulang, serta memperbaiki hasil kesehatan pasien lanjut usia (Suparyanto dan Rosad, 2020). Pada praktik di komunitas, pendekatan kolaboratif ini juga mendukung asuhan keperawatan yang efektif, edukasi kesehatan, dan pemantauan kondisi kronis lansia secara lebih efektif.

Pemahaman terhadap kolaborasi interprofesional dan peran perawat dalam tim multidisiplin menjadi landasan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bersifat holistik bagi populasi lanjut usia. Perawat komunitas

memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam memberdayakan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari sistem pendukung lansia (Stanhope, M., & Lancaster, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada keterpaduan, keterjangkauan dan partisipasi masyarakat.

B. Konsep Dasar Keperawatan Gerontik

Keperawatan gerontik bukan sekadar memberikan perawatan kepada lansia yang mengalami gangguan kesehatan tetapi juga menekankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari individu lanjut usia. Pendekatan ini penting karena lansia sering kali mengalami kondisi, keterbatasan mobilitas, isolasi sosial, hingga penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, sebagai perawat gerontik dituntut memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian komprehensif serta menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap lansia termasuk intervensi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan pencegahan disabilitas (Mardiana, 2023).

Pada praktik asuhan keperawatan gerontik mencakup pelayanan terhadap lansia dalam kondisi sehat maupun sakit. Untuk lansia sehat, intervensi keperawatan diarahkan pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, termasuk penyuluhan gizi, latihan fisik yang sesuai usia, serta dukungan untuk menjaga kesehatan mental dan sosial. Sementara pada lansia yang mengalami penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, *osteoarthritis*, atau demensia, perawat bertanggung jawab dalam manajemen gejala, edukasi pengobatan, pemantauan efek samping terapi, dan koordinasi layanan antarprofesi guna memastikan kontinuitas dan efektivitas pelayanan (Dhian Satya Rachmawati, Siti Juwariyah, Yeanneke Liesbeth Tinungki, 2023; Gawara et al., 2023).

Asuhan keperawatan juga melibatkan peran penting dalam proses rehabilitasi fungsional, terutama setelah lansia mengalami peristiwa akut seperti stroke, jatuh, atau fraktur. Perawat gerontik bekerja sama dengan tim rehabilitasi untuk membantu lansia mengembalikan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari (ADL) melalui latihan-latihan tertentu dan modifikasi lingkungan yang mendukung. Selain itu, pemberdayaan keluarga sebagai pendukung dalam proses pemulihan pasien juga menjadi bagian integral dari intervensi, agar lansia memperoleh dukungan sosial dan emosional yang konsisten di rumah (Agnes Dewi Astuti, Hyan Oktodia Basuki, 2024; Prof. Dr. Rita Benya Adriani, S.Kp. et al., 2024).

Keperawatan gerontik harus mencakup dukungan spiritual dan sosial yang berkesinambungan. Lansia sering menghadapi tantangan emosional seperti kesepian, kehilangan pasangan hidup, atau penurunan peran sosial. Perawat

berperan sebagai fasilitator untuk menghubungkan lansia dengan komunitas, kelompok spiritual, atau kegiatan sosial yang sesuai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "*healthy aging*" atau penuaan sehat yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesejahteraan mental spiritual dalam menjalani masa tua secara bermakna dan produktif(Hidayati et al., 2020).

Penerapan *Evidence Based Practice (EBP)* dalam keperawatan gerontik menjadi kunci dalam menjamin asuhan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan unik lansia. Pada praktiknya EBP memerlukan kemampuan perawat untuk mengintegrasikan hasil-hasil riset terbaru dengan keahlian klinis serta mempertimbangkan preferensi individu lansia yang dilayani. Hal ini menjadi sangat penting karena lansia memiliki kerentanan fisiologis dan psikososial yang kompleks sehingga intervensi keperawatan perlu disesuaikan dengan konteks hidup mereka, bukan hanya berdasarkan protokol standar.

EBP juga memberikan kerangka sistematis untuk mengurangi kesenjangan antara penelitian dan praktik klinik. Mencakup berbagai intervensi mulai dari manajemen nyeri kronik, pencegahan luka dekubitus, hingga pendekatan psikososial seperti *reminiscence therapy* dan *spiritual care*. Studi menunjukkan bahwa penggunaan EBP secara konsisten dalam pelayanan keperawatan dapat menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial, meningkatkan kepuasan pasien, serta memperpendek lama perawatan. Hal ini memperkuat argumen bahwa praktik berbasis bukti bukan sekadar tren akademik melainkan kebutuhan klinis nyata(Siti Hikmah et al., 2024). Lebih lanjut keperawatan gerontik berbasis EBP mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur. Melalui langkah-langkah sistematis EBP yaitu *Ask, Acquire, Appraise, Apply, dan Assess* perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana intervensi tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam meningkatkan kualitas layanan(Tomotaki et al., 2024).

EBP dalam keperawatan gerontik memberikan kerangka kerja sistematis bagi perawat dalam menjalankan tugasnya. Proses ini diawali dengan perumusan pertanyaan klinis spesifik (*Ask*) diikuti pencarian bukti dari sumber tepercaya seperti jurnal ilmiah atau *guideline* praktik klinik (*Acquire*) penilaian terhadap validitas dan relevansi bukti (*Appraise*) penerapan bukti dalam praktik yang mempertimbangkan kondisi dan budaya pasien (*Apply*) serta evaluasi hasil intervensi dan refleksi praktik (*Assess*). Pendekatan ini membantu perawat dalam menghindari praktik yang sudah kurang relevan untuk dilakukan sekaligus mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan(Tomotaki et al., 2024).

Proses ini mendorong perawat untuk terus memperbaharui pengetahuan, berpikir kritis terhadap intervensi yang digunakan serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan spiritual pasien lansia yang mungkin mempengaruhi penerimaan

terhadap terapi tertentu. Integrasi EBP dalam keperawatan gerontik tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lansia tetapi juga memperkuat posisi perawat sebagai profesional yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. EBP bukan sekadar alat bantu teknis tetapi merupakan filosofi praktik yang menjunjung tinggi hak lansia untuk mendapatkan perawatan terbaik yang berakar pada bukti ilmiah, kearifan klinis, dan nilai-nilai pribadi mereka.

C. Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Gerontik dan *Evidence Based Practice*

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan sistematis dalam pemberian layanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang holistik, efektif, dan terkoordinasi. Kolaborasi interprofesional menjadi sangat penting mengingat kompleksitas kebutuhan lansia yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Lansia umumnya mengalami berbagai penyakit kronis dan degeneratif, keterbatasan mobilitas, penurunan kognitif, hingga isolasi sosial. Pemberian asuhan keperawatan tidak dapat dilakukan secara tunggal hanya pada satu profesi saja melainkan memerlukan sinergi berbagai tenaga kesehatan untuk menciptakan intervensi yang menyeluruh dan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice/EBP*)(Jylhä et al., 2017).

1. Definisi dan Urgensi Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional adalah bentuk praktik kesehatan di mana tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama berbagi tanggung jawab, serta membuat keputusan bersama untuk mencapai tujuan yang berpusat pada pasien. Pada populasi lansia praktik ini dapat menurunkan fragmentasi layanan, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, serta mengurangi risiko *medical error* dan rehospitalisasi. Kolaborasi ini penting dalam mengintegrasikan keahlian dari perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, psikolog, hingga pekerja sosial. Sebagai contoh, dalam menangani lansia dengan penyakit *stroke* dan gangguan kognitif, perawat memiliki peran dalam pemantauan harian dan dukungan psikososial, dokter menangani aspek medis, fisioterapis memfokuskan rehabilitasi fungsional, dan ahli gizi mengatur pola makan sesuai kondisi penyakit. Semua profesi tersebut bekerja dalam kerangka kerja kolaboratif dengan komunikasi terbuka dan tujuan bersama.

Kolaborasi interprofesional pada konteks gerontik juga berfungsi sebagai strategi untuk menghadapi kompleksitas kebutuhan lansia yang sering mengalami multimorbiditas, penurunan kognitif, dan keterbatasan fungsional. Pada kerangka praktik berbasis *Evidence Based Practice* (EBP), pendekatan ini

memungkinkan tim kesehatan untuk saling bertukar informasi ilmiah terbaru dan menyusun intervensi yang terintegrasi, tepat sasaran, serta disesuaikan dengan bukti terkini. Selain itu, kolaborasi lintas disiplin juga memperkuat proses evaluasi dan tindak lanjut layanan, karena setiap intervensi yang diberikan dapat dikaji bersama melalui refleksi kritis dan diskusi antarpakar.

Urgensi kolaborasi semakin mengemuka ketika layanan kesehatan diarahkan pada sistem berkelanjutan berbasis komunitas. Perawat gerontik tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai koordinator tim kesehatan yang menjembatani kebutuhan lansia dengan layanan yang tersedia. Intervensi rumah, manajemen kasus, serta advokasi terhadap hak-hak lansia menjadi lebih efektif bila dijalankan dalam kerangka kolaborasi interprofesional. Bekerja secara sinergis tim kesehatan dapat meminimalisir tumpang tindih peran, mempercepat penanganan, dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

2. Prinsip-Prinsip Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Gerontik

Pada penerapannya kolaborasi interprofesional harus mematuhi prinsip-prinsip utama, yakni (Rahmat Budiman, 2023):

- a. Komunikasi Terbuka dilakukan dengan pertukaran informasi yang jelas dan efektif antar anggota tim.
- b. Penghargaan terhadap peran dan keahlian profesi lain dengan mengakui kontribusi unik masing-masing profesi dalam tim.
- c. Pengambilan keputusan bersama dengan menyusun rencana asuhan berdasarkan musyawarah dan konsensus.
- d. Berorientasi pada Klien (*Client-Centered Care*), dimana seluruh aktivitas berfokus pada kebutuhan, harapan, dan preferensi pasien.
- e. Akuntabilitas Bersama dengan Bertanggung jawab terhadap hasil layanan secara kolektif.

Pada keperawatan gerontik penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan klien. Komunikasi terbuka antara perawat dan ahli farmasi dapat mencegah terjadinya polifarmasi pada lansia yang sering kali menjalani pengobatan untuk beberapa penyakit kronis sekaligus. Kolaborasi interprofesional tidak hanya memperkuat koordinasi antar profesi, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan yang kompleks, terutama dalam kondisi klinis lansia yang sering mengalami sindrom geriatrik seperti delirium, demensia, malnutrisi, dan risiko jatuh. Intervensi tunggal dari satu profesi tidak cukup untuk memberikan asuhan yang holistik. Misalnya ketika lansia mengalami delirium akut di rumah sakit, perawat perlu segera melakukan asesmen lingkungan, ahli gizi meninjau kemungkinan ketidakseimbangan

elektrolit atau kekurangan nutrisi, sedangkan dokter mengevaluasi faktor medikamentosa dan penyakit penyerta. Kolaborasi yang intensif dapat mencegah komplikasi lebih lanjut, mempercepat pemulihan, serta mengurangi lama perawatan di rumah sakit.

Selain itu kolaborasi interprofesional sangat penting dalam transisi perawatan, seperti pemulangan pasien lansia dari rumah sakit ke rumah atau fasilitas pelayanan jangka panjang. Masa transisi ini merupakan momen rawan terjadinya disrupsi dalam kontinuitas asuhan, yang dapat menyebabkan rehospitalisasi atau penurunan fungsi. Perawat, pekerja sosial, dan apoteker harus bekerja sama untuk memastikan pasien dan keluarga memahami rencana asuhan lanjutan, pengelolaan obat yang tepat, serta dukungan sosial yang tersedia. Kolaborasi yang terstruktur, dengan pelibatan aktif keluarga sebagai bagian dari tim, terbukti meningkatkan kemandirian lansia dan mengurangi ketergantungan pada layanan darurat. Pada konteks ini, kolaborasi bukan sekadar strategi, tetapi menjadi kebutuhan fundamental dalam sistem pelayanan gerontik yang responsif, adaptif, dan manusiawi.

3. Model Kolaborasi Interprofesional dalam Konteks Gerontik

Berbagai model dikembangkan untuk mendukung kolaborasi tim interprofesional dalam pelayanan geriatri. Salah satunya adalah *Geriatric Interdisciplinary Team Model (GITM)* yang dikembangkan oleh *Hartford Institute*. Model ini menekankan evaluasi menyeluruh terhadap lansia melalui pendekatan multidisiplin, pertemuan tim secara berkala, dan pembuatan rencana asuhan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan status fungsional lansia, menurunkan lama perawatan, dan memperbaiki kualitas hidup.

Model lainnya adalah *Collaborative Practice Model*, yang didasarkan pada prinsip kolaborasi setara antaranggota tim, pengambilan keputusan bersama, dan partisipasi aktif pasien serta keluarganya. Dalam konteks keperawatan gerontik, model ini sangat sesuai diterapkan pada layanan *home care*, *palliative care*, maupun pada manajemen penyakit kronis seperti demensia dan penyakit kardiovaskular. Kolaborasi dalam model ini difasilitasi melalui komunikasi terapeutik, dokumentasi kolaboratif, dan penggunaan data berbasis bukti untuk mendukung setiap keputusan klinis. Model ini selaras dengan prinsip-prinsip *Evidence-Based Practice*, yang tidak hanya mengandalkan hasil riset terkini, tetapi juga mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kondisi individu lansia.

Selain GITM dan Collaborative Practice Model, model lain yang relevan dalam konteks gerontik adalah *Patient-Centered Medical Home (PCMH)* dan *Chronic Care Model (CCM)* (Nishijima David L; Wisner, David H; Holmes, James F

& Maxson & Mitchell, 2016). PCMH menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh aktivitas pelayanan, dengan tim lintas profesi yang secara aktif terlibat dalam koordinasi perawatan, pengelolaan data kesehatan elektronik, dan komunikasi berkelanjutan dengan pasien dan keluarganya. Sementara itu, CCM lebih fokus pada peningkatan kualitas perawatan pasien dengan penyakit kronis melalui integrasi antara komunitas, organisasi pelayanan, dan sistem informasi. Dalam pelayanan gerontik, CCM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen penyakit degeneratif yang sering diderita oleh lansia, seperti diabetes, hipertensi, dan osteoarthritis.

4. Integrasi EBP dalam Kolaborasi Interprofesional

EBP menjadi landasan penting dalam praktik kolaboratif. Setiap intervensi yang dilakukan oleh tim interprofesional harus berbasis pada bukti ilmiah terkini, baik berupa *guideline*, *systematic review*, maupun hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dalam praktiknya, integrasi EBP dalam kolaborasi dapat dilakukan melalui (Susilaningsih et al., 2017):

- a. Diskusi dan pertemuan tim interprofesional untuk mengevaluasi bukti ilmiah sebelum menentukan intervensi.
- b. Pelatihan bersama antarprofesi terkait metode pencarian dan penilaian bukti.
- c. Pembuatan *Clinical Pathway* dan SOP berbasis EBP, yang disusun secara kolektif oleh berbagai profesi.

Contohnya dalam penanganan lansia dengan *diabetes mellitus* dan luka kaki diabetik, tim interprofesional akan menggunakan guideline terbaru dari *International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)* sebagai acuan bersama. Selanjutnya, dokter akan mengatur terapi medikamentosa, perawat melakukan perawatan luka berbasis bukti, ahli gizi menyesuaikan diet, dan fisioterapis membantu rehabilitasi untuk mencegah disabilitas.

5. Peran Perawat dalam Kolaborasi Interprofesional

Perawat memiliki peran sentral dalam tim interprofesional. Dalam konteks gerontik, perawat tidak hanya sebagai pelaksana intervensi, tetapi juga sebagai koordinator layanan, edukator, advokat pasien, dan penghubung antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain.

- a. Koordinator: Perawat menjembatani komunikasi antara profesi dan memastikan rencana asuhan terlaksana sesuai jadwal.
- b. Advokat: Perawat memperjuangkan hak dan keinginan pasien lansia, khususnya dalam pengambilan keputusan terapi.

- c. Edukator: Perawat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait diagnosis, pengobatan, dan cara perawatan mandiri.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Perawat secara kontinu melakukan evaluasi terhadap intervensi dan menyampaikan feedback kepada tim.

EBP memperkuat peran perawat sebagai pengambil keputusan klinis yang berbasis bukti. Melalui pelatihan dan praktik EBP, perawat dapat meningkatkan kompetensi dalam menilai jurnal, menyusun pertanyaan klinis berbasis PICO, dan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik sehari-hari.

6. Tantangan dalam Kolaborasi Interprofesional Berbasis EBP

Meskipun memiliki banyak keuntungan, pelaksanaan kolaborasi interprofesional berbasis EBP tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya:

- a. Kurangnya pemahaman antarprofesi tentang tugas dan peran masing-masing.
- b. Ketimpangan kekuasaan dan komunikasi antara profesi (misalnya dominasi keputusan oleh profesi medis).
- c. Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan evaluasi bukti ilmiah secara bersama.
- d. Kurangnya pelatihan EBP lintas profesi dalam institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan dukungan dari level institusional berupa kebijakan yang mendorong kolaborasi antarprofesi, pelatihan berkelanjutan tentang EBP, serta sistem dokumentasi dan evaluasi terpadu.

7. Strategi Penguatan Kolaborasi Interprofesional di Komunitas

Pemberian layanan keperawatan gerontik berbasis komunitas menggunakan strategi berikut dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi:

- a. Pembentukan tim geriatri komunitas (*Community Geriatric Team*).
- b. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem rekam medis elektronik bersama.
- c. *Case conference* lintas profesi secara berkala.
- d. Pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan sebagai bagian dari tim.
- e. Integrasi praktik EBP dalam program homecare dan posyandu lansia.

Keterlibatan masyarakat dan keluarga sebagai mitra dalam tim kolaboratif juga penting, terutama dalam mendorong lansia untuk mengikuti pengobatan, pola makan sehat, dan aktivitas fisik rutin.

8. Evaluasi Hasil Kolaborasi Interprofesional dalam Pelayanan Kesehatan Gerontik

Evaluasi hasil kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan gerontik merupakan komponen penting dalam menjamin efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan kepada lansia. Kolaborasi yang berhasil tidak hanya ditandai oleh tercapainya tujuan klinis, tetapi juga oleh kepuasan pasien, peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan kohesi dan komunikasi antarprofesi. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hasil klinis pasien, proses kolaborasi tim, hingga aspek sistem dan organisasi.

a. Indikator Hasil Klinis Pasien

Evaluasi terhadap hasil klinis mencakup pencapaian target-target kesehatan lansia, seperti pengendalian penyakit kronis (contoh: hipertensi, diabetes), peningkatan status fungsional (kemampuan aktivitas sehari-hari), serta penurunan kejadian rawat inap atau komplikasi. Penggunaan instrumen standar seperti *Barthel Index*, *Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL)*, dan *Mini Nutritional Assessment* menjadi alat bantu penting dalam menilai efektivitas intervensi berbasis kolaborasi. Ketika kolaborasi tim berjalan optimal, pasien lansia cenderung menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, penurunan angka kejadian penyakit yang dapat dicegah, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

b. Evaluasi Proses Kolaborasi Tim

Penilaian terhadap dinamika tim kolaboratif penting untuk mengetahui sejauh mana peran masing-masing profesi terlaksana dengan efektif. Aspek yang dievaluasi meliputi komunikasi antarprofesi, saling menghormati peran dan kompetensi, pengambilan keputusan bersama, dan adanya refleksi terhadap praktik yang dilakukan. Instrumen seperti *Team Climate Inventory (TCI)* dan *Interprofessional Collaborative Competency Attainment Survey (ICCAS)* telah digunakan untuk mengukur sejauh mana kolaborasi berjalan secara sinergis. Penurunan konflik profesional, peningkatan kepuasan kerja, dan efisiensi pelayanan sering kali menjadi indikator keberhasilan kolaborasi di tingkat proses.

c. Perspektif Pasien dan Keluarga

Kepuasan pasien lansia dan keluarganya menjadi indikator penting dalam evaluasi kolaborasi interprofesional. Ketika pasien merasa bahwa perawat, dokter, ahli gizi, apoteker, dan pekerja sosial bekerja secara terkoordinasi, rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem pelayanan meningkat. Survei seperti *Client Satisfaction Questionnaire (CSQ)* dan wawancara semi terstruktur dapat digunakan untuk menggali persepsi mereka terhadap pelayanan yang

diterima. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai dan preferensi pasien, yang merupakan salah satu pilar penting dalam praktik EBP.

9. Evaluasi Sistem dan Organisasi

Evaluasi pada tingkat makro meninjau bagaimana kebijakan, struktur organisasi, dan sistem mendukung atau menghambat kolaborasi interprofesional. Ini mencakup sistem rujukan, integrasi rekam medis elektronik (EMR), pelatihan lintas profesi, dan dukungan administratif terhadap model pelayanan berbasis tim. Organisasi pelayanan kesehatan yang mengimplementasikan *interprofessional collaborative care* secara konsisten umumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya perawatan jangka panjang, dan pengurangan *hospital readmission rate* pada lansia.

10. Penggunaan Model dan *Framework* Evaluatif

Beberapa model digunakan sebagai kerangka evaluasi kolaborasi interprofesional, di antaranya:

- a. *The Interprofessional Education Collaborative (IPEC) Core Competencies*: sebagai pedoman kompetensi kolaboratif yang menjadi tolok ukur.
- b. *Donabedian Model (Structure-Process-Outcome)*: menilai kualitas pelayanan berdasarkan struktur sistem, proses kolaborasi, dan hasil yang diperoleh.
- c. *Logic Model for Interprofessional Collaboration*: digunakan untuk menyusun rencana evaluasi berdasarkan input, aktivitas, *output*, dan *outcome* jangka pendek maupun panjang.

11. Tantangan dalam Evaluasi Kolaborasi

Meskipun evaluasi kolaborasi interprofesional memiliki banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan latar belakang profesi, resistensi terhadap perubahan peran, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kurangnya pelatihan dalam penilaian antarprofesi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan dan sistem monitoring yang terstruktur agar proses kolaborasi tetap berjalan efektif.

D. Referensi

Agnes Dewi Astuti, Hyan Oktodia Basuki, S. P. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*.

Dhian Satya Rachmawati, Siti Juwariyah, Yeanneke Liesbeth Tinungki, et. a. (2023). *Keperawatan Gerontik: Panduan Praktis Keperawatan Gerontik untuk Perawat*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Gawara, A., Hutajulu, K., & Agrina, A. (2023). Penerapan Evidence Based Practice Terapi Infrared Terhadap Penurunan Nyeri Pada Lansia Dengan

- Osteoarthritis. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol2.iss2.771>
- Hidayati, M., Lestari, S. P., Sunu, J., Tyoso, P., & Tengah, J. (2020). Healthy aging menuju lansia sehat dan aktif 1,2,3). *Healthy Aging Menuju Lansia Sehat Dan Aktif*, 205–211.
- Jylhä, V., Oikarainen, A., Perälä, M.-L., & Holopainen, A. (2017). Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region. *World Health Organization*, 1–34.
- Mardiana, M. (2023). Ilmu Dasar Keperawatan Gerontik. In *jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Nishijima David L; Wisner, David H; Holmes, James F, D. K. S., & Maxson & Mitchell. (2016). 乳鼠心肌提取 HHS Public Access. *Physiology & Behavior*, 176(25), 139–148. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2014.8263.Patient-Centered>
- Prof. Dr. Rita Benya Adriani, S.Kp., M. K., Nadya Puspita Adriana, S.Psi., M. P., Dipo Wicaksono, S.KM., M. K., & Laili Fanafilah, S. G. (2024). "Gerontik: Dilihat dari Perspektif Kesehatan Masyarakat dan Psikolog. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue April).
- Rahmat Budiman. (2023). *Bunga Rampai home care*.
- Siti Hikmah, Siti Syarah Nursuada, Fitri Nurul Hayani, & Ishma Annisa. (2024). Peran Terapi Reminiscence sebagai Upaya untuk Memelihara Fungsi Memori pada Lansia Yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 3(1), 39–43. <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i1.896>
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community (10th ed.)*. Elsevier.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). FullBook Asuhan Keperawatan Gerontik. In *Suparyanto dan Rosad (2015)* (Vol. 5, Issue 3).
- Susilaningsih, F. S., Mediani, H. S., Kurniawan, T., Widiawati, M., Maryani, L., & Meharawati, . Ira. (2017). Sosialisasi Model Praktik Kolaborasi Interprofesional Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(1), 10–13.
- Tomotaki, A., Sakai, I., Fukahori, H., & Tsuda, Y. (2024). Evaluation of an evidence-based practice education workshop focused on critical appraisal for advanced practice nurses: A before-after intervention study. *BMC Medical Education*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06315-z>
- Yulistanti., Y. (2023). FullBook Keperawatan Gerontik. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue April).

E. Glosarium

A

ADL (*Activities of Daily Living*): Aktivitas harian yang diperlukan individu untuk menjalani kehidupan mandiri, seperti makan, mandi, berpakaian, toileting, dan berpindah tempat.

***Aging Population*:** Istilah demografis untuk masyarakat yang memiliki proporsi lanjut usia yang meningkat secara signifikan.

B

***Barthel Index*:** Skala penilaian kemampuan fungsional individu dalam melakukan ADL secara mandiri.

C

***Client Centered Care*:** Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan nilai individu pasien.

***Collaborative Practice Model*:** Model pelayanan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan kesehatan bersama tim kesehatan.

D

***Delirium*:** Kondisi gangguan kesadaran dan perubahan kognitif akut yang sering terjadi pada lansia.

***Donabedian Model*:** Kerangka evaluasi kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan struktur, proses, dan hasil.

E

***EBP (Evidence Based Practice)*:** Pendekatan praktik profesional yang mengintegrasikan bukti penelitian terkini, keahlian klinis, dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan.

***Evaluasi Kolaborasi Interprofesional*:** Proses menilai efektivitas kerja sama antarprofesi dalam pelayanan kesehatan, mencakup hasil klinis, proses tim, dan sistem organisasi.

F

***Fraktur*:** Patah tulang, kondisi umum pada lansia akibat osteoporosis atau jatuh.

G

***Geriatric Interdisciplinary Team Model (GITM)*:** Model pelayanan gerontik yang melibatkan berbagai profesi untuk memberikan perawatan terpadu dan komprehensif bagi lansia.

***Guideline*:** Pedoman klinis berbasis bukti yang digunakan sebagai acuan praktik dalam pelayanan kesehatan.

H

Healthy Aging: Konsep penuaan sehat yang mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal sepanjang usia lanjut.

I

IPEC (*Interprofessional Education Collaborative*): Kerangka kompetensi kolaboratif antarprofesi dalam pendidikan dan praktik kesehatan.

Indeks Katz ADL: Instrumen pengukuran kemandirian lansia dalam melakukan enam fungsi dasar kehidupan sehari-hari.

J

Jurnal Ilmiah: Publikasi akademik yang berisi artikel hasil penelitian, telaah pustaka, dan laporan ilmiah lainnya.

K

Komunikasi Terbuka: Pertukaran informasi yang jelas dan jujur antar anggota tim kesehatan dalam kolaborasi interprofesional.

L

Luka Dekubitus: Luka pada kulit dan jaringan bawah akibat tekanan berkepanjangan, sering terjadi pada lansia yang mengalami imobilitas.

M

Mini Nutritional Assessment (MNA): Instrumen skrining status gizi lansia.

Multimorbiditas: Kondisi di mana seseorang mengalami dua atau lebih penyakit kronik secara bersamaan.

N

Nosokomial: Infeksi yang didapatkan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.

O

Outcome: Hasil atau dampak dari suatu intervensi atau proses pelayanan kesehatan.

P

PICO (*Patient, Intervention, Comparison, Outcome*): Format pertanyaan klinis dalam EBP untuk memudahkan pencarian bukti ilmiah.

Polifarmasi: Penggunaan banyak obat secara bersamaan, sering terjadi pada lansia dan berisiko menyebabkan efek samping.

Posyandu Lansia: Pos pelayanan terpadu untuk lanjut usia yang menyediakan pemeriksaan kesehatan dasar di tingkat komunitas.

Q

Quality of Life (Kualitas Hidup): Tingkat kesejahteraan individu yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

R

Reminiscence Therapy: Terapi psikososial yang melibatkan aktivitas mengingat pengalaman masa lalu sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan emosional lansia.

Rehospitalisasi: Masuk kembali ke rumah sakit setelah pasien sebelumnya dinyatakan pulang.

S

Spiritual Care: Pendekatan keperawatan yang memperhatikan kebutuhan spiritual pasien dalam mendukung proses penyembuhan dan kesejahteraan.

SOP (Standard Operating Procedure): Prosedur standar yang digunakan dalam menjalankan suatu tugas atau intervensi secara konsisten.

T

Team Climate Inventory (TCI): Alat ukur untuk menilai iklim kerja dan dinamika tim kolaboratif.

Transisi Perawatan: Perpindahan pasien dari satu tempat atau tingkat pelayanan ke tempat atau tingkat lainnya (misal: dari rumah sakit ke rumah).

U

Usia Lanjut: Individu yang berusia ≥ 60 tahun menurut standar WHO dan kebijakan nasional.

V

Validitas Bukti: Tingkat kebenaran dan kekuatan bukti ilmiah yang digunakan dalam praktik keperawatan berbasis EBP.

W

WHO (World Health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia yang memberikan pedoman dan rekomendasi global di bidang kesehatan.

CHAPTER 2

PROSES KEPERAWATAN GERONTIK

I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D.

A. Pendahuluan

Distribusi usia dalam suatu populasi berpengaruh signifikan terhadap beban penyakit dan tingkat kecacatan masyarakat. Seiring dengan peningkatan harapan hidup baik pada pria maupun wanita, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami peningkatan jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia. Dalam tiga dekade mendatang, jumlah lansia secara global diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat. Pendekatan penilaian terhadap lansia harus mempertimbangkan keterkaitan kompleks antara kondisi fisik, gangguan psikologis, serta tantangan sosial dan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di rumah. Penilaian ini mencakup integrasi antara aspek medis dan sosial, serta menekankan pentingnya diagnosis yang komprehensif dan pengambilan keputusan yang tepat, yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, seperti perawat dan dokter, khususnya mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang Gerontik.

Di Indonesia, populasi lansia telah meningkat secara signifikan dalam lima dekade terakhir. Pada tahun 2024, jumlah lansia mencapai sekitar 12% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024). Pertumbuhan ini menciptakan tantangan serius bagi sistem kesehatan nasional, yang menuntut peningkatan kapasitas layanan keperawatan sebagai bagian integral dari penyediaan layanan kesehatan berkualitas bagi kelompok usia lanjut. Layanan ini harus diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh dengan melibatkan pasien dan keluarga (Suyasa & Sutini, 2021). Dalam konteks ini, pendekatan keperawatan yang terstruktur dengan menerapkan praktik berbasis bukti menjadi sangat penting untuk menghadapi meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan lansia. Proses keperawatan merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan kesehatan individu lanjut usia. Proses ini terdiri dari lima tahap utama: pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi (ADPIE). Tahap pengkajian melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap status kesehatan fisik, kapasitas fungsional, fungsi kognitif, kesejahteraan psikososial, serta aspek lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Untuk mendukung pengkajian yang komprehensif, alat

seperti Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) digunakan guna mengumpulkan data yang holistik dan akurat, sebagai dasar dalam menyusun intervensi keperawatan yang tepat sasaran (Fidecki et al., 2025). Tahap diagnosis keperawatan berfokus pada identifikasi sindrom geriatri yang umum terjadi, termasuk risiko jatuh, kelemahan otot, inkontinensia, dan gangguan kognitif. Berdasarkan temuan tersebut, rencana keperawatan dirancang dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup melalui pendekatan person-centered care. Pada tahap implementasi, intervensi yang telah dirancang diterapkan secara individual, mencakup koordinasi layanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengelolaan obat, serta kerja sama dengan tim interprofesional. Pengkajian untuk praktik berkualitas tinggi harus komprehensif, multidimensional, interdisipliner, dan terencana (Ferretti-Rebustini et al., 2022). Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian dalam rencana perawatan (Wagner et al., 2023). Evaluasi ini mendukung proses perbaikan berkelanjutan demi hasil kesehatan yang optimal bagi lansia.

Asuhan keperawatan gerontik menuntut penguasaan keterampilan berpikir kritis, penalaran klinis, serta kemampuan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktik. Penalaran analitis dan sintesis menjadi kunci dalam menyusun diagnosis yang akurat berdasarkan data klinis dan anamnesis. Penggunaan bahasa standar keperawatan, seperti taksonomi NANDA-I, sangat diperlukan dalam proses ini untuk memastikan ketepatan diagnosis serta mendukung penyusunan rencana asuhan keperawatan yang bersifat personal dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia (Reis da Silva, 2024). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi keperawatan gerontik di kalangan tenaga keperawatan klinis dinilai pada tingkat menengah bawah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga dibutuhkan pelatihan klinis lebih lanjut dalam keperawatan gerontik bagi tenaga keperawatan klinis. Pendidikan keperawatan gerontik harus berfokus pada sikap serta keterampilan klinis yang diperlukan dan mempersiapkan perawat untuk mengelola sindrom geriatri komprehensif dengan baik (Long et al., 2024; Suyasa et al., 2025).

B. Langkah-Langkah Proses Keperawatan Gerontik

Proses keperawatan adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan oleh perawat untuk memberikan asuhan yang terstruktur, menyeluruh, dan efektif. Proses keperawatan gerontik membutuhkan penyesuaian agar relevan dengan kondisi fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang khas pada populasi lansia. Pendekatan

ini tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga berfokus pada pemeliharaan kualitas hidup dan kemandirian lansia.

Lima langkah utama dalam proses keperawatan gerontik yang diaplikasikan secara spesifik pada populasi lansia meliputi:

1. Pengkajian (Assessment)

Pengumpulan data komprehensif pada lanjut usia (Comprehensive Geriatric Assessment) dengan pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual yang berfokus pada perubahan akibat proses penuaan. Pengkajian pada Keperawatan Gerontik merupakan fase awal proses keperawatan. Pengkajian memainkan peran yang sangat penting. Hal ini melibatkan pengumpulan data komprehensif tentang kondisi kesehatan lansia, kemampuan fungsional, fungsi kognitif, kesejahteraan psikososial, dan faktor lingkungan. Mengingat kompleksitas penuaan, perawat perlu menggunakan alat bantu pengkajian yang valid dan spesifik untuk populasi lansia, seperti *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)*, *MMSE*, *GDS*, *Barthel Index*, *Timed Up and Go Test*, *MNA*, *SPICES*, *Katz Index*, *Lawton Scale*, *MMSE*, *MNA*, *Morse Fall Scale*, dan lain-lain untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan individu (Toney-Butler & Thayer, 2025).

Tujuan: Menyediakan gambaran holistik untuk mengumpulkan data secara menyeluruh tentang kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan fungsional lansia sehingga dapat menentukan intervensi yang tepat.

Rangkaian kompetensi dan keterampilan yang komprehensif dan esensial bagi perawat dalam melakukan penilaian geriatri komprehensif dapat dilakukan dengan pendekatan enam domain yang berbeda yang mencakup area kompetensi kritis, antara lain: a. penilaian klinis dan diagnostik, b. perencanaan dan koordinasi perawatan, c. profesional dan kompetensi interpersonal, d. lingkungan dan kompetensi sistemik, e. kompetensi teknis dan kompetensi prosedural, serta f. peningkatan kualitas dan praktik berbasis bukti yang berpusat pada pasien lansia (Gambar 1).

a. Kompetensi penilaian klinis dan diagnostik

Penilaian Klinis dan Kompetensi Diagnostik merupakan landasan penting dalam perawatan lansia yang efektif. Pelaksanaan penilaian kesehatan komprehensif secara konsisten ditekankan dalam literatur sebagai kompetensi kritis bagi perawat perawatan primer. Penilaian ini mencakup berbagai evaluasi, termasuk penilaian frailty, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik yang sesuai. Selain itu, pentingnya melakukan penilaian gizi dan kognitif, serta evaluasi mood dan psikologis, juga ditekankan. Perawat diharapkan dapat mengelola skenario klinis kompleks,

seperti manajemen nyeri dan manajemen penyakit kronis, yang sering ditemui pada populasi lansia. Selain itu, peran perawat dalam penilaian khusus, seperti tinjauan obat, pengelolaan delirium, dan identifikasi defisit kognitif atau fisik, sangat kritis untuk memastikan perawatan yang komprehensif. Kompetensi lanjutan, termasuk pemantauan gaya berjalan, keseimbangan, dan kelelahan, serta merangkum temuan klinis menjadi daftar masalah yang dapat ditindaklanjuti.

b. Perencanaan dan koordinasi perawatan

Komponen kunci dalam praktik keperawatan gerontik adalah pembuatan dan pengelolaan rencana perawatan yang disesuaikan secara individual. Penelitian menunjukkan bahwa perawat harus terlibat dalam pembuatan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Proses ini ditandai dengan keterlibatan aktif pasien dalam pengambilan keputusan bersama, yang tidak hanya menghormati otonomi pasien tetapi juga meningkatkan hasil kesehatan yang lebih baik. Menjaga relevansi dan efektivitas rencana perawatan memerlukan tinjauan dan revisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasien yang terus berkembang. Selain itu, tanggung jawab perawat melampaui pemberian perawatan klinis untuk mencakup pemberdayaan pasien dalam mengendalikan kesehatan mereka sendiri. Selain itu, literatur menekankan pentingnya perencanaan perawatan akhir hayat dan pertimbangan kebutuhan budaya, spiritual, dan emosional dalam proses perawatan. Perencanaan perawatan komprehensif juga mencakup perencanaan perawatan dini (ACP) dan perawatan paliatif. ACP memungkinkan diskusi proaktif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan mengenai keputusan perawatan di masa depan, memastikan bahwa perawatan sesuai dengan nilai dan preferensi individu. Selain itu, perawatan paliatif berperan penting dalam mengelola gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan dukungan psikososial kepada pasien dengan kondisi kronis atau membatasi, terlepas dari prognosis. Karakter multidimensional dari perencanaan perawatan dalam keperawatan gerontik juga ditunjukkan oleh kompetensi yang terkait dengan penilaian lingkungan, pencegahan jatuh, dan pendidikan pasien tentang mobilitas aman.

c. Kompetensi profesional dan interpersonal

Pembelajaran seumur hidup dan pengembangan profesional ditekankan sebagai komponen kunci dari pengkajian geriatrik komprehensif. Keterampilan dan pengetahuan, seperti penuaan sehat, sindrom geriatrik dan masalah kesehatan paling umum di kalangan orang tua, merupakan landasan utama dari pengkajian geriatrik komprehensif. Kerja sama multiprofesional sangat

penting untuk penyampaian pengkajian geriatrik komprehensif yang efektif. Selain itu, kemampuan berkomunikasi secara efektif tidak hanya dengan profesional lain tetapi juga dengan orang tua dan anggota keluarga mereka merupakan bagian penting dari penilaian geriatrik. Membangun hubungan positif dengan lansia dan anggota keluarga mereka juga esensial untuk memberikan perawatan yang menghormati dan responsif terhadap kebutuhan beragam lansia. Dalam pengkajian geriatrik komprehensif, keterampilan terkait budaya yang berbeda penting saat memberikan perawatan keperawatan gerontik kepada individu dari latar belakang yang berbeda.

d. Kompetensi lingkungan dan sistemik

Kompetensi dalam mengelola aspek lingkungan dan sistemik yang lebih luas dalam perawatan sangat penting bagi perawat perawatan primer. Membangun lingkungan kerja yang terbuka dan kooperatif sangat krusial untuk mendorong kolaborasi dan kerja tim, yang vital dalam penyediaan perawatan lansia yang komprehensif. Kolaborasi tim multidisiplin ditekankan sebagai kompetensi kunci, dengan perawat sering berperan sebagai penghubung utama dalam mengoordinasikan perawatan antar penyedia layanan kesehatan. Keterampilan kepemimpinan, termasuk pengelolaan tim perawatan dan advokasi untuk sumber daya dan tenaga kerja yang berkualitas, sangat penting untuk mempertahankan standar perawatan yang tinggi. Selain itu, kemampuan untuk mengelola perawatan secara mandiri dan berkontribusi pada pengembangan praktik dan kebijakan berbasis bukti memastikan bahwa perawat perawatan primer dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasien lansia yang terus berkembang sambil mempertahankan standar kualitas perawatan yang tinggi.

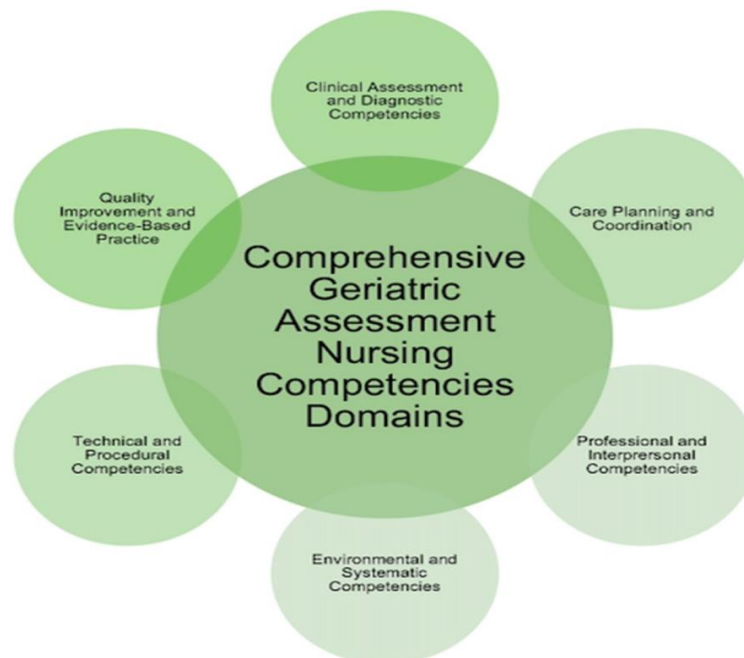
e. Kompetensi teknis dan kompetensi prosedural

Kompetensi teknis dan prosedural sangat penting dalam pemberian perawatan langsung pasien di lingkungan lansia. Tugas seperti memberikan suntikan dan memantau tanda-tanda vital merupakan aspek kunci dari peran mereka. Kompetensi teknis yang kritis meliputi penanganan tindakan medis, termasuk kateter urin dan ostomi; prosedur mobilisasi yang aman; dan pengelolaan masalah pernapasan. Evaluasi dan penanganan bahaya terkait jatuh memiliki arti penting dalam bidang perawatan lansia, karena menyoroti tanggung jawab perawat untuk memastikan keselamatan dan mencegah kecelakaan.

f. Peningkatan kualitas dan praktik berbasis bukti

Partisipasi dalam inisiatif peningkatan kualitas dan penerapan praktik berbasis bukti merupakan hal yang esensial untuk mengembangkan perawatan untuk

lansia. Literatur menekankan pentingnya praktik reflektif dan partisipasi dalam kegiatan penelitian untuk mengembangkan kompetensi klinis sendiri dan meningkatkan hasil perawatan pasien. Perawat didorong untuk menerapkan pedoman berbasis bukti dalam praktik mereka dan memantau serta mengevaluasi efektivitas intervensi untuk memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Praktik berbasis bukti meliputi bekerja sama dengan tim dari berbagai disiplin ilmu untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian dan praktik, serta menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang untuk lebih meningkatkan kualitas perawatan (Grove & Gray, 2018). Pengembangan profesional berkelanjutan, terutama di bidang yang berkaitan dengan praktik berbasis bukti, sangat penting untuk peningkatan berkelanjutan kompetensi keperawatan.



Gambar 2.1

**Domain Kompetensi Keperawatan dalam Penilaian Geriatri Komprehensif
(Dimitriadou et al., 2025)**

Komponen Pengkajian Asuhan Keperawatan Gerontik

a. Identitas Klien

- 1) Nama
- 2) Usia
- 3) Jenis kelamin
- 4) Status pernikahan
- 5) Pendidikan terakhir
- 6) Pekerjaan terakhir (pensiunan/aktif)

- 7) Sumber pembiayaan kesehatan (JKN/BPJS/mandiri)
- b. Riwayat Kesehatan
 - 1) Keluhan utama
 - 2) Riwayat penyakit sekarang
 - 3) Riwayat penyakit dahulu (hipertensi, diabetes, stroke, nyeri kronis, osteoarthritis, demensia, dll.)
 - 4) Riwayat penyakit keluarga
 - 5) Penggunaan obat rutin dan obat bebas
 - 6) Riwayat alergi (obat, makanan, lingkungan)
- c. Status Fungsional
 - 1) Aktivitas sehari-hari (ADL: mandi, berpakaian, makan, toileting, mobilisasi)
 - 2) Aktivitas instrumental (IADL: menggunakan telepon, berbelanja, memasak, mengelola uang, transportasi)
 - 3) Status mobilitas dan risiko jatuh (gunakan instrumen: Morse Fall Scale, Tinetti, dll.)
- d. Status Kognitif dan Mental
 - 1) Penilaian fungsi kognitif (Mini Mental State Examination/MMSE)
 - 2) Tanda-tanda demensia atau delirium
 - 3) Status psikologis: kecemasan, depresi, stres (gunakan Geriatric Depression Scale)
 - 4) Persepsi terhadap penyakit dan penuaan
- e. Status Nutrisi
 - 1) Berat badan, tinggi badan, IMT
 - 2) Perubahan berat badan akhir-akhir ini
 - 3) Pola makan dan nafsu makan
 - 4) Pemeriksaan laboratorium (Hb, albumin, kolesterol, gula darah)
 - 5) Penilaian malnutrisi (Mini Nutritional Assessment/MNA)
- f. Status Eliminasi
 - 1) Pola berkemih (inkontinensia, urgensi, frekuensi)
 - 2) Pola defekasi (sembelit, inkontinensia fekal)
- g. Status Tidur dan Istirahat
 - 1) Durasi dan kualitas tidur
 - 2) Gangguan tidur (insomnia, sering terbangun, sleep apnea)
- h. Status Sensori dan Persepsi
 - 1) Penglihatan (katarak, presbiopi, gangguan retina)
 - 2) Pendengaran (presbikusis)
 - 3) Nyeri (lokasi, intensitas, durasi, karakteristik, alat ukur: NRS, VDS)

- 4) Persepsi terhadap lingkungan sekitar
- i. Status Sosial dan Ekonomi
 - 1) Tinggal dengan siapa (mandiri, dengan anak, panti)
 - 2) Dukungan sosial (keluarga, tetangga, komunitas)
 - 3) Status ekonomi dan ketergantungan finansial
- j. Status Spiritual dan Budaya
 - 1) Keyakinan agama atau kepercayaan
 - 2) Praktik spiritual harian
 - 3) Makna hidup, harapan, dan kepasrahan
 - 4) Preferensi budaya dalam perawatan
- k. Riwayat Gaya Hidup dan Kebiasaan
 - 1) Aktivitas fisik (olahraga ringan, jalan kaki)
 - 2) Merokok, alkohol
 - 3) Hobi dan aktivitas sosial
- l. Lingkungan Tempat Tinggal
 - 1) Keamanan lingkungan rumah
 - 2) Akses terhadap fasilitas kesehatan
 - 3) Risiko jatuh di rumah (lantai licin, tangga, pencahayaan buruk)

2. Diagnosa Keperawatan (*Nursing Diagnosis*)

Identifikasi masalah keperawatan spesifik pada lansia berdasarkan hasil pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian, perawat merumuskan diagnosis keperawatan dan menyusun rencana perawatan yang disesuaikan untuk menangani masalah kesehatan dan kekhawatiran yang diidentifikasi pada lansia. Diagnosa disusun mengacu pada standar NANDA-I dan mencerminkan masalah aktual, risiko, maupun potensi peningkatan kesehatan. Diagnosis keperawatan dalam konteks ini dapat mencakup sindrom geriatri seperti jatuh, kelemahan, inkontinensia, dan gangguan kognitif. Rencana perawatan disesuaikan secara individual, bertujuan tidak hanya untuk mengelola kondisi akut tetapi juga untuk mempromosikan fungsi optimal dan meningkatkan kualitas hidup lansia (Toney-Butler & Thayer, 2025).

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan bertujuan menyusun intervensi keperawatan yang disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual lansia yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Dalam konteks gerontik, perencanaan harus:

- 1) Mempertimbangkan preferensi lansia.
- 2) Disusun secara kolaboratif dengan keluarga dan tim interdisipliner.
- 3) Berdasarkan *evidence-based practice*.

Contoh tujuan keperawatan:

- b. "Dalam 7 hari, klien mampu berjalan mandiri dengan alat bantu tanpa insiden jatuh."
- c. "Klien menunjukkan skor MMSE stabil dalam 1 bulan ke depan."

3. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, intervensi yang telah direncanakan dilakukan secara sistematis dan konsisten. Pelaksanaan intervensi keperawatan yang aman, empatik, dan sesuai kebutuhan unik lansia. Perawat harus:

- a. Mengedepankan prinsip keselamatan pasien lansia (*fall prevention, skin care, medication safety*).
- b. Memberdayakan lansia untuk berpartisipasi aktif dalam asuhan.
- c. Menyesuaikan intervensi dengan kemampuan fisik dan kognitif lansia.

Contoh intervensi:

- a. Latihan kekuatan dan keseimbangan untuk mencegah jatuh.
- b. Pelatihan bladder training untuk inkontinensia urin.
- c. Aktivitas stimulasi kognitif harian pada lansia dengan demensia ringan.

4. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi bertujuan menilai efektivitas asuhan yang telah diberikan dan menentukan apakah tujuan keperawatan tercapai.

Evaluasi dilakukan dengan meninjau:

- a. Perubahan status fisik, fungsional, dan psikologis.
- b. Persepsi lansia terhadap perawatan.
- c. Data objektif (nilai skala penilaian, indikator hasil kesehatan).

Jika tujuan belum tercapai, dilakukan modifikasi rencana asuhan atau rujukan ke layanan yang lebih spesifik.

5. Kesimpulan

Proses keperawatan gerontik menekankan pendekatan yang komprehensif, individualistik, dan berbasis bukti tidak hanya fokus pada penyakit, tetapi juga pada fungsi, kemandirian, kenyamanan, dan martabat. Pendekatan harus bersifat holistik, sabar, dan berorientasi pada kualitas hidup. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kompleksitas kondisi lansia, termasuk komorbiditas, perubahan fisiologis, dan peran keluarga. Dengan menerapkan proses ini secara konsisten, perawat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

C. Teknik Pengkajian Lansia Secara Komprehensif (Fisik, Mental, Sosial)

Pengkajian komprehensif pada lansia merupakan fondasi utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif, aman, dan berpusat pada pasien.

Lansia memiliki kebutuhan yang kompleks akibat perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pengkajian tidak cukup hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek mental dan sosial yang saling berkaitan erat dalam mempengaruhi kualitas hidup lansia.

Pengkajian komprehensif pada lansia mencakup berbagai dimensi:

1. Pengkajian Fisik

Pengkajian fisik pada lansia memerlukan pendekatan yang hati-hati, terstruktur, dan sensitif terhadap perubahan akibat proses penuaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, risiko, dan potensi perawatan mandiri.

a. Komponen Pengkajian Fisik:

- 1) Tanda vital: Perubahan suhu tubuh, tekanan darah postural, denyut nadi tidak teratur.
- 2) Status nutrisi: Penurunan berat badan, massa otot, dan asupan makanan.
- 3) Sistem kardiovaskular: Bunyi jantung, edema, perfusi perifer.
- 4) Sistem pernapasan: Bunyi napas, pola napas, kapasitas paru.
- 5) Sistem muskuloskeletal: Kekuatan otot, mobilitas, risiko jatuh.
- 6) Sistem integumen: Kelembaban kulit, turgor, risiko luka tekan.
- 7) Sistem sensorik: Penurunan penglihatan dan pendengaran.
- 8) Sistem genitourinaria: Inkontinensia, frekuensi miksi.
- 9) Sistem gastrointestinal: Pola defekasi, nafsu makan.
- 10) Fungsi sensorimotorik: Koordinasi gerak, refleks.

b. Alat Bantu Pengkajian Fisik:

- 1) Mini Nutritional Assessment (MNA)
- 2) Timed Up and Go (TUG) Test
- 3) Body Mass Index (BMI)
- 4) Skin Assessment Tools (Braden Scale)

2. Pengkajian Mental dan Kognitif

Penurunan fungsi kognitif dan kesehatan mental sering terjadi pada lansia, dan dapat berdampak besar terhadap kemampuan merawat diri serta kualitas hidup.

a. Aspek yang Dikaji:

- 1) Kognitif: Orientasi, memori jangka pendek/panjang, perhatian, fungsi eksekutif.
- 2) Emosional: Tingkat stres, kecemasan, kesepian, keputusan.
- 3) Psikiatri: Depresi, delirium, demensia, gangguan tidur.

b. Alat Ukur yang Direkomendasikan:

- 1) Mini Mental State Examination (MMSE): Untuk skrining gangguan kognitif.

- 2) Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Alternatif MMSE dengan sensitivitas tinggi.
 - 3) Geriatric Depression Scale (GDS): Untuk deteksi dini depresi.
 - 4) Confusion Assessment Method (CAM): Untuk identifikasi delirium akut.
- c. Prinsip Pengkajian Mental:
- 1) Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
 - 2) Hindari waktu pengkajian saat lansia dalam kelelahan atau bingung.
 - 3) Libatkan keluarga untuk konfirmasi perubahan perilaku atau fungsi mental.

3. Pengkajian Sosial

Kesehatan sosial lansia berkaitan erat dengan kualitas hidup, kemandirian, dan status fungsional mereka. Dukungan sosial yang memadai dapat mengurangi risiko isolasi sosial, depresi, dan penurunan fungsi kognitif.

a. Aspek yang Dikaji:

- 1) Dukungan keluarga: Apakah lansia tinggal bersama keluarga? Siapa yang menjadi caregiver utama?
- 2) Relasi sosial: Frekuensi komunikasi dengan teman, tetangga, atau komunitas.
- 3) Peran sosial: Apakah lansia masih terlibat dalam aktivitas masyarakat, keagamaan, atau organisasi?
- 4) Keamanan sosial: Akses terhadap layanan kesehatan, transportasi, dan bantuan sosial.

b. Alat Ukur yang Disarankan:

- 1) Lubben Social Network Scale (LSNS): Mengukur ukuran dan kekuatan jejaring sosial lansia.
- 2) Duke Social Support Index (DSSI): Mengukur frekuensi dan persepsi terhadap dukungan sosial.
- 3) Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL) dan Lawton IADL Scale: Untuk menilai kemampuan menjalani kehidupan sosial mandiri.

4. Pendekatan Interpersonal dalam Pengkajian

Pendekatan pengkajian harus komunikatif, empatik, dan melibatkan keluarga, serta mempertimbangkan faktor usia, gangguan pendengaran, dan keterbatasan fisik.

- a. Empati dan kehangatan: Membangun hubungan terapeutik yang saling percaya.
- b. Komunikasi efektif: Gunakan suara jelas, waktu cukup, dan kontak mata.
- c. Lingkungan nyaman: Minimalkan gangguan dan pastikan privasi.
- d. Keterlibatan keluarga: Sangat penting dalam validasi informasi dan pengambilan keputusan.

5. Integrasi Data dan Dokumentasi

Data hasil pengkajian fisik, mental, dan sosial harus didokumentasikan secara sistematis dan dijadikan dasar untuk menyusun diagnosa keperawatan dan rencana intervensi yang terintegrasi. Penggunaan format pengkajian gerontik terpadu sangat direkomendasikan agar hasil lebih komprehensif dan mudah ditindaklanjuti.

6. Kesimpulan

Pengkajian komprehensif pada lansia adalah proses dinamis yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan personal. Dengan menggunakan alat bantu terstandar dan pendekatan berbasis EBP, perawat dapat mengidentifikasi masalah secara dini dan merancang intervensi yang tepat. Keberhasilan pengkajian ini sangat bergantung pada sensitivitas perawat terhadap kebutuhan unik lansia, komunikasi efektif, dan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan.

D. Penyusunan Diagnosa Keperawatan pada Lansia

Diagnosa keperawatan merupakan langkah kritis dalam proses keperawatan yang berfungsi sebagai dasar perencanaan intervensi. Pada lansia, penyusunan diagnosa keperawatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang khas terjadi pada proses penuaan. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kemampuan klinis, analitis, dan empatik yang tinggi dalam menyusun diagnosa yang tepat, bermakna, dan relevan. Diagnosa harus mengacu pada NANDA-I dan disusun secara individual sesuai konteks lansia dan prioritas perawatan.

1. Prinsip Diagnosa Keperawatan pada Lansia

Beberapa prinsip penting dalam penyusunan diagnosa keperawatan pada lansia meliputi:

- Holistik dan individualistik: Diagnosa harus mencerminkan kondisi lansia secara menyeluruh, bukan hanya gejala penyakit.
- Berbasis data objektif dan subjektif: Didasarkan pada hasil pengkajian fisik, kognitif, emosional, fungsional, dan sosial.
- Berorientasi pada respons pasien: Fokus pada respons lansia terhadap masalah kesehatan, bukan diagnosis medis semata.
- Berprioritas: Diagnosa disusun berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap kualitas hidup, dan potensi komplikasi.

2. Format Diagnosa Keperawatan

Format standar yang digunakan dalam menyusun diagnosa keperawatan mengacu pada rumusan NANDA-I, yang terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Label Diagnosa (Problem): Menggambarkan kondisi atau respons yang dialami pasien (misalnya: gangguan mobilitas fisik).
- b. Etiologi (Related to/R/T): Faktor penyebab atau berkontribusi (misalnya: kelemahan otot).
- c. Gejala/Tanda (As Evidenced by/AEB): Bukti pendukung dari data subjektif maupun objektif (misalnya: pasien tampak lemah, tidak mampu berjalan tanpa bantuan).

Contoh:

Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot ekstremitas bawah ditandai dengan ketidakmampuan berjalan tanpa alat bantu dan keluhan cepat lelah saat bergerak.

3. Jenis-Jenis Diagnosa Keperawatan pada Lansia

Diagnosa keperawatan pada lansia dapat dibagi ke dalam beberapa kategori:

- a. Diagnosa Aktual: Masalah yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan dengan tanda dan gejala.
Contoh: Gangguan tidur berhubungan dengan nyeri kronis ditandai dengan kesulitan tidur dan tampak lelah di pagi hari.
- b. Diagnosa Risiko: Masalah potensial yang belum terjadi tetapi memiliki risiko tinggi.
Contoh: Risiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan dan penurunan penglihatan.
- c. Diagnosa Kesejahteraan (Health Promotion): Fokus pada peningkatan status kesehatan dan kualitas hidup.
Contoh: Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan motivasi pasien untuk meningkatkan aktivitas fisik.
- d. Diagnosa Kolaboratif (Collaborative Problems): Masalah yang memerlukan intervensi kolaboratif dengan tim kesehatan lain.
Contoh: Risiko komplikasi akibat hipertensi atau diabetes.

4. Contoh Diagnosa Keperawatan Umum pada Lansia

Berikut ini beberapa contoh diagnosa keperawatan yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan gerontik:

Tabel 2.1
Diagnosa Keperawatan

Masalah	Etiologi	Tanda/Gejala
Gangguan mobilitas fisik	Penurunan kekuatan otot	Kesulitan berjalan, memerlukan alat bantu
Risiko jatuh	Riwayat jatuh sebelumnya, gangguan penglihatan	Lingkungan rumah tidak aman

Masalah	Etiologi	Tanda/Gejala
Gangguan pola tidur	Nyeri kronis, kecemasan	Sulit tidur, sering terbangun
Isolasi sosial	Kehilangan pasangan, keterbatasan mobilitas	Menarik diri, enggan berbicara
Ketidakefektifan manajemen kesehatan	Penurunan kognitif	Lupa minum obat, tidak memahami edukasi
Inkontinensia urin	Penurunan kontrol sfingter, demensia	Mengompol, frekuensi berkemih meningkat
Risiko gangguan integritas kulit	Imobilitas, inkontinensia	Kulit lembap, area kemerahan
Keputusasaan	Penyakit terminal, kehilangan orang terdekat	Perasaan tidak berguna, menangis

5. Strategi Menyusun Diagnosa Secara Efektif

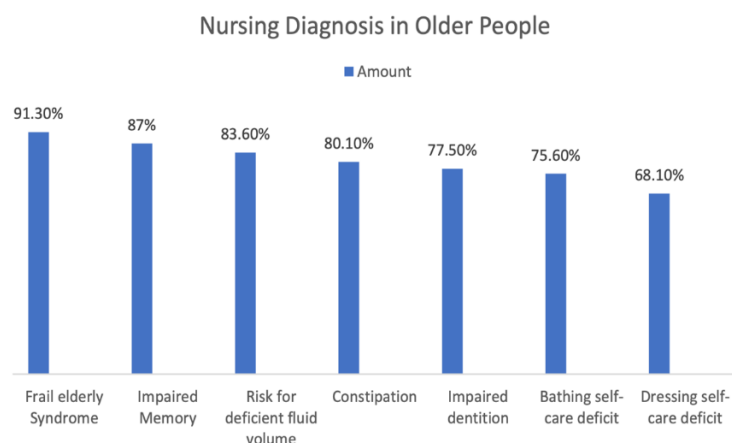
- Gunakan format standar NANDA-I.
- Prioritaskan berdasarkan kebutuhan fisiologis, keamanan, dan psikososial.
- Gunakan pendekatan tim (kolaborasi dengan keluarga dan tim medis).
- Validasi dengan pasien dan/atau keluarga untuk memastikan kesesuaian.

6. Peran Evidence-Based Practice dalam Penyusunan Diagnosa

Pendekatan berbasis bukti (EBP) mendukung perawat dalam:

- Memilih diagnosa yang paling relevan dan efektif.
- Menghindari overdiagnosis atau bias subjektif.
- Meningkatkan akurasi identifikasi masalah dan pengambilan keputusan klinis.
- Menyesuaikan dengan pedoman keperawatan gerontik terkini.

Grafik 1. Menunjukkan diagnosa keperawatan umum yang ditemukan pada lanjut usia berdasarkan hasil penelitian (Tiago, 2024).



Gambar 2.2
Diagnosa Keperawatan yang Paling Umum pada Lanjut Usia

Diagnosis keperawatan yang umum ditemukan, antara lain:

- a. Sindrom lansia rapuh (91,3%)
- b. Gangguan memori (87%)
- c. Risiko volume cairan tidak memadai (83,6%)
- d. Konstipasi (80,1%)
- e. Gangguan gigi (77,5%)
- f. Gangguan perawatan diri mandi (75,6%)
- g. Gangguan perawatan diri berpakaian (77,5%)
- h. Defisit perawatan diri mandi (75,6%)
- i. Defisit perawatan diri berpakaian (68,1%)

7. Kesimpulan

Penyusunan diagnosa keperawatan yang tepat pada lansia merupakan langkah penting untuk memberikan asuhan yang holistik, efektif, dan aman. Diagnosa perlu mencerminkan prioritas, tingkat urgensi, dan nilai-nilai lansia. Diagnosa ini menjadi dasar dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan unik lansia dan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Oleh karena itu, perawat harus terampil dalam menganalisis data pengkajian dan menyusunnya menjadi diagnosa keperawatan yang bermakna dan berorientasi pada kualitas hidup lansia.

E. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan Lansia Berbasis Bukti

Perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan pada lansia merupakan inti dari praktik profesional keperawatan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks keperawatan gerontik, pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan kerentanan lansia dan dilandasi oleh praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP), yakni integrasi antara bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, serta preferensi dan nilai-nilai pasien.

1. Prinsip Perencanaan Asuhan Keperawatan Lansia

Perencanaan keperawatan melibatkan penyusunan tujuan keperawatan dan pemilihan intervensi yang sesuai berdasarkan hasil pengkajian dan diagnosa keperawatan. Intervensi dapat berupa keperawatan mandiri, kolaboratif, atau edukatif. Prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. SMART: Tujuan harus *Specific, Measurable, Achievable, Realistic*, dan *Time-bound*.
- b. Berbasis evidence: Mengacu pada pedoman klinis, penelitian terkini, dan intervensi yang terbukti efektif.
- c. Kolaboratif dan partisipatif: Melibatkan lansia, keluarga, dan tim kesehatan interdisipliner.

- d. Bersifat individual dan realistis: Menyesuaikan dengan kondisi fisik, kognitif, dan psikososial lansia.

Contoh Tujuan Keperawatan SMART:

- a. "Dalam 3 hari, lansia mampu mengonsumsi minimal 1.500 ml cairan/hari secara mandiri."
- b. "Dalam 7 hari, lansia menunjukkan peningkatan mobilitas dengan berjalan menggunakan tongkat sejauh 10 meter tanpa bantuan."

Contoh intervensi EBP:

- a. Untuk risiko jatuh: Intervensi multifaktorial berbasis NICE guidelines seperti pelatihan keseimbangan dan kekuatan otot, penyesuaian lingkungan.
- b. Untuk demensia ringan: Cognitive stimulation therapy (CST) berbasis NICE 2018.
- c. Untuk inkontinensia urin: Bladder training dan pelatihan otot dasar panggul berbasis Cochrane review.

2. Implementasi Intervensi Keperawatan Lansia

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disusun. Pelaksanaannya harus memperhatikan:

- a. Kondisi klinis dan kapasitas lansia
- b. Preferensi individu lansia
- c. Lingkungan dan dukungan keluarga
- d. Ketersediaan sumber daya

3. Contoh Intervensi Keperawatan Lansia Berbasis Bukti

- a. Risiko Jatuh

EBP: Multifactorial fall prevention program (NICE Guidelines, CDC STEADI Toolkit)

Intervensi:

- 1) Latihan keseimbangan dan kekuatan otot (otot tungkai dan pinggul)
- 2) Pemeriksaan ulang obat-obatan yang menyebabkan hipotensi ortostatik
- 3) Modifikasi lingkungan rumah (lampu terang, tidak ada karpet lepas)
- 4) Edukasi keluarga tentang pencegahan jatuh

- b. Inkontinensia Urin

EBP: *Bladder training* dan *pelvic floor muscle training* (Cochrane Review)

Intervensi:

- 1) Latihan otot dasar panggul 3–4 kali/hari
- 2) Jadwal berkemih teratur setiap 2–3 jam
- 3) Hindari konsumsi kafein atau cairan berlebih di malam hari

- c. Gangguan Mobilitas

EBP: *Progressive resistance exercise* untuk peningkatan kekuatan otot (JAGS)

Intervensi:

- 1) Latihan ringan bertahap, seperti berjalan di koridor atau senam kursi
- 2) Fisioterapi bila diperlukan
- 3) Pemberian alat bantu jalan dan pelatihan penggunaannya

d. Demensia Ringan

EBP: *Cognitive Stimulation Therapy (CST) (NICE, WHO)*

Intervensi:

- 1) Aktivitas stimulasi memori: permainan kata, teka-teki, membaca
- 2) Jadwal harian yang konsisten untuk menghindari disorientasi
- 3) Pemberdayaan keluarga dalam komunikasi yang ramah demensia

e. Depresi pada Lansia

EBP: *Behavioral Activation Therapy*, intervensi sosial, dan terapi kelompok

Intervensi:

- 1) Mendorong keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna
- 2) Terapi kelompok atau komunitas lansia
- 3) Rujukan ke psikolog jika perlu

f. Hasil penelitian dengan judul "*Effect of a comprehensive geriatric assessment nursing intervention model on older patients with diabetes and hypertension*" menyimpulkan bahwa *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)* sebagai intervensi keperawatan secara signifikan meningkatkan pengendalian glikemik, pengelolaan tekanan darah, dan kualitas hidup pada pasien lanjut usia yang dirawat di rumah sakit dengan diabetes dan hipertensi, dibandingkan dengan perawatan rutin. Peningkatan kepatuhan pengobatan yang diamati pada kelompok CGA menunjukkan bahwa model ini berpotensi meningkatkan standar perawatan untuk pasien lansia. Oleh karena itu, CGA seharusnya dipertimbangkan untuk implementasi yang lebih luas pada populasi pasien serupa guna lebih mengoptimalkan hasil Kesehatan (Bao et al., 2024).

g. Hasil penelitian dengan judul "*Comprehensive geriatric assessment in clinical nursing practice*" mengungkapkan bahwa penilaian geriatri komprehensif adalah proses diagnostik multidimensi yang berfokus pada penentuan profil klinis, risiko penyakit, diagnosis jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana terapeutik dan perawatan yang disesuaikan secara pribadi untuk lansia. Efektivitas program penilaian geriatri dapat bergantung pada lingkungan di mana program tersebut dilaksanakan (rumah sakit, panti jompo, lingkungan rumah), serta kondisi klinis spesifik lansia. Penilaian Geriatri Komprehensif (CGA) dianggap sebagai model optimal untuk penilaian medis dan perencanaan perawatan bagi lansia, dan harus dilakukan pada setiap

pasien lansia. Kompleksitas penilaian ini berarti bahkan seorang lansia tidak dapat melakukannya sendiri dan memerlukan upaya tim interdisipliner. Inti dari tim ini harus terdiri dari dokter penanggung jawab, perawat yang terlatih untuk bekerja dengan pasien lansia, fisioterapis, terapis okupasi, atau psikolog. Seluruh tim harus berkolaborasi dengan departemen kesejahteraan sosial. Setiap anggota menilai pasien menggunakan metode khusus yang sesuai dengan profesinya. Partisipasi keluarga pasien juga sangat penting dalam penilaian (Fidecki et al., 2025).

4. Strategi Penerapan EBP dalam Intervensi Keperawatan

Agar intervensi berbasis bukti dapat dilaksanakan secara optimal, dibutuhkan strategi berikut:

- a. Kaji literatur terbaru dari jurnal-jurnal keperawatan gerontik dan organisasi seperti WHO, NICE, atau Cochrane.
- b. Gunakan *Clinical Practice Guideline* (CPG) atau pathway keperawatan lansia.
- c. Libatkan tim multidisipliner (dokter, fisioterapis, gizi, psikolog).
- d. Libatkan keluarga dalam intervensi keperawatan
- e. Lakukan edukasi berkelanjutan kepada perawat mengenai praktik EBP.
- f. Evaluasi efektivitas intervensi secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan.

5. Kolaborasi dalam Implementasi Asuhan

Lansia sering kali memiliki masalah kesehatan yang kompleks dan tumpang tindih, sehingga implementasi intervensi keperawatan membutuhkan koordinasi lintas profesi dan lintas sektor:

- a. Kolaborasi internal: Dengan dokter, apoteker, ahli gizi, fisioterapis.
- b. Kolaborasi eksternal: Dengan keluarga, caregiver, komunitas lansia, LSM, dan layanan home care.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan kesinambungan asuhan dan mencegah rawat inap berulang atau komplikasi yang dapat dicegah.

6. Kesimpulan

Perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan gerontik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lansia, kebutuhan individual mereka, dan bukti ilmiah terkini. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip EBP ke dalam praktik sehari-hari, perawat dapat memberikan intervensi yang lebih efektif, aman, dan berdampak positif terhadap kualitas hidup lansia. Keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada kolaborasi lintas disiplin dan keterlibatan aktif lansia serta keluarganya dalam proses perawatan.

F. Evaluasi Efektivitas Asuhan Keperawatan Gerontik

Evaluasi adalah tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan menilai pencapaian tujuan asuhan serta efektivitas intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Dalam keperawatan gerontik, evaluasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan benar-benar meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan fungsi, serta mengurangi risiko komplikasi atau ketergantungan lebih lanjut pada lansia.

1. Tujuan Evaluasi dalam Asuhan Keperawatan Gerontik

- a. Mengukur hasil dari intervensi keperawatan.
- b. Menilai kemajuan terhadap tujuan keperawatan yang telah direncanakan.
- c. Mengidentifikasi hambatan terhadap pencapaian tujuan.
- d. Menentukan kebutuhan modifikasi rencana asuhan.
- e. Meningkatkan kontinuitas perawatan dan kolaborasi lintas tim.

Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pada akhir masa perawatan, tetapi juga selama pelaksanaan intervensi berlangsung.

2. Komponen Evaluasi Efektivitas Asuhan Keperawatan Gerontik

Evaluasi dalam keperawatan gerontik dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

a. Evaluasi Objektif

Evaluasi objektif dinilai berdasarkan indikator klinis, seperti tanda vital, status nutrisi, mobilitas, integritas kulit, hasil laboratorium, dan skor fungsional.

Contoh:

- 1) Skor *Timed Up and Go Test* berkurang dari 20 detik menjadi 12 detik.
- 2) Luka tekan stadium II menunjukkan penyembuhan dalam 10 hari.

b. Evaluasi Subjektif

Evaluasi subjektif dinilai berdasarkan persepsi dan pengalaman lansia serta keluarga terhadap kondisi, kenyamanan, dan kepuasan atas pelayanan.

Contoh:

- 1) Lansia melaporkan peningkatan kualitas tidur.
- 2) Keluarga menyatakan lebih mampu menangani inkontinensia pasien.

c. Evaluasi Fungsional dan Sosial

Evaluasi fungsional dan sosial bertujuan untuk menilai perubahan dalam kemampuan menjalani ADL/IADL (aktivitas harian), tingkat keterlibatan sosial, dan kemandirian (Suyasa et al., 2023).

Alat yang digunakan:

- 1) Katz Index of Independence in ADL
- 2) Lawton IADL Scale

3) Quality of Life (QoL) Scale for Older People

3. Indikator Keberhasilan Asuhan Keperawatan Gerontik

Keberhasilan asuhan keperawatan tidak selalu ditandai dengan penyembuhan total, tetapi dapat dilihat dari:

Tabel 2.2
Indikator Keberhasilan Asuhan Keperawatan Gerontik

Kategori	Indikator Keberhasilan
Klinis	Stabilnya tanda vital, peningkatan status gizi, penurunan nyeri, perbaikan luka
Fungsional	Peningkatan mobilitas, peningkatan kemampuan ADL, pengurangan risiko jatuh
Psikologis	Penurunan gejala depresi, peningkatan afek positif, peningkatan minat beraktivitas sosial
Sosial	Meningkatnya dukungan keluarga, keterlibatan dalam komunitas, penurunan isolasi sosial
Kepuasan pasien dan keluarga	Kepuasan terhadap intervensi, komunikasi, dan kolaborasi perawat dengan keluarga

4. Proses Evaluasi: Langkah-langkah Praktis

- Bandingkan hasil aktual dengan tujuan keperawatan.
- Identifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian.
- Dokumentasikan hasil secara akurat dan lengkap.
- Tentukan status tujuan:
 - Tercapai
 - Sebagian tercapai
 - Belum tercapai
- Lakukan modifikasi rencana keperawatan bila diperlukan.
- Komunikasikan hasil evaluasi kepada tim kesehatan dan keluarga.

5. Evaluasi Asuhan Keperawatan Gerontik Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Evaluasi dalam konteks EBP mengharuskan:

- Menggunakan instrumen yang tervalidasi dan diakui secara internasional.
- Mengacu pada standar kualitas layanan geriatri, seperti dari WHO, NICE, atau Kementerian Kesehatan.
- Berdasarkan hasil penelitian terkini mengenai intervensi yang paling efektif untuk lansia.

Contoh EBP:

Jika intervensi pelatihan keseimbangan digunakan untuk mencegah jatuh, maka evaluasinya dapat menggunakan *Berg Balance Scale* atau *Fall Efficacy Scale* untuk menilai efektivitasnya secara kuantitatif.

6. Dokumentasi Evaluasi Asuhan Keperawatan Gerontik

Dokumentasi hasil evaluasi sangat penting untuk:

- a. Melacak perkembangan kondisi lansia.
- b. Memberikan informasi kepada shift selanjutnya.
- c. Menjamin akuntabilitas perawat.
- d. Mendukung komunikasi interprofesional dan tindak lanjut layanan.
- e. Dokumentasi harus bersifat objektif, sistematis, dan mudah ditinjau ulang.

7. Kesimpulan

Evaluasi efektivitas asuhan keperawatan gerontik merupakan proses integral yang memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar berdampak positif terhadap kehidupan lansia. Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti, indikator yang terukur, dan keterlibatan aktif pasien serta keluarga, perawat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan fungsi optimal lansia. Evaluasi yang baik adalah dasar bagi pengambilan keputusan klinis yang tepat dan perawatan yang berkelanjutan.

G. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bao, D.-Y., Wu, L.-Y., & Cheng, Q.-Y. (2024). Effect of a comprehensive geriatric assessment nursing intervention model on older patients with diabetes and hypertension. *World Journal of Clinical Cases*, 12(20), 4065. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v12.i20.4065>
- Dimitriadou, I., Sini, E., Šteinmiller, J., Saridi, M., Lundberg, A., Häger, M., Hjaltadottir, I., Skuladottir, S. S., Korsström, N., & Mört, S. (2025). Comprehensive geriatric health assessment core competencies and skills for primary care nurses: a scoping review. *Geriatrics*, 10(2), 48.
- Ferretti-Rebustini, R. E. d. L., Souza-Talarico, J. N. d., Fhon, J. R. S., & Greenberg, S. A. (2022). The role of assessment in competence-based gerontological advanced practice nursing. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 56, e20220072. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0072en>
- Fidecki, W., Ślusarz, R., Sienkiewicz, Z., Kuszplak, K., & Wysokiński, M. (2025). Comprehensive geriatric assessment in clinical nursing practice. *Annals of Agricultural & Environmental Medicine*, 32(2). <https://doi.org/10.26444/aaem/204161>
- Grove, S. K., & Gray, J. R. (2018). *Understanding nursing research e-book: Building an evidence-based practice*. Elsevier health sciences.

- Long, J., Li, Y., Chen, W., Wu, X., Fu, R., Dong, L., Huang, Y., Yi, D., Xu, Z., & Cheng, Y. (2024). Geriatric nursing competence of clinical nursing staff at different hospital levels in Chongqing, China: A cross-sectional study. *International Journal of Nursing Sciences*, 11(4), 439-446. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2024.08.003>
- Reis da Silva, T. (2024). The Nursing Process in Geriatric Care: A Comprehensive Approach. *International Journal of Biomedical Research*, 3(5). <https://doi.org/10.31579/2834-5029/064>
- Suyasa, I., Sutini, N. K., Kamaryati, N. P., & Nuryanto, I. K. (2023). Determinant of functional disability in instrumental activities of daily living among elderly living in a rural area in Bali: a cross-sectional study. *Jurnal Ners*, 18(2), 110-116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jn.v18i2.45700>
- Suyasa, I. G. P. D., Agustini, N. L. P. I. B., Sutini, N. K., Israfil, I., & Rittiruang, A. (2025). Attitudes Toward Older People Among Nursing Students in Southeast Asia: A Narrative Review. *Adi Husada Nursing Journal*, 11(1), 35-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.37036/ahnj.v11i1.623>
- Suyasa, I. G. P. D., & Sutini, N. K. (2021). Research Priority of Gerontic Nursing in Indonesia: findings from a Delphi Study. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 9(1), 18-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkp.v9i1.1563>
- Toney-Butler, T. J., & Thayer, J. M. (2025). Nursing Process. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Wagner, C. M., Butcher, H. K., & Clarke, M. F. (2023). *Nursing interventions classification (NIC)-E-book: nursing interventions classification (NIC)-E-book*. Elsevier Health Sciences.

CHAPTER 3

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM KEPERAWATAN GERONTIK

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Komunikasi efektif dalam praktik keperawatan gerontik merupakan sebuah aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan, mengingat komunikasi adalah inti dari interaksi antara perawat dan pasien lansia dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan. Keperawatan gerontik, yang secara khusus berfokus pada pemberian asuhan kepada populasi lansia, memiliki tantangan yang unik, mengingat kelompok usia ini umumnya mengalami perubahan fisiologis, psikologis, sosial, serta emosional yang kompleks. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi secara efektif menjadi kunci utama dalam memastikan terciptanya pelayanan keperawatan yang optimal, berkualitas, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lansia secara menyeluruh.

Secara lebih rinci, komunikasi efektif dalam keperawatan gerontik berperan sangat penting karena melalui komunikasi inilah perawat mampu membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan pasien lansia. Hubungan yang terjalin baik memungkinkan perawat untuk memahami secara mendalam berbagai kebutuhan spesifik lansia, baik yang bersifat fisik maupun psikososial. Lansia seringkali memiliki tantangan dalam mengungkapkan keluhan, rasa sakit, atau berbagai kebutuhan lain secara jelas karena faktor-faktor yang berkaitan dengan usia lanjut seperti penurunan fungsi kognitif, gangguan pendengaran, kesulitan dalam mengolah informasi dengan cepat, atau bahkan hambatan bahasa akibat perbedaan latar belakang budaya dan sosial. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempersulit proses komunikasi, sehingga perawat harus memiliki keterampilan khusus dalam berkomunikasi untuk menangkap dengan tepat pesan dan kebutuhan yang ingin disampaikan oleh lansia.

Komunikasi yang efektif juga memberikan dampak signifikan pada aspek emosional dan psikologis lansia. Ketika lansia merasa didengarkan, dihormati, dan dipahami oleh perawat, hal tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi lansia dalam mengikuti berbagai bentuk intervensi atau perawatan yang diberikan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat memicu munculnya perasaan cemas, terisolasi, atau frustrasi pada lansia, yang kemudian bisa berdampak negatif terhadap

kesehatan dan kesejahteraan emosional mereka. Oleh sebab itu, perawat yang bekerja dengan lansia harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang tidak hanya jelas secara verbal, namun juga penuh empati, perhatian, dan kesabaran, sehingga interaksi yang dibangun selalu bersifat suportif dan menguatkan lansia secara emosional.

Lebih jauh lagi, komunikasi efektif dalam praktik keperawatan gerontik menjadi sangat esensial dalam proses pengambilan keputusan klinis. Komunikasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami membantu perawat dalam mengumpulkan data akurat mengenai kondisi fisik, mental, serta emosional pasien lansia. Dengan data tersebut, perawat dapat membuat keputusan klinis yang tepat, merancang rencana intervensi yang sesuai, serta mengimplementasikan berbagai tindakan perawatan secara efektif. Selain itu, komunikasi yang baik antara perawat dan lansia juga membantu dalam melakukan edukasi kesehatan secara lebih baik, memberikan informasi tentang pengobatan, prosedur medis, atau tindakan lain yang akan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa pasien lansia dan keluarga mereka mampu memahami sepenuhnya situasi kesehatan mereka serta dapat secara aktif terlibat dalam proses perawatan yang dilakukan.

Dalam konteks yang lebih luas, komunikasi efektif juga memfasilitasi kolaborasi antara perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapis, maupun pekerja sosial. Ketika perawat mampu mengkomunikasikan kondisi pasien lansia secara jelas, tim multidisiplin akan memiliki gambaran yang sama mengenai kebutuhan, tantangan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam proses perawatan. Hal ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia bersifat integratif, holistik, dan terkoordinasi dengan baik antar berbagai profesi kesehatan.

B. Prinsip Dasar Komunikasi Efektif dengan Lansia

Prinsip dasar komunikasi efektif dengan lansia menjadi suatu fondasi yang sangat penting dalam praktik keperawatan gerontik. Lansia sebagai kelompok usia lanjut memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari kelompok usia lain, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengadaptasi cara komunikasinya agar interaksi dengan lansia dapat berlangsung secara optimal dan efektif. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami serta dipraktikkan oleh perawat dalam berkomunikasi dengan lansia agar tujuan perawatan dapat tercapai dengan baik, yaitu menghormati lansia, menciptakan suasana yang nyaman, sabar dalam proses komunikasi, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta menjaga kontak mata secara tepat.

Menghormati lansia merupakan prinsip pertama dan utama yang harus diterapkan dalam komunikasi efektif dengan populasi lansia. Rasa hormat kepada lansia tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap sopan secara verbal, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap pengalaman hidup, kebijaksanaan, serta nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang dimiliki oleh lansia tersebut. Saat berkomunikasi, perawat harus menghindari sikap merendahkan atau memperlakukan lansia seolah-olah mereka kurang kompeten dalam memahami informasi. Sikap hormat ini juga diwujudkan dengan cara mendengarkan secara aktif, memberikan kesempatan kepada lansia untuk menyampaikan perasaan dan pendapat tanpa tergesa-gesa atau menginterupsi pembicaraan, serta menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap apa yang mereka ungkapkan. Dengan sikap penuh hormat, lansia akan merasa dihargai sebagai individu yang masih memiliki nilai dan kontribusi, sehingga tercipta hubungan kepercayaan yang mendalam antara perawat dengan lansia.

Prinsip kedua adalah menciptakan suasana yang nyaman dalam berkomunikasi dengan lansia. Perawat perlu memahami bahwa suasana lingkungan sangat memengaruhi kualitas interaksi dengan lansia. Suasana yang nyaman dapat diwujudkan dengan menciptakan lingkungan komunikasi yang tenang, minim gangguan atau distraksi, pencahayaan yang cukup, serta posisi duduk yang nyaman dan sejajar, yang memungkinkan lansia merasa rileks saat berkomunikasi. Dalam beberapa situasi, suasana nyaman juga bisa didukung dengan sentuhan yang hangat seperti memegang tangan lansia secara lembut jika hal tersebut sesuai dengan kondisi budaya dan sosial mereka. Suasana yang nyaman ini membantu lansia merasa aman, diterima, dan didukung, sehingga mereka lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan, kekhawatiran, ataupun keluhan yang dirasakan.

Kesabaran dalam proses komunikasi merupakan prinsip ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam komunikasi dengan lansia. Perawat harus menyadari bahwa lansia seringkali mengalami tantangan dalam merespons, memahami, atau mengolah informasi yang disampaikan secara cepat. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti penurunan fungsi kognitif, gangguan pendengaran, atau kesulitan bahasa akibat usia lanjut. Oleh sebab itu, perawat perlu memberikan waktu yang cukup bagi lansia untuk merespons pertanyaan maupun pernyataan yang disampaikan tanpa memperlihatkan ketidaksabaran atau kegelisahan. Jika lansia menunjukkan tanda-tanda kesulitan memahami, perawat harus bersedia mengulang informasi dengan lebih jelas dan perlahan tanpa memberikan tekanan. Dengan kesabaran ini, lansia akan merasa nyaman dalam proses komunikasi dan lebih termotivasi untuk tetap terlibat aktif dalam interaksi.

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami merupakan prinsip keempat yang sangat penting dalam komunikasi dengan lansia. Perawat harus menyadari bahwa lansia mungkin mengalami kesulitan dalam memahami istilah medis atau bahasa teknis yang rumit. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana, jelas, serta menggunakan kalimat yang pendek dan terstruktur dengan baik. Perawat juga harus berbicara dengan volume suara yang sesuai dan kecepatan bicara yang lambat agar informasi dapat diterima secara jelas oleh lansia, terutama bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran atau penurunan fungsi kognitif. Jika diperlukan, informasi yang kompleks dapat disederhanakan dengan menggunakan analogi atau ilustrasi yang dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari lansia. Bahasa yang mudah dipahami akan memastikan bahwa lansia benar-benar memahami pesan yang disampaikan oleh perawat, sehingga risiko kesalahpahaman atau ketidakjelasan dapat diminimalisasi.

Terakhir, prinsip kelima adalah menjaga kontak mata secara tepat saat berkomunikasi dengan lansia. Kontak mata merupakan salah satu elemen nonverbal yang sangat penting dalam membangun hubungan kepercayaan dan penghormatan dalam komunikasi. Ketika berkomunikasi, perawat sebaiknya menjaga kontak mata secara natural dan penuh perhatian tanpa terkesan menatap secara berlebihan atau sebaliknya menghindari kontak mata sama sekali. Kontak mata yang tepat dapat memperkuat pesan verbal yang disampaikan serta menunjukkan bahwa perawat benar-benar hadir, memperhatikan, dan menghargai interaksi dengan lansia. Namun demikian, perawat juga perlu peka terhadap konteks budaya dari lansia tersebut, mengingat bahwa dalam beberapa budaya tertentu kontak mata yang intens mungkin dipandang tidak sopan atau mengganggu. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk menyesuaikan cara berkomunikasi berdasarkan sensitivitas budaya dan preferensi pribadi dari lansia tersebut.

C. Teknik Komunikasi Terapeutik dengan Lansia

Teknik komunikasi terapeutik dengan lansia merupakan keterampilan yang sangat esensial dalam praktik keperawatan gerontik, khususnya untuk membangun hubungan yang positif, penuh perhatian, serta mampu memberikan efek terapi kepada lansia. Lansia merupakan kelompok usia yang sering kali memiliki berbagai perasaan atau kekhawatiran yang spesifik, baik terkait dengan perubahan fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual yang terjadi seiring dengan proses penuaan. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang mendalam, meliputi empati dalam memahami perasaan lansia, mendengarkan secara aktif untuk mengidentifikasi kebutuhan lansia, serta menerapkan pendekatan empatik dalam merespons setiap kekhawatiran atau kecemasan yang dialami lansia.

Empati merupakan salah satu teknik komunikasi terapeutik yang paling mendasar sekaligus efektif saat berinteraksi dengan lansia. Empati di sini bukan sekadar memahami perasaan lansia secara intelektual, melainkan juga melibatkan keterlibatan emosional secara mendalam dalam merasakan apa yang dirasakan oleh lansia tersebut. Dalam komunikasi terapeutik, perawat yang empatik mampu menempatkan diri dalam posisi lansia, mencoba memahami bagaimana perasaan mereka menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam hidupnya, seperti penurunan fungsi fisik, kehilangan pasangan atau teman sebaya, isolasi sosial, hingga perasaan tidak berdaya atau kehilangan kemandirian. Empati membantu perawat untuk merespons lansia secara tepat, tulus, dan penuh kehangatan, sehingga lansia merasa didukung secara emosional. Sikap empatik yang ditunjukkan perawat akan membuat lansia merasa bahwa perawat sungguh-sungguh peduli dan memahami situasi mereka, sehingga mereka lebih terbuka dan percaya untuk berbagi perasaan yang mungkin selama ini mereka pendam.

Selanjutnya, teknik mendengarkan aktif menjadi bagian penting dalam komunikasi terapeutik yang efektif dengan lansia. Mendengarkan aktif bukan hanya tentang diam dan mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh lansia, melainkan proses yang lebih dalam di mana perawat secara sadar dan penuh perhatian menangkap pesan verbal maupun nonverbal yang disampaikan lansia. Dalam mendengarkan aktif, perawat memberikan perhatian penuh kepada lansia dengan cara mempertahankan kontak mata secara lembut, menampilkan ekspresi wajah yang penuh perhatian, serta memberikan respon nonverbal seperti anggukan kepala, senyuman ringan, ataupun sentuhan lembut jika sesuai dan diterima oleh lansia. Perawat juga memberikan respon verbal yang menunjukkan ketertarikan, seperti mengucapkan kalimat sederhana seperti "Saya mengerti," atau "Teruskan, saya mendengarkan Anda." Teknik ini membuat lansia merasa dihargai dan didengarkan sepenuhnya, yang pada gilirannya akan membantu mereka lebih leluasa dalam mengekspresikan perasaan, harapan, atau kebutuhan yang selama ini sulit untuk disampaikan secara jelas.

Lebih jauh lagi, mendengarkan aktif membantu perawat untuk menangkap berbagai informasi penting yang mungkin tersirat dalam ucapan lansia. Lansia sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara langsung kebutuhan atau masalah mereka karena berbagai faktor seperti rasa malu, takut menjadi beban, atau kesulitan dalam menyusun kalimat yang jelas. Dengan mendengarkan secara aktif, perawat akan lebih mampu menangkap makna di balik ucapan lansia serta mengenali tanda-tanda emosional yang tersirat, seperti kecemasan, rasa sedih, kebingungan, atau ketakutan. Informasi penting ini menjadi dasar bagi perawat

untuk merancang intervensi yang sesuai dan efektif dalam mendukung kebutuhan fisik maupun psikologis lansia.

Teknik komunikasi terapeutik berikutnya adalah pendekatan empatik dalam merespons kekhawatiran atau kecemasan yang dialami lansia. Pendekatan empatik mengharuskan perawat untuk tidak hanya memahami perasaan lansia tetapi juga mampu merespons secara hangat, sabar, dan penuh perhatian terhadap kekhawatiran atau kecemasan yang disampaikan lansia. Respons empatik yang efektif biasanya melibatkan beberapa tahapan, yaitu pertama, perawat secara jelas mengidentifikasi perasaan atau kekhawatiran lansia dengan ucapan seperti "Saya bisa melihat bahwa Ibu merasa khawatir tentang kondisi kesehatan Ibu saat ini." Kedua, perawat memberikan validasi terhadap perasaan tersebut dengan cara menunjukkan bahwa perasaan lansia tersebut normal dan wajar, seperti dengan mengatakan "Saya paham perasaan cemas yang Bapak rasakan, itu memang wajar dialami oleh banyak lansia dalam situasi serupa." Terakhir, perawat memberikan dukungan secara verbal maupun nonverbal untuk membantu lansia merasa lebih tenang dan nyaman, seperti dengan mengatakan "Mari kita cari bersama solusi terbaik yang bisa membuat Ibu merasa lebih nyaman," atau dengan memberikan sentuhan ringan di tangan lansia untuk menunjukkan dukungan emosional secara nyata.

Pendekatan empatik ini sangat efektif karena lansia sering kali membutuhkan rasa aman dan diyakinkan bahwa perasaan mereka diakui, diterima, dan dipahami oleh orang lain, khususnya oleh perawat yang merawat mereka. Sikap empatik yang konsisten dari perawat dalam menghadapi kekhawatiran atau kecemasan lansia dapat membantu meredakan stres emosional yang dialami lansia, meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

D. Hambatan Komunikasi pada Lansia

Hambatan komunikasi dengan lansia merupakan tantangan yang sangat umum terjadi dalam praktik keperawatan gerontik. Hal ini disebabkan oleh beberapa perubahan yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-budaya. Hambatan ini sering kali mengganggu efektivitas komunikasi, sehingga informasi penting mungkin tidak tersampaikan dengan jelas, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas interaksi dan pelayanan keperawatan terhadap lansia. Beberapa hambatan yang paling sering ditemui dalam komunikasi dengan lansia antara lain gangguan pendengaran, gangguan kognitif, serta hambatan bahasa yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya atau latar belakang sosial.

Gangguan pendengaran merupakan hambatan yang paling umum dalam komunikasi dengan lansia. Hal ini terjadi karena adanya proses degeneratif pada sistem pendengaran yang dikenal sebagai presbikusis, yakni penurunan fungsi pendengaran akibat proses penuaan alami. Kondisi ini biasanya ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk mendengar suara berfrekuensi tinggi, kesulitan dalam mendengar percakapan, terutama dalam suasana yang bising atau ramai, serta sering kali membutuhkan lawan bicara untuk berbicara lebih keras atau mengulang informasi berkali-kali. Lansia yang mengalami gangguan pendengaran juga cenderung menarik diri dari interaksi sosial karena merasa frustrasi, malu, atau takut dianggap sebagai beban oleh lawan bicaranya.

Dalam konteks komunikasi dengan lansia yang memiliki gangguan pendengaran, perawat perlu memahami bahwa gangguan ini bukan hanya persoalan fisik semata, tetapi juga bisa mempengaruhi aspek psikologis lansia, seperti kepercayaan diri dan harga diri mereka. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perawat untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang jelas, berbicara dengan nada suara yang sedikit lebih tinggi tetapi tetap lembut, berbicara dalam kecepatan yang sedang, menggunakan artikulasi yang jelas, serta memperhatikan posisi tubuh agar lansia bisa melihat gerakan bibir atau ekspresi wajah dengan jelas. Menggunakan bahasa tubuh seperti gestur atau ekspresi wajah yang ramah juga sangat membantu lansia dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh perawat. Selain itu, meminimalisir gangguan eksternal seperti suara latar yang bising saat berkomunikasi dengan lansia dapat meningkatkan efektivitas komunikasi.

Hambatan lain yang sering ditemui adalah gangguan kognitif, yang sering kali muncul seiring bertambahnya usia. Gangguan kognitif pada lansia meliputi berbagai kondisi seperti demensia, Alzheimer, penurunan daya ingat, serta gangguan konsentrasi yang berdampak langsung pada kemampuan lansia untuk memahami, mengolah, dan merespons informasi yang diterima. Lansia dengan gangguan kognitif sering kali mengalami kesulitan dalam memahami pesan, mengingat informasi penting yang disampaikan, serta kesulitan dalam menyusun kalimat atau kata-kata secara logis dan jelas. Hal ini menyebabkan proses komunikasi menjadi lambat, tidak lancar, bahkan sering kali menimbulkan kebingungan dan frustrasi baik bagi lansia maupun bagi perawat yang berinteraksi dengannya.

Menghadapi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh gangguan kognitif ini, perawat perlu lebih sabar dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sederhana namun jelas. Pesan yang disampaikan harus singkat, padat, dan diulang beberapa kali jika diperlukan agar lansia dapat memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Perawat juga harus memberikan waktu yang cukup bagi lansia untuk memproses pesan tersebut sebelum merespons. Selain itu, perawat dapat

menggunakan bantuan visual, seperti gambar atau tulisan sederhana, untuk membantu lansia memahami informasi yang disampaikan secara lebih baik. Pendekatan yang tenang, sabar, dan penuh perhatian sangat diperlukan agar lansia tidak merasa tertekan atau stres akibat kesulitan memahami pesan.

Hambatan komunikasi berikutnya adalah hambatan bahasa, yang biasanya muncul karena adanya perbedaan latar belakang budaya atau sosial antara perawat dengan lansia yang dirawat. Perbedaan budaya sering kali mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, termasuk pilihan kata, dialek, ekspresi nonverbal, hingga sikap terhadap orang yang lebih tua. Lansia yang berasal dari budaya atau latar belakang sosial yang berbeda sering kali memiliki kebiasaan atau nilai komunikasi yang khas, seperti cara menyampaikan perasaan, penggunaan istilah tertentu, atau ekspresi yang mungkin tidak familiar bagi perawat. Sebaliknya, perawat mungkin menggunakan istilah medis atau bahasa formal yang sulit dipahami oleh lansia dengan latar belakang pendidikan atau budaya yang berbeda.

Untuk mengatasi hambatan bahasa ini, perawat harus memiliki kepekaan budaya (*cultural sensitivity*), yang berarti perawat harus terbuka dan mau belajar tentang latar belakang budaya lansia, memahami istilah-istilah atau ekspresi khusus yang sering digunakan oleh lansia tersebut, serta menyesuaikan cara berbicara atau menyampaikan pesan agar lebih mudah dipahami oleh lansia. Dalam situasi tertentu, perawat mungkin perlu menggunakan bantuan keluarga atau penerjemah informal, atau menggunakan pendekatan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, sentuhan lembut, atau gerakan tubuh yang ramah untuk membantu memperjelas pesan yang disampaikan.

E. Dokumentasi Hasil Komunikasi dan Interaksi Efektif dalam Keperawatan Gerontik

Dokumentasi hasil komunikasi dan interaksi efektif dalam keperawatan gerontik merupakan bagian integral yang sangat penting dalam proses pelayanan keperawatan bagi lansia. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis yang akurat dan informatif, namun juga menjadi alat komunikasi antarperawat serta tenaga kesehatan lainnya untuk menjamin kontinuitas perawatan. Dalam konteks keperawatan gerontik, dokumentasi yang terstruktur dan jelas sangat esensial karena lansia memiliki berbagai kebutuhan unik yang kompleks, termasuk perubahan kondisi kesehatan yang cepat serta tantangan komunikasi yang sering terjadi akibat proses penuaan.

Pentingnya dokumentasi dalam keperawatan gerontik tercermin dari fungsinya sebagai media pencatatan informasi yang diperoleh dari hasil komunikasi dan interaksi perawat dengan lansia. Komunikasi yang berlangsung antara perawat

dengan lansia sering kali memberikan data yang berharga tentang kondisi fisik, psikologis, sosial, serta emosional lansia tersebut. Dengan dokumentasi yang baik, setiap informasi penting dari interaksi ini dapat dicatat secara detail, termasuk keluhan yang disampaikan lansia, perubahan suasana hati atau perilaku, respon terhadap intervensi, hingga ekspresi verbal dan nonverbal yang diamati oleh perawat selama proses komunikasi berlangsung. Informasi ini sangat berguna bagi perawat atau tim kesehatan lain dalam menentukan intervensi selanjutnya, mengevaluasi efektivitas perawatan yang telah diberikan, serta melakukan adaptasi atau modifikasi pada rencana perawatan yang sesuai dengan perkembangan kondisi lansia.

Selain itu, dokumentasi hasil komunikasi yang akurat dan teratur juga membantu menciptakan kesinambungan pelayanan yang berkualitas tinggi. Dalam pelayanan gerontik, lansia sering kali ditangani oleh beberapa perawat atau tenaga kesehatan yang berbeda secara bergantian. Tanpa dokumentasi yang jelas, perawat lain yang melanjutkan perawatan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap riwayat komunikasi dan interaksi sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan kesalahan atau ketidakefektifan pelayanan. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan perawat lain untuk memahami dengan baik kebutuhan dan kondisi spesifik lansia, sehingga mereka dapat melanjutkan pelayanan secara konsisten dan terkoordinasi.

Dalam menyusun dokumentasi hasil komunikasi dan interaksi dengan lansia, teknik pencatatan yang sistematis sangat diperlukan agar informasi yang tercatat dapat digunakan secara efektif oleh semua anggota tim kesehatan. Pencatatan harus dilakukan secara kronologis, lengkap, dan jelas, mencakup informasi tentang waktu, tanggal, serta tempat terjadinya komunikasi atau interaksi. Perawat harus secara jelas mencatat tujuan komunikasi, metode atau pendekatan yang digunakan, respon lansia, serta hambatan-hambatan yang muncul selama interaksi berlangsung. Selain itu, perawat juga harus mencatat setiap perubahan kondisi lansia yang ditemukan dalam proses komunikasi, seperti perubahan emosi, perilaku, atau adanya keluhan baru yang disampaikan lansia. Dengan cara ini, dokumentasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kondisi lansia dari waktu ke waktu.

Penggunaan format dokumentasi yang tepat juga sangat penting dalam praktik keperawatan gerontik. Format dokumentasi harus mencakup komponen yang relevan dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim kesehatan. Dalam keperawatan gerontik, biasanya digunakan format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), atau format pencatatan naratif yang terstruktur secara kronologis dan deskriptif. Format SOAP misalnya, memungkinkan perawat untuk mencatat

informasi subyektif (keluhan, perasaan, atau pernyataan lansia), data obyektif (hasil observasi seperti ekspresi wajah, perilaku, kondisi fisik), hasil analisis atau assessment (interpretasi data oleh perawat), serta rencana tindakan atau intervensi yang akan dilakukan selanjutnya. Penggunaan format ini membantu perawat mencatat informasi secara sistematis, memudahkan pembacaan, serta membantu tim dalam merencanakan tindakan lanjutan secara jelas dan efektif.

Dokumentasi hasil komunikasi dan interaksi juga digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan kepada lansia. Dengan adanya catatan yang lengkap dan akurat, perawat dapat mengevaluasi sejauh mana intervensi yang dilakukan telah efektif dalam mengatasi masalah yang dialami lansia. Dokumentasi ini memungkinkan perawat untuk melihat pola-pola tertentu dalam respon lansia terhadap intervensi yang telah diberikan, seperti apakah terdapat peningkatan kualitas komunikasi, perbaikan kondisi psikologis, atau pengurangan keluhan fisik dan emosional. Dari hasil evaluasi ini, perawat kemudian dapat memutuskan apakah intervensi yang sama perlu dilanjutkan, dihentikan, atau diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru lansia.

Lebih jauh lagi, dokumentasi ini juga memiliki fungsi legal dan profesional yang penting dalam praktik keperawatan gerontik. Dalam konteks hukum dan etika keperawatan, dokumentasi yang akurat dapat digunakan sebagai bukti bahwa pelayanan yang diberikan kepada lansia telah sesuai dengan standar profesional. Dokumentasi ini membantu melindungi perawat dan institusi pelayanan kesehatan apabila terjadi tuntutan hukum atau konflik yang melibatkan pelayanan kepada lansia. Oleh karena itu, pencatatan yang tepat, obyektif, dan terperinci menjadi aspek kritis yang harus diperhatikan oleh setiap perawat dalam keperawatan gerontik.

F. Simpulan

Komunikasi efektif merupakan elemen yang sangat penting dalam praktik keperawatan gerontik untuk memastikan pemberian pelayanan yang optimal bagi lansia. Melalui komunikasi yang efektif, perawat dapat membangun hubungan interpersonal yang positif, memahami secara mendalam kebutuhan unik lansia, serta menciptakan lingkungan terapeutik yang mendukung peningkatan kualitas hidup lansia. Prinsip dasar komunikasi dengan lansia, seperti menghormati lansia, menciptakan suasana yang nyaman, bersikap sabar, menggunakan bahasa sederhana, serta menjaga kontak mata yang tepat, harus secara konsisten diterapkan dalam interaksi sehari-hari.

Teknik komunikasi terapeutik, seperti empati, mendengarkan aktif, dan pendekatan empatik dalam merespons kecemasan atau kekhawatiran lansia, merupakan keterampilan khusus yang perlu dikuasai perawat gerontik. Teknik ini membantu perawat untuk mendalami perasaan lansia, merespons secara tulus dan tepat, serta menciptakan rasa aman dan nyaman yang sangat dibutuhkan lansia dalam menghadapi berbagai perubahan akibat proses penuaan.

Dalam praktiknya, perawat gerontik sering kali menghadapi berbagai hambatan komunikasi, seperti gangguan pendengaran, gangguan kognitif, serta perbedaan bahasa akibat latar belakang budaya yang beragam. Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan kepekaan khusus, kesabaran ekstra, serta kemampuan perawat untuk menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan tetap tersampaikan secara efektif.

Dokumentasi hasil komunikasi dan interaksi dengan lansia juga merupakan aspek penting dalam keperawatan gerontik. Dokumentasi yang sistematis, akurat, dan jelas berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kesinambungan pelayanan, evaluasi efektivitas intervensi keperawatan, serta perlindungan legal dan profesional bagi perawat. Oleh karena itu, dokumentasi yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap lansia, tetapi juga memperkuat kolaborasi tim multidisiplin dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan holistik kepada lansia di komunitas maupun institusi pelayanan kesehatan.

G. Referensi

- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2019). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Blais, K. K., & Hayes, J. S. (2016). *Professional Nursing Practice: Concepts and Perspectives* (7th ed.). Pearson Education.
- Daly, L. (2017). Effective communication with older adults. *Nursing Standard*, 31(41), 55-63. <https://doi.org/10.7748/ns.2017.e10734>
- Eldh, A. C., Ekman, I., & Ehnfors, M. (2016). Considering patient non-participation in healthcare. *Health Expectations*, 19(5), 1250-1261. <https://doi.org/10.1111/hex.12447>
- Eliopoulos, C. (2018). *Gerontological Nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Fleischer, S., Berg, A., Zimmermann, M., Wüste, K., & Behrens, J. (2017). Nurse-patient interaction and communication: A systematic literature review. *Journal of Public Health*, 25(4), 339-353. <https://doi.org/10.1007/s10389-017-0807-5>
- Heise, B. A., & Gilpin, L. C. (2016). Nursing students' clinical experiences with older adults: A content analysis. *Nurse Education Today*, 42, 58-63.

<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.017>

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

Stanyon, M. R., Griffiths, A., Thomas, S. A., & Gordon, A. L. (2016). The facilitators of communication with people with dementia in a care setting: An interview study with healthcare workers. *Age and Ageing*, 45(1), 164-170. <https://doi.org/10.1093/ageing/afv161>

Touhy, T. A., & Jett, K. (2017). *Ebersole and Hess' Gerontological Nursing & Healthy Aging* (5th ed.). Elsevier Health Sciences.

Webb, L., & Dening, T. (2016). In whose best interests? A case study of a family affected by dementia. *British Journal of Community Nursing*, 21(6), 300-304. <https://doi.org/10.12968/bjcn.2016.21.6.300>

World Health Organization. (2017). *Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*. World Health Organization Press.

H. Glosarium

Keperawatan Gerontik

Cabang keperawatan khusus yang fokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada populasi lansia dengan mempertimbangkan berbagai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan emosional yang terjadi seiring proses penuaan.

Komunikasi Efektif

Proses penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan akurat dengan mempertimbangkan kemampuan penerimaan pesan oleh pasien, yang melibatkan penggunaan bahasa sederhana, jelas, serta dukungan nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, atau kontak mata.

Komunikasi Terapeutik

Interaksi interpersonal antara perawat dan pasien yang bertujuan memberikan dukungan psikologis dan emosional, dengan menerapkan teknik komunikasi yang empatik, mendengarkan aktif, dan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan emosional pasien.

Empati

Kemampuan perawat untuk memahami dan merasakan perasaan pasien lansia secara mendalam, sehingga dapat memberikan respons yang tepat, tulus, dan penuh perhatian terhadap kekhawatiran atau kecemasan yang dialami lansia.

Mendengarkan Aktif

Teknik komunikasi di mana perawat secara sadar memberikan perhatian penuh kepada pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh lansia, menampilkan

sikap responsif serta memberikan umpan balik secara tepat agar pasien merasa dihargai dan dimengerti.

Gangguan Pendengaran (Presbikosis)

Penurunan fungsi pendengaran yang umumnya terjadi secara alami seiring bertambahnya usia, ditandai dengan kesulitan mendengar suara bernada tinggi dan percakapan dalam lingkungan bising.

Gangguan Kognitif

Penurunan kemampuan mental yang mencakup masalah memori, daya pikir, pemahaman, konsentrasi, dan pengolahan informasi yang sering dialami oleh lansia, termasuk kondisi seperti demensia atau penyakit Alzheimer.

Hambatan Bahasa

Kesulitan dalam komunikasi yang muncul akibat perbedaan bahasa, dialek, istilah medis, atau ekspresi verbal dan nonverbal yang terkait dengan latar belakang budaya atau sosial yang berbeda antara perawat dan pasien lansia.

Dokumentasi Keperawatan Gerontik

Pencatatan sistematis yang dilakukan perawat terhadap hasil komunikasi, interaksi, pengkajian, serta intervensi yang diberikan kepada lansia, digunakan sebagai alat evaluasi perawatan dan dasar kesinambungan pelayanan.

Format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)

Metode pencatatan dokumentasi keperawatan yang terstruktur, mencakup pencatatan data subjektif (keluhan pasien), objektif (hasil observasi klinis), asesmen (interpretasi data), dan rencana tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

CHAPTER 4

PROSES KEPERAWATAN GERONTIK

Drh. Ignatus Djuniarto, S.Kep., M.M.R.

A. Pendahuluan/Prolog

Lanjut usia atau lansia merupakan kelompok populasi yang mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial secara signifikan. Dalam proses penuaan tersebut, lansia tidak hanya menghadapi risiko penyakit kronis yang umum seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit degeneratif lainnya, namun juga rentan mengalami kumpulan gejala khas yang dikenal sebagai sindrom geriatri. Sindrom geriatri merujuk pada berbagai kondisi yang seringkali terjadi secara bersamaan pada lansia, yang tidak sepenuhnya diklasifikasikan sebagai penyakit tunggal, tetapi berupa kumpulan gejala klinis yang muncul akibat akumulasi proses penuaan, menurunnya cadangan fisiologis tubuh, serta pengaruh interaksi antara faktor internal dan eksternal.

Sindrom geriatri yang paling umum ditemukan dalam praktik keperawatan lansia di antaranya adalah jatuh (fall), inkontinensia urin, dan delirium. Ketiga kondisi ini kerap kali tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait, memperparah kondisi kesehatan lansia, serta meningkatkan risiko komplikasi dan penurunan fungsi secara menyeluruh. Misalnya, lansia yang mengalami delirium memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh, sedangkan lansia yang mengalami inkontinensia urin berisiko mengalami depresi dan isolasi sosial yang signifikan.

Dalam konteks asuhan keperawatan, pemahaman mengenai sindrom geriatri menjadi sangat penting karena dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup lansia. Sindrom geriatri tidak hanya berdampak pada fisik lansia semata, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial mereka. Sebagai contoh, lansia yang mengalami jatuh seringkali kali mengalami trauma psikologis, ketakutan berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan akhirnya memilih untuk membatasi aktivitas sehari-hari mereka. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan penurunan fungsi fisik yang lebih lanjut dan semakin memburuknya kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

Selain itu, sindrom geriatri juga memengaruhi beban keluarga dan sistem pelayanan kesehatan secara luas. Keluarga yang merawat lansia dengan sindrom geriatri sering menghadapi tantangan besar dalam aspek perawatan sehari-hari, dukungan emosional, serta biaya kesehatan yang meningkat akibat kondisi yang

kronis dan berulang. Oleh karena itu, peran perawat sebagai penyedia layanan kesehatan profesional dalam mendeteksi secara dini, mencegah, serta mengelola sindrom geriatri pada lansia menjadi sangat krusial.

Untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, perawat perlu memahami secara komprehensif bagaimana proses penuaan mempengaruhi timbulnya sindrom geriatri, apa saja gejala klinis yang perlu diwaspadai, serta bagaimana melakukan intervensi efektif yang didasarkan pada pendekatan berbasis bukti. Pendekatan ini memungkinkan perawat tidak hanya bertindak secara responsif terhadap masalah kesehatan yang muncul, tetapi juga proaktif dalam upaya pencegahan dan edukasi bagi lansia dan keluarganya. Dengan demikian, perawat dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi risiko sindrom geriatri, memperlambat progresivitasnya, serta mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas hidup lansia secara optimal.

B. Konsep Dasar Sindrom Geriatri

Sindrom geriatri merupakan serangkaian kondisi klinis yang khas terjadi pada lansia akibat akumulasi dari berbagai proses penuaan, penurunan fungsi fisiologis, serta interaksi kompleks antara faktor internal maupun eksternal. Istilah sindrom geriatri secara umum digunakan untuk menggambarkan sejumlah gejala atau gangguan yang memiliki sifat multifaktorial dan tidak dapat secara jelas diklasifikasikan dalam kategori penyakit tunggal. Beberapa sindrom geriatri yang paling sering ditemukan di lingkungan klinis adalah jatuh (fall), inkontinensia urin (urinary incontinence), dan delirium. Memahami konsep dasar masing-masing sindrom ini, termasuk penyebab, faktor risiko, manifestasi klinis, serta dampaknya terhadap lansia sangat penting dalam asuhan keperawatan lansia yang komprehensif.

Jatuh atau fall merupakan salah satu masalah utama yang sering dialami lansia. Kejadian jatuh pada lansia seringkali dihubungkan dengan berbagai perubahan fisik yang terjadi akibat proses penuaan, seperti penurunan keseimbangan tubuh, gangguan fungsi muskuloskeletal, gangguan penglihatan, serta penggunaan obat-obatan tertentu. Selain itu, lingkungan fisik yang kurang aman, seperti lantai licin, pencahayaan yang kurang baik, atau penggunaan alas kaki yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko terjadinya jatuh. Lansia yang mengalami jatuh seringkali menunjukkan manifestasi klinis berupa cedera fisik seperti patah tulang, luka memar, hingga perdarahan internal. Dampak jatuh pada lansia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi psikologis mereka. Setelah mengalami kejadian jatuh, lansia sering mengalami rasa takut atau trauma terhadap aktivitas fisik, yang berakibat pada isolasi sosial serta memburuknya kualitas hidup secara signifikan.

Selanjutnya, inkontinensia urin merupakan kondisi di mana lansia kehilangan kontrol terhadap proses berkemih secara tidak sadar, sehingga menyebabkan kebocoran urin yang tidak disengaja. Penyebab utama inkontinensia urin pada lansia bisa bervariasi, mulai dari melemahnya otot dasar panggul akibat proses penuaan, gangguan saraf yang mengatur fungsi berkemih, hingga penyakit kronis seperti diabetes atau stroke. Faktor risiko lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya inkontinensia urin meliputi jenis kelamin perempuan, riwayat persalinan multipara, obesitas, serta imobilitas atau kurangnya aktivitas fisik. Manifestasi klinis yang sering ditemui pada lansia dengan inkontinensia urin adalah urin keluar tanpa disadari, frekuensi berkemih meningkat secara abnormal, dan rasa malu atau kecemasan dalam menjalankan aktivitas sosial karena khawatir terhadap kebocoran urin. Dampak dari kondisi ini secara psikologis sangat besar, karena lansia kerap mengalami stres, malu, depresi, hingga menarik diri dari interaksi sosial akibat rasa tidak nyaman dan kehilangan rasa percaya diri yang signifikan.

Delirium merupakan gangguan akut yang ditandai oleh perubahan kesadaran, penurunan perhatian, serta gangguan pada proses berpikir dan persepsi. Kondisi ini dapat berkembang secara tiba-tiba dalam beberapa jam hingga beberapa hari, dan sering terjadi pada lansia yang menjalani perawatan di rumah sakit atau sedang mengalami kondisi medis yang kompleks. Penyebab delirium sangat beragam, termasuk infeksi akut, gangguan metabolik seperti gangguan elektrolit, penggunaan atau penghentian mendadak obat-obatan tertentu, serta kondisi nyeri yang tidak terkontrol. Faktor risiko delirium pada lansia meliputi usia yang sangat lanjut, gangguan kognitif sebelumnya seperti demensia, dehidrasi, serta lingkungan rumah sakit yang kurang kondusif seperti ruangan yang bising atau pencahayaan buruk. Manifestasi klinis delirium meliputi kebingungan mendadak, disorientasi waktu, tempat, maupun orang, gangguan tidur, agitasi, serta terkadang munculnya halusinasi. Dampak delirium pada lansia sangat serius, karena selain memperpanjang masa rawat inap di rumah sakit, kondisi ini juga meningkatkan risiko komplikasi lain seperti jatuh, cedera, hingga mortalitas. Selain itu, lansia yang pernah mengalami delirium juga berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kognitif permanen, gangguan psikologis, serta menurunnya kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Ketiga kondisi sindrom geriatri ini tidak berdiri sendiri secara terisolasi, tetapi sering kali saling berhubungan dan dapat memperparah kondisi kesehatan lansia. Misalnya, delirium yang terjadi pada lansia bisa meningkatkan risiko jatuh karena adanya disorientasi dan agitasi, sedangkan inkontinensia urin juga meningkatkan risiko jatuh karena lansia terburu-buru menuju toilet, yang memperbesar peluang kehilangan keseimbangan tubuh.

C. Teknik Pengkajian dan Deteksi Dini Sindrom Geriatri

Pengkajian yang komprehensif dan deteksi dini sindrom geriatri merupakan langkah penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif bagi lansia. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat dan tepat adanya kondisi yang dapat memperburuk kualitas hidup lansia, seperti jatuh, inkontinensia urin, dan delirium. Untuk melaksanakan deteksi dini secara optimal, perawat perlu menguasai beberapa teknik pengkajian spesifik yang mencakup pengkajian fisik, penggunaan instrumen pengkajian khusus, skrining cepat, observasi klinis secara cermat, serta wawancara terstruktur dengan lansia dan keluarga mereka.

Langkah awal dalam proses pengkajian adalah pengkajian fisik secara menyeluruh. Pengkajian fisik dilakukan untuk mendapatkan data objektif terkait kondisi kesehatan lansia, yang meliputi pemeriksaan fungsi muskuloskeletal, kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan pola berjalan untuk mendeteksi risiko jatuh. Misalnya, perawat dapat mengobservasi lansia saat berpindah posisi dari duduk ke berdiri, berjalan, serta melakukan aktivitas fisik sederhana seperti mengangkat benda ringan. Pemeriksaan neurologis juga perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda gangguan saraf yang mungkin berhubungan dengan inkontinensia urin maupun delirium, misalnya pemeriksaan refleks, tonus otot, dan tingkat kesadaran. Selain itu, pemeriksaan status mental lansia seperti orientasi, memori, dan fungsi kognitif umum juga penting untuk mendeteksi gejala awal delirium.

Selanjutnya, penggunaan instrumen pengkajian khusus sangat membantu dalam mendeteksi secara cepat sindrom geriatri pada lansia. Salah satu instrumen yang lazim digunakan untuk mendeteksi risiko jatuh adalah Morse Fall Scale (MFS), yang terdiri dari beberapa indikator seperti riwayat jatuh sebelumnya, penggunaan alat bantu, status mental, dan gaya berjalan. Alat ukur ini mampu mengklasifikasikan tingkat risiko jatuh secara efektif, sehingga memungkinkan perawat untuk merencanakan intervensi preventif yang tepat. Untuk inkontinensia urin, instrumen seperti Bladder Diary atau Incontinence Questionnaire sering digunakan untuk mengetahui frekuensi, volume, pola kebocoran urin, serta situasi yang memicu munculnya inkontinensia pada lansia. Dalam mendeteksi delirium, instrumen seperti Confusion Assessment Method (CAM) merupakan alat pengkajian yang sangat efektif, karena dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan kesadaran, gangguan perhatian, gangguan persepsi, dan disorientasi yang terjadi secara tiba-tiba.

Selain instrumen pengkajian khusus, skrining cepat juga berperan penting dalam proses deteksi dini. Skrining cepat biasanya dilakukan pada saat lansia

pertama kali datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dalam kunjungan rumah secara rutin. Contoh sederhana skrining cepat adalah dengan mengajukan pertanyaan singkat mengenai riwayat jatuh dalam enam bulan terakhir, frekuensi berkemih tidak terkontrol dalam satu minggu terakhir, atau perubahan mendadak dalam perilaku dan kesadaran lansia. Informasi awal ini memberikan gambaran apakah lansia berisiko tinggi mengalami sindrom geriatri dan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut secara mendalam.

Teknik observasi klinis juga merupakan komponen penting dalam pengkajian sindrom geriatri. Observasi dilakukan dengan memperhatikan perilaku lansia selama proses perawatan atau aktivitas sehari-hari. Dalam mendeteksi risiko jatuh, perawat dapat memperhatikan keseimbangan lansia saat berjalan, cara lansia berdiri dari posisi duduk atau berbaring, serta adanya tanda-tanda gangguan penglihatan atau pendengaran yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Observasi klinis juga efektif dalam mengidentifikasi inkontinensia urin dengan memperhatikan pola lansia berulang kali ke kamar mandi atau adanya aroma khas urin yang tercium. Untuk delirium, observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan tanda perubahan perilaku yang tiba-tiba seperti gelisah, linglung, atau perubahan siklus tidur yang mendadak dan tidak wajar.

Wawancara terstruktur dengan lansia dan keluarga juga merupakan langkah penting yang tidak boleh terlewatkan dalam proses pengkajian sindrom geriatri. Melalui wawancara ini, perawat dapat memperoleh data subjektif yang sangat berharga terkait kondisi lansia secara keseluruhan, serta informasi penting yang mungkin tidak terungkap melalui pemeriksaan fisik atau observasi langsung. Dalam wawancara terstruktur, perawat dapat menggali informasi tentang faktor risiko jatuh, kebiasaan berkemih, adanya perubahan perilaku secara mendadak, hingga riwayat penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan risiko delirium atau inkontinensia urin. Wawancara ini juga membuka peluang bagi keluarga untuk menyampaikan kekhawatiran, tantangan, serta kendala yang mereka alami dalam merawat lansia, sehingga perawat dapat memberikan intervensi yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan.

D. Intervensi Keperawatan Efektif pada Sindrom Geriatri

Dalam asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri, intervensi berbasis bukti (evidence-based practice) memegang peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan. Intervensi ini mencakup berbagai aspek mulai dari preventif, promotif, kuratif hingga rehabilitatif, yang kesemuanya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi secara holistik. Keberhasilan intervensi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif tim

multidisiplin yang terdiri dari perawat, dokter, ahli fisioterapi, ahli gizi, psikolog, serta keluarga lansia itu sendiri. Dengan pendekatan ini, maka intervensi yang diberikan akan menyentuh berbagai aspek kebutuhan lansia secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada gejala fisik semata, tetapi juga psikologis, sosial, dan lingkungan.

Dalam aspek preventif atau pencegahan, intervensi yang dilakukan oleh perawat antara lain meliputi identifikasi dini faktor risiko jatuh, inkontinensia urin, serta delirium. Untuk mencegah risiko jatuh, perawat dapat melakukan modifikasi lingkungan fisik yang aman bagi lansia, seperti pemasangan pegangan tangan di kamar mandi, menyediakan pencahayaan yang cukup, serta menjaga agar lantai selalu kering dan bebas dari barang yang mudah tersandung. Selain itu, pemberian edukasi kepada lansia dan keluarga mengenai pentingnya menjaga aktivitas fisik rutin seperti berjalan kaki, latihan keseimbangan, serta latihan penguatan otot sangat efektif untuk meningkatkan stabilitas fisik lansia, sehingga mengurangi risiko jatuh secara nyata.

Intervensi preventif untuk inkontinensia urin dapat berupa pelatihan kandung kemih (bladder training) yang membantu lansia mengatur jadwal berkemih secara teratur dan meningkatkan kemampuan kontrol berkemih. Perawat juga dapat mengajarkan teknik senam otot dasar panggul atau latihan Kegel kepada lansia secara rutin, yang secara signifikan mampu memperkuat otot dasar panggul serta meningkatkan kontrol berkemih lansia. Sedangkan pencegahan delirium dapat dilakukan melalui edukasi kepada keluarga tentang tanda-tanda delirium yang harus diwaspadai, memastikan kecukupan cairan tubuh dan nutrisi lansia, serta mengurangi penggunaan obat-obatan tertentu yang berpotensi meningkatkan risiko delirium, kecuali atas rekomendasi medis yang jelas.

Dari segi intervensi promotif, perawat perlu melakukan edukasi kesehatan secara rutin kepada lansia dan keluarganya mengenai pentingnya gaya hidup sehat, seperti pola makan bergizi seimbang, menjaga hidrasi tubuh yang baik, latihan fisik secara teratur, serta menjaga pola tidur yang teratur. Promosi kesehatan juga mencakup peningkatan kesadaran lansia mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk deteksi dini penyakit atau gangguan kesehatan yang berisiko memperparah sindrom geriatri. Selain itu, perawat juga dapat mendorong lansia agar tetap aktif secara sosial, karena interaksi sosial yang baik secara langsung mampu meningkatkan kondisi psikologis lansia serta mencegah isolasi sosial yang memperparah kondisi geriatri mereka.

Dalam aspek kuratif, intervensi keperawatan harus dilakukan berdasarkan prinsip evidence-based yang merujuk pada hasil penelitian terbaru dan rekomendasi klinis yang valid. Untuk penanganan lansia yang mengalami jatuh, perawat perlu melakukan tindakan awal yang meliputi pemeriksaan cedera secara menyeluruh,

stabilisasi kondisi lansia, serta koordinasi lebih lanjut dengan tim medis apabila ditemukan cedera serius seperti patah tulang atau trauma kepala. Untuk lansia dengan inkontinensia urin, tindakan kuratif meliputi manajemen cairan yang tepat, memastikan lansia mendapatkan akses mudah ke kamar mandi atau alat bantu seperti urinal, dan penggantian popok secara teratur jika diperlukan. Untuk delirium, perawat harus segera mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya seperti infeksi, gangguan metabolik, atau efek samping obat, kemudian segera berkoordinasi dengan dokter untuk memberikan penanganan medis yang sesuai.

Pada aspek rehabilitatif, intervensi keperawatan diarahkan untuk membantu lansia dalam pemulihan fungsi serta kemandirian mereka setelah mengalami kondisi sindrom geriatri. Misalnya, bagi lansia yang pernah jatuh, rehabilitasi melibatkan latihan fisik berupa latihan keseimbangan, mobilisasi secara bertahap, serta dukungan fisioterapi yang membantu lansia mengembalikan fungsi motorik dan kepercayaan diri mereka. Dalam kasus inkontinensia urin, rehabilitasi bisa berupa latihan rutin yang memperkuat otot panggul serta pelatihan ulang kontrol berkemih, didukung dengan edukasi berkelanjutan kepada lansia maupun keluarga. Sedangkan untuk lansia yang mengalami delirium, rehabilitasi mencakup pendekatan psikososial, terapi realitas, serta kegiatan stimulasi kognitif yang membantu mengembalikan orientasi dan fungsi mental lansia.

Keseluruhan intervensi ini tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi yang erat antara berbagai disiplin ilmu kesehatan atau tim multidisiplin. Tim multidisiplin yang bekerja sama secara efektif mampu memberikan asuhan yang terintegrasi bagi lansia dengan sindrom geriatri. Perawat memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan komunikasi antar anggota tim, mengintegrasikan perawatan yang diberikan oleh dokter, ahli fisioterapi, psikolog, ahli gizi, serta mendukung keluarga untuk berperan aktif dalam perawatan sehari-hari lansia. Kolaborasi ini memungkinkan penyusunan rencana asuhan yang lebih akurat, individual, dan berkesinambungan bagi lansia, sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup lansia yang mengalami sindrom geriatri.

E. Pencegahan Sindrom Geriatri Melalui Edukasi Keluarga dan Lansia

Pencegahan sindrom geriatri merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan lansia, terutama dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal di masa tua. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mencegah atau setidaknya mengurangi risiko terjadinya sindrom geriatri adalah melalui edukasi kesehatan yang terencana dengan baik, yang ditujukan tidak hanya bagi lansia tetapi juga bagi keluarganya. Edukasi kesehatan ini merupakan upaya proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta

keterampilan keluarga dan lansia dalam menghadapi tantangan kesehatan terkait proses penuaan.

Materi edukasi yang perlu diberikan kepada keluarga dan lansia mencakup berbagai aspek penting dari sindrom geriatri seperti risiko jatuh, inkontinensia urin, dan delirium. Untuk risiko jatuh, materi edukasi dapat meliputi pentingnya menjaga lingkungan rumah tetap aman seperti menyediakan pencahayaan yang cukup, memastikan lantai tidak licin, memasang pegangan tangan atau railing di area berisiko seperti kamar mandi atau tangga, serta memilih alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Selain itu, keluarga dan lansia juga harus memahami pentingnya latihan fisik rutin seperti latihan keseimbangan, latihan kekuatan otot, dan aktivitas mobilitas ringan yang secara signifikan mampu mengurangi risiko jatuh. Pengetahuan tentang cara aman bergerak, posisi tubuh yang benar ketika bangun dari duduk atau tidur, serta penggunaan alat bantu jalan juga perlu disampaikan agar lansia lebih percaya diri dan aman dalam beraktivitas sehari-hari.

Materi edukasi terkait inkontinensia urin mencakup penjelasan mengenai pentingnya menjaga pola minum yang teratur, tidak mengurangi asupan cairan secara berlebihan karena takut inkontinensia, serta pelatihan teknik dasar untuk memperkuat otot panggul seperti latihan Kegel. Keluarga juga perlu diberikan pemahaman bahwa inkontinensia urin bukan kondisi yang harus disembunyikan atau dibiarkan begitu saja, melainkan suatu kondisi yang dapat dikelola dengan tepat. Materi ini dapat mencakup panduan mengenai cara menjaga kebersihan area genital, mengenali tanda-tanda infeksi saluran kemih, serta bagaimana mendukung lansia agar tetap percaya diri meskipun menghadapi masalah ini.

Selanjutnya, dalam hal delirium, edukasi yang perlu diberikan kepada keluarga meliputi tanda-tanda dini delirium seperti perubahan perilaku yang mendadak, gangguan orientasi terhadap tempat, waktu atau orang, gangguan pola tidur, dan gangguan perhatian secara mendadak. Penting juga untuk mengajarkan keluarga tentang langkah preventif seperti memastikan kecukupan cairan, nutrisi seimbang, serta pentingnya menjaga pola tidur yang baik pada lansia. Keluarga juga harus memahami risiko delirium yang dapat meningkat akibat penggunaan obat-obatan tertentu, sehingga perlu adanya pengawasan terhadap konsumsi obat oleh lansia.

Dalam penyampaian materi edukasi tersebut, strategi komunikasi yang efektif memegang peranan yang sangat penting. Komunikasi harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh lansia maupun keluarganya, serta diberikan secara perlahan agar keluarga dan lansia mampu mencerna informasi tersebut secara optimal. Perawat perlu menggunakan teknik komunikasi yang empatik, sabar, dan mendengarkan dengan aktif, sehingga lansia maupun keluarga merasa nyaman untuk bertanya dan menyampaikan keluhan atau

kekhawatiran yang mereka alami. Strategi seperti diskusi kelompok, tanya jawab, maupun demonstrasi langsung sangat dianjurkan untuk membantu lansia dan keluarga memahami materi secara lebih konkret dan aplikatif.

Selain materi edukasi dan strategi komunikasi, ada keterampilan khusus yang harus diajarkan kepada keluarga maupun lansia untuk mencegah sindrom geriatri. Misalnya, keterampilan mobilisasi yang aman bagi lansia seperti cara berpindah posisi dari tempat tidur ke kursi roda atau toilet, keterampilan dalam membantu lansia berpakaian, mandi, dan makan, serta keterampilan untuk mendampingi lansia saat berjalan atau menggunakan alat bantu jalan. Keluarga juga harus dilatih secara khusus dalam teknik bladder training yang membantu lansia memiliki pola berkemih yang lebih teratur, serta teknik latihan Kegel secara sederhana namun efektif dalam mengelola inkontinensia urin.

Untuk mencegah delirium, keluarga perlu diajarkan keterampilan dalam mengidentifikasi perubahan perilaku yang halus namun signifikan, teknik stimulasi kognitif sederhana seperti mengajak lansia berbicara secara aktif tentang aktivitas sehari-hari, serta menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman agar lansia tidak mengalami kebingungan atau kecemasan yang berlebihan. Keluarga juga harus tahu bagaimana memastikan lansia terhidrasi dengan baik, serta memperhatikan tanda-tanda dini dehidrasi atau gangguan metabolik yang dapat memicu delirium.

F. Studi Kasus Penanganan Sindrom Geriatri Berbasis Bukti

Studi kasus merupakan salah satu pendekatan penting yang memberikan gambaran nyata mengenai penerapan intervensi keperawatan berbasis bukti dalam mengelola sindrom geriatri pada lansia. Studi kasus berikut akan memaparkan beberapa contoh nyata dari intervensi keperawatan efektif yang berhasil diterapkan, sekaligus menganalisis langkah-langkah intervensi tersebut secara terperinci, serta mengevaluasi hasil akhirnya terhadap kondisi lansia secara menyeluruh.

Salah satu contoh kasus nyata adalah seorang perempuan lansia berusia 78 tahun yang mengalami sindrom geriatri berupa jatuh berulang kali di rumahnya. Dari hasil pengkajian awal, diketahui bahwa lansia ini memiliki riwayat osteoarthritis lutut kanan, penglihatan yang buruk, serta mengalami penurunan keseimbangan tubuh. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim keperawatan memutuskan untuk melakukan intervensi preventif dengan modifikasi lingkungan di rumah lansia, seperti pemasangan pegangan tangan di sekitar kamar mandi dan area tangga, memperbaiki pencahayaan di setiap ruangan terutama malam hari, dan memastikan lantai selalu bersih serta tidak licin. Selain itu, dilakukan intervensi promotif dengan melatih lansia melakukan latihan keseimbangan sederhana selama 20 menit setiap

hari yang dibantu oleh keluarga. Intervensi rehabilitatif juga diberikan melalui kolaborasi dengan fisioterapis berupa latihan penguatan otot kaki untuk memperbaiki stabilitas saat berjalan. Setelah tiga bulan pelaksanaan intervensi tersebut, evaluasi menunjukkan hasil yang positif, yaitu frekuensi jatuh berkurang secara signifikan, lansia menjadi lebih percaya diri saat melakukan aktivitas sehari-hari, dan keluarga merasa lebih tenang karena lingkungan rumah sudah menjadi lebih aman bagi lansia.

Pada kasus kedua, seorang lansia laki-laki berusia 80 tahun mengalami inkontinensia urin yang berat, di mana lansia sering mengalami kebocoran urin terutama saat malam hari atau ketika terburu-buru ke toilet. Pengkajian menunjukkan bahwa lansia memiliki riwayat diabetes melitus selama lebih dari 10 tahun serta kelemahan otot dasar panggul. Intervensi keperawatan berbasis bukti yang diterapkan mencakup bladder training atau latihan pengaturan waktu berkemih setiap 2 hingga 3 jam, serta pemberian edukasi kepada lansia dan keluarganya mengenai teknik latihan Kegel yang harus dilakukan secara rutin dua kali sehari. Keluarga juga diberikan edukasi tentang cara memastikan asupan cairan yang cukup serta menghindari minuman yang dapat memperburuk kondisi seperti kafein atau minuman bersoda. Setelah dua bulan pelaksanaan intervensi, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa lansia menunjukkan perbaikan nyata dalam mengontrol berkemihnya, frekuensi kebocoran urin berkurang drastis, lansia merasa lebih nyaman, serta kualitas tidurnya meningkat karena tidak lagi sering terbangun akibat kebocoran urin.

Kasus ketiga melibatkan lansia perempuan berusia 82 tahun yang dirawat di rumah sakit karena pneumonia, namun selama masa perawatan mengalami delirium akut dengan gejala berupa agitasi, disorientasi waktu dan tempat, serta gangguan tidur yang parah. Pengkajian awal mengidentifikasi bahwa lansia mengalami delirium akibat infeksi akut yang diperparah oleh lingkungan rumah sakit yang kurang familiar, kebisingan, serta pola tidur yang terganggu. Intervensi keperawatan yang diterapkan meliputi pendekatan kuratif berupa kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik untuk mengatasi pneumonia, serta pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi ringan. Selain itu, dilakukan intervensi psikososial berupa pendekatan realitas dan orientasi secara konsisten, menciptakan lingkungan rumah sakit yang tenang dengan pengaturan cahaya redup saat malam hari, serta melibatkan keluarga untuk menemani lansia secara bergantian untuk memberikan rasa nyaman dan aman. Setelah satu minggu pelaksanaan intervensi ini, kondisi lansia secara bertahap membaik, agitasi dan kebingungan berkurang secara nyata, lansia kembali mampu mengenali keluarga dan tempat, serta pola tidur kembali normal. Setelah dua minggu, evaluasi akhir menunjukkan delirium telah

teratasi sepenuhnya, pneumonia membaik signifikan, dan lansia siap untuk pulang ke rumah dalam kondisi yang jauh lebih stabil.

Analisis terhadap langkah-langkah intervensi dalam studi kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan intervensi keperawatan yang bersifat holistik dan berbasis bukti. Keberhasilan intervensi dalam mengelola sindrom geriatri sangat tergantung pada kombinasi tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dirancang secara spesifik berdasarkan hasil pengkajian yang cermat. Faktor kunci lainnya adalah kolaborasi erat antara perawat dengan tim multidisiplin yang mencakup dokter, fisioterapis, ahli gizi, psikolog, serta peran aktif keluarga lansia yang memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan intervensi sehari-hari.

Evaluasi dari masing-masing studi kasus secara konsisten memperlihatkan bahwa penerapan intervensi keperawatan berbasis bukti tidak hanya mampu memperbaiki gejala atau kondisi fisik lansia secara signifikan, tetapi juga mampu meningkatkan aspek psikologis dan sosial yang sebelumnya terganggu oleh sindrom geriatri. Dalam jangka panjang, intervensi ini terbukti mampu mengembalikan kemandirian lansia, meningkatkan rasa percaya diri, serta secara signifikan meningkatkan kualitas hidup lansia maupun keluarganya.

G. Evaluasi Keberhasilan Asuhan Keperawatan pada Sindrom Geriatri

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam asuhan keperawatan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan intervensi yang diterapkan telah tercapai. Dalam konteks asuhan keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri, evaluasi tidak hanya dilakukan untuk mengetahui efektivitas intervensi secara klinis semata, melainkan juga bertujuan mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan lansia secara komprehensif. Dengan evaluasi yang dilakukan secara tepat, perawat dapat menentukan apakah intervensi yang diberikan telah berhasil, apakah perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian intervensi, atau bahkan memutuskan apakah ada kebutuhan untuk melibatkan tim multidisiplin lebih lanjut.

Keberhasilan asuhan keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri dapat diketahui melalui berbagai indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Indikator ini mencakup aspek fisik, psikologis, fungsional, dan sosial. Pada aspek fisik, indikator keberhasilan dapat berupa berkurangnya frekuensi jatuh, meningkatnya stabilitas dan keseimbangan tubuh lansia, meningkatnya kemampuan kontrol berkemih sehingga frekuensi inkontinensia urin berkurang, serta teratasinya gejala delirium seperti agitasi, disorientasi, dan gangguan tidur. Indikator psikologis dapat dilihat melalui penurunan tingkat kecemasan atau stres lansia, meningkatnya rasa

percaya diri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta perasaan nyaman dan aman dalam lingkungan rumah maupun lingkungan perawatan.

Indikator keberhasilan dalam aspek fungsional dapat diukur dengan meningkatnya tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity of Daily Living/ADL), seperti mandi, berpakaian, makan, mobilisasi, serta penggunaan toilet secara mandiri. Sedangkan indikator sosial dapat dilihat melalui meningkatnya interaksi sosial lansia, berkurangnya isolasi sosial akibat kondisi inkontinensia atau takut jatuh, serta meningkatnya keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan kepada lansia secara aktif.

Metode evaluasi yang efektif dalam asuhan keperawatan pada sindrom geriatri harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti pengkajian ulang kondisi fisik lansia secara teratur, observasi langsung terhadap kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, wawancara mendalam dengan lansia dan keluarganya mengenai perasaan dan persepsi mereka tentang perbaikan yang terjadi, serta menggunakan instrumen evaluasi standar seperti Morse Fall Scale untuk jatuh, Bladder Diary atau Incontinence Questionnaire untuk inkontinensia urin, serta Confusion Assessment Method (CAM) untuk delirium.

Pengkajian ulang kondisi fisik lansia penting untuk mengetahui perubahan objektif yang telah dicapai setelah intervensi dilakukan. Misalnya, pada kasus risiko jatuh, perawat dapat mengevaluasi stabilitas berjalan lansia, kemampuan lansia dalam menjaga keseimbangan tubuh, serta mencatat frekuensi kejadian jatuh yang terjadi setelah pelaksanaan intervensi. Pada kasus inkontinensia urin, evaluasi dapat berupa pencatatan pola berkemih lansia, frekuensi kebocoran urin, serta tingkat ketergantungan pada alat bantu seperti popok. Sedangkan untuk delirium, evaluasi berfokus pada pengamatan terhadap tingkat kesadaran, orientasi waktu, tempat, dan orang, serta adanya perubahan perilaku atau sikap lansia selama masa perawatan.

Observasi langsung terhadap kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari juga merupakan metode evaluasi yang sangat bermanfaat. Melalui observasi, perawat dapat melihat langsung apakah lansia mengalami kesulitan atau perbaikan dalam melakukan aktivitas tertentu, seperti berjalan menuju kamar mandi, makan, berpakaian, atau bahkan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Observasi ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana intervensi keperawatan telah mempengaruhi kemampuan fungsional lansia secara langsung.

Wawancara mendalam dengan lansia dan keluarga juga menjadi bagian penting dari evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan. Melalui wawancara, perawat dapat menggali lebih dalam bagaimana lansia dan keluarga merasakan manfaat dari

intervensi yang telah diberikan, apakah mereka merasa lebih nyaman, percaya diri, serta mampu mengelola kondisi kesehatan dengan lebih baik. Informasi ini sangat berharga karena merefleksikan perubahan yang dialami lansia dan keluarganya dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Setelah dilakukan evaluasi, perawat perlu melakukan analisis terhadap hasil evaluasi tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka intervensi tersebut dapat dipertahankan dan diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, jika evaluasi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan atau belum sepenuhnya berhasil, perawat harus segera menyesuaikan atau memodifikasi intervensi yang diberikan. Penyesuaian intervensi ini dapat berupa peningkatan frekuensi pelatihan, penambahan jenis latihan fisik yang lebih intensif, atau bahkan melibatkan ahli lain dalam tim multidisiplin seperti dokter, fisioterapis, atau psikolog untuk memberikan intervensi tambahan.

H. Tantangan dalam Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Sindrom Geriatri

Dalam implementasi asuhan keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri, terdapat berbagai tantangan yang sering muncul, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistem pelayanan kesehatan. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas pemberian asuhan keperawatan, sehingga menjadi penting bagi tenaga keperawatan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola tantangan tersebut agar intervensi yang diberikan dapat mencapai hasil yang optimal.

Salah satu tantangan utama yang kerap ditemui adalah tantangan komunikasi. Lansia dengan sindrom geriatri sering mengalami penurunan kemampuan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, akibat gangguan fungsi kognitif, pendengaran, atau penglihatan. Kondisi seperti delirium, demensia, gangguan pendengaran terkait usia (presbikusis), serta masalah penglihatan seperti katarak sangat umum terjadi, sehingga menyulitkan lansia dalam memahami instruksi atau informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Selain itu, lansia juga cenderung lebih lambat dalam memproses informasi dan memerlukan penjelasan yang berulang agar benar-benar memahami instruksi yang diberikan. Kondisi tersebut menuntut tenaga keperawatan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sabar, empatik, dan mampu menggunakan berbagai strategi seperti penggunaan bahasa tubuh, gerakan tangan, alat bantu komunikasi visual, serta pendekatan komunikasi terapeutik yang jelas dan sederhana. Jika tidak ditangani secara efektif, tantangan komunikasi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses perawatan, yang

berpotensi menurunkan efektivitas intervensi yang diberikan dan meningkatkan risiko munculnya komplikasi lainnya.

Selanjutnya, tantangan sumber daya juga sering menjadi hambatan serius dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri. Di banyak tempat, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas, sumber daya seperti tenaga perawat yang terlatih dalam perawatan geriatri masih kurang. Rasio perawat terhadap pasien lansia sering kali tidak memadai, yang menyebabkan perawat menghadapi beban kerja yang tinggi sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang cukup intensif kepada masing-masing lansia. Selain keterbatasan tenaga, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala utama. Misalnya, masih minimnya alat bantu seperti pegangan tangan atau railing di rumah sakit atau panti lansia yang dapat membantu mencegah jatuh, kurangnya popok dewasa atau alat bantu inkontinensia urin yang memadai, serta keterbatasan alat untuk mendukung mobilisasi lansia seperti kursi roda, tongkat, atau walker. Kondisi ini menyebabkan perawat mengalami kesulitan dalam memberikan intervensi secara optimal. Tantangan sumber daya ini juga berkaitan erat dengan minimnya dana yang dialokasikan untuk layanan geriatri, sehingga menyebabkan terbatasnya investasi dalam pelatihan tenaga kesehatan dan pengadaan alat bantu yang mendukung kenyamanan dan keselamatan lansia.

Di samping tantangan komunikasi dan sumber daya, tantangan multidisiplin juga menjadi kendala yang signifikan dalam praktik asuhan keperawatan lansia. Sindrom geriatri merupakan kondisi kompleks yang sering kali tidak bisa diatasi hanya oleh satu disiplin ilmu kesehatan saja. Dibutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga keperawatan, dokter, fisioterapis, ahli gizi, psikolog, terapis okupasi, serta pekerja sosial. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dan komunikasi antar tenaga profesional multidisiplin sering kali masih kurang optimal. Masing-masing disiplin sering bekerja dalam "silo" atau kelompok tersendiri tanpa adanya komunikasi efektif antarprofesional, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksepahaman dalam penyusunan rencana perawatan yang komprehensif. Ketidakharmonisan atau kurangnya komunikasi antarprofesional ini dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih intervensi, ketidakjelasan tanggung jawab, atau bahkan terjadinya gap dalam pemberian layanan, sehingga lansia tidak mendapatkan manfaat penuh dari perawatan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan usaha ekstra untuk membangun kolaborasi multidisiplin yang kuat, misalnya dengan menyelenggarakan pertemuan reguler antar anggota tim, penyusunan panduan kerja bersama, serta pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing disiplin.

Selain ketiga tantangan utama tersebut, tantangan lain yang juga harus diperhatikan adalah keterlibatan keluarga. Dalam budaya tertentu, keluarga menjadi elemen penting dalam perawatan lansia. Namun, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam merawat lansia sering kali menjadi hambatan tersendiri. Banyak keluarga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pencegahan dan deteksi dini sindrom geriatri, sehingga mereka cenderung menganggap keluhan lansia sebagai sesuatu yang normal dan tidak memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini dapat memperlambat proses identifikasi dini, yang pada akhirnya memperburuk prognosis lansia. Oleh karena itu, tantangan ini memerlukan intervensi edukasi keluarga yang intensif agar mereka dapat memahami dan mengambil peran aktif dalam mendukung perawatan lansia sehari-hari.

Terakhir, tantangan yang juga tak kalah penting adalah faktor psikologis lansia itu sendiri. Banyak lansia dengan sindrom geriatri yang mengalami depresi, ansietas, atau isolasi sosial yang menyebabkan mereka kurang termotivasi dalam menjalankan intervensi yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Perasaan tidak berguna, kesepian, atau rasa malu akibat kondisi inkontinensia atau sering jatuh juga dapat mengurangi tingkat partisipasi lansia dalam perawatan. Tantangan ini membutuhkan intervensi yang sifatnya suportif dan psikologis, seperti pemberian dukungan emosional, konseling, serta pendampingan secara empatik dari tenaga keperawatan maupun keluarga.

I. Simpulan

Sindrom geriatri merupakan tantangan besar dalam asuhan keperawatan lansia yang mencakup berbagai kondisi kompleks seperti jatuh, inkontinensia urin, dan delirium. Ketiga kondisi tersebut tidak berdiri sendiri tetapi sering kali saling berhubungan, sehingga memperparah kondisi lansia dan mengganggu kualitas hidupnya secara signifikan. Untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif pada lansia dengan sindrom geriatri, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi pengkajian yang komprehensif, intervensi berbasis bukti, evaluasi yang sistematis, serta edukasi kesehatan yang intensif baik kepada lansia maupun keluarganya.

Pengkajian yang tepat merupakan langkah awal yang penting untuk mendeteksi dini sindrom geriatri, meliputi pengkajian fisik, skrining cepat, observasi klinis, penggunaan instrumen khusus, serta wawancara mendalam dengan lansia dan keluarganya. Intervensi keperawatan yang efektif mencakup aspek preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif, dengan melibatkan kolaborasi multidisiplin yang mencakup dokter, fisioterapis, psikolog, ahli gizi, serta dukungan keluarga.

Edukasi keluarga dan lansia merupakan bagian integral dari strategi pencegahan sindrom geriatri. Melalui edukasi yang sistematis dan terencana, lansia dan keluarga dapat memahami secara mendalam berbagai faktor risiko sindrom geriatri serta cara mengelolanya dengan benar. Strategi ini mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan keluarga dalam mendukung lansia, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Implementasi asuhan keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan komunikasi akibat gangguan kognitif dan sensorik lansia, keterbatasan sumber daya baik berupa tenaga maupun fasilitas kesehatan, tantangan multidisiplin berupa koordinasi antarprofesi, serta tantangan psikologis yang dialami lansia dan keluarganya. Mengatasi tantangan tersebut memerlukan upaya ekstra dari perawat untuk mengembangkan keterampilan komunikasi empatik, meningkatkan kolaborasi multidisiplin, serta melibatkan keluarga secara aktif.

J. Referensi

- Abdi, S., Spann, A., Borilovic, J., De Witte, L., & Hawley, M. (2019). Understanding the care and support needs of older people: A scoping review and categorisation using the WHO international classification of functioning, disability and health framework (ICF). *BMC Geriatrics*, 19(1), 195. <https://doi.org/10.1186/s12877-019-1189-9>
- American Geriatrics Society. (2020). Updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 68(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/jgs.15767>
- Buurman, B. M., Frenkel, W. J., Abu-Hanna, A., Parlevliet, J. L., & de Rooij, S. E. (2016). Acute and chronic diseases as part of multimorbidity in acutely hospitalized older patients. *European Journal of Internal Medicine*, 27, 68–75. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2015.07.006>
- Clegg, A., Young, J., Iliffe, S., Rikkert, M. O., & Rockwood, K. (2013). Frailty in elderly people. *The Lancet*, 381(9868), 752–762. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)62167-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)62167-9)
- Inouye, S. K., Westendorp, R. G. J., & Saczynski, J. S. (2014). Delirium in elderly people. *The Lancet*, 383(9920), 911–922. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60688-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60688-1)
- Kojima, G. (2015). Frailty as a predictor of future falls among community-dwelling older people: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Medical Directors Association*, 16(12), 1027–1033. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.06.018>
- Mauk, K. L. (2017). *Gerontological nursing: Competencies for care* (4th ed.). Jones &

Bartlett Learning.

- Morley, J. E. (2017). Frailty and sarcopenia in elderly. *Wiener Klinische Wochenschrift*, 129(Suppl 7), 439–445. <https://doi.org/10.1007/s00508-017-1244-6>
- Resnick, B., & Boltz, M. (Eds.). (2018). *Geriatric nursing review syllabus: A core curriculum in advanced practice geriatric nursing* (5th ed.). American Geriatrics Society.
- Stewart Williams, J., Kowal, P., Hestekin, H., O'Driscoll, T., Peltzer, K., & Yawson, A. (2015). Prevalence, risk factors and disability associated with fall-related injury in older adults in low- and middle-income countries: Results from the WHO Study on Global AGEing and Adult Health (SAGE). *BMC Medicine*, 13(1), 147. <https://doi.org/10.1186/s12916-015-0390-8>
- World Health Organization (WHO). (2015). *World report on ageing and health*. WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2017). *Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*. WHO Press.
- Yoshida, Y., Iwasa, H., Kumagai, S., Suzuki, T., & Yoshida, H. (2014). Risk factors for urinary incontinence in community-dwelling elderly Japanese women: A 7-year longitudinal study. *Journal of Urology*, 191(3), 863–870. <https://doi.org/10.1016/j.juro.2013.09.041>
- Zisberg, A., Sinoff, G., Gur-Yaish, N., Admi, H., & Shadmi, E. (2015). In-hospital use of continence aids and new-onset urinary incontinence in adults aged 70 and older. *Journal of the American Geriatrics Society*, 59(6), 1099–1104. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2011.03413.x>

K. Glosarium

Delirium

Gangguan akut yang ditandai oleh perubahan mendadak pada tingkat kesadaran, disorientasi waktu, tempat atau orang, gangguan perhatian, serta persepsi yang terganggu. Kondisi ini sering muncul secara tiba-tiba dan berlangsung dalam periode singkat, biasanya beberapa jam hingga beberapa hari.

Inkontinensia Urin

Kondisi kehilangan kontrol atas proses berkemih secara tidak sadar, yang menyebabkan kebocoran urin tanpa disengaja. Umumnya disebabkan oleh melemahnya otot panggul, gangguan neurologis, atau penyakit kronis seperti diabetes dan stroke.

Jatuh (Fall)

Kejadian yang menyebabkan seseorang secara tiba-tiba terjatuh ke lantai atau permukaan yang lebih rendah secara tidak sengaja. Pada lansia, jatuh sering

dikaitkan dengan cedera fisik serius, seperti patah tulang atau perdarahan internal, serta dampak psikologis seperti rasa takut berlebihan dan isolasi sosial.

Sindrom Geriatri

Kumpulan gejala atau kondisi klinis yang sering muncul bersamaan pada lansia, bukan sebagai penyakit tunggal tetapi akibat interaksi antara proses penuaan, penurunan cadangan fisiologis tubuh, dan faktor internal serta eksternal lainnya. Contoh sindrom geriatri antara lain jatuh, inkontinensia urin, dan delirium.

Pendekatan Holistik

Pendekatan dalam asuhan keperawatan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik pasien tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, emosional, dan lingkungan untuk mencapai hasil perawatan yang optimal secara keseluruhan.

Intervensi Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Praktik perawatan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru dan terbaik yang tersedia, serta dikombinasikan dengan keahlian klinis perawat dan preferensi pasien, bertujuan memberikan intervensi yang efektif dan efisien.

Teknik Pengkajian

Metode atau langkah-langkah spesifik yang digunakan perawat dalam mengumpulkan informasi secara objektif maupun subjektif mengenai kondisi kesehatan pasien, termasuk pemeriksaan fisik, wawancara, observasi klinis, dan penggunaan instrumen khusus.

Bladder Training

Latihan khusus untuk melatih kandung kemih agar dapat mengontrol berkemih secara teratur dengan tujuan mengurangi frekuensi inkontinensia urin pada pasien lansia.

Latihan Kegel

Latihan untuk memperkuat otot dasar panggul yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol berkemih dan mencegah inkontinensia urin.

Evaluasi Keperawatan

Proses penilaian sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan intervensi keperawatan tercapai, serta menentukan langkah lanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Instrumen Pengkajian

Alat atau skala pengukuran yang digunakan untuk mendeteksi secara dini kondisi-kondisi tertentu pada pasien, seperti Morse Fall Scale untuk risiko jatuh, Bladder Diary untuk inkontinensia urin, dan Confusion Assessment Method (CAM) untuk delirium.

Pendekatan Multidisiplin

Kolaborasi antar berbagai profesi kesehatan, seperti dokter, perawat, fisioterapis, psikolog, ahli gizi, dan tenaga profesional lainnya dalam memberikan asuhan yang komprehensif bagi pasien.

Stimulasi Kognitif

Aktivitas atau intervensi yang bertujuan meningkatkan atau mempertahankan fungsi kognitif pasien, seperti orientasi realitas dan terapi okupasi, yang umumnya diterapkan pada lansia yang mengalami delirium atau gangguan kognitif.

Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (Activity of Daily Living - ADL)

Aktivitas dasar sehari-hari yang mencakup mandi, berpakaian, makan, berpindah tempat, serta menggunakan toilet, yang menjadi indikator kemampuan fungsional seseorang terutama lansia.

Isolasi Sosial

Kondisi di mana seseorang menarik diri atau dijauhi dari interaksi sosial, sering disebabkan oleh kondisi kesehatan fisik atau psikologis seperti rasa malu akibat inkontinensia urin atau ketakutan jatuh.

CHAPTER 5

ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN PENYAKIT KRONIS

Ns. Riris Friandi, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit kronis merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang secara khusus diberikan kepada kelompok usia lanjut yang mengalami kondisi kesehatan dengan sifat progresif, berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan sering kali seumur hidup. Lansia merupakan populasi khusus dengan kebutuhan unik yang harus dipahami secara mendalam oleh tenaga kesehatan, terutama perawat, agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari kelompok usia ini. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupannya, baik itu dari sisi fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit kronis harus diberikan secara komprehensif dan terintegrasi, mencakup berbagai aspek penting tersebut agar dapat meningkatkan kualitas hidup lansia secara optimal.

Dari aspek fisik, lansia dengan penyakit kronis biasanya mengalami penurunan berbagai fungsi tubuh secara signifikan. Kondisi seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, serta gangguan muskuloskeletal merupakan beberapa contoh penyakit kronis yang umum terjadi pada populasi lansia. Penyakit-penyakit tersebut seringkali menimbulkan keterbatasan fisik, penurunan mobilitas, gangguan keseimbangan, hingga ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kondisi ini menuntut perawat untuk memiliki keterampilan klinis yang tinggi dalam mengelola berbagai gejala fisik, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup lansia. Intervensi fisik yang diberikan, seperti terapi gerak, latihan fisik, manajemen nyeri, hingga pemantauan rutin tanda vital dan status kesehatan, harus dirancang secara individual sesuai dengan kondisi dan kemampuan lansia.

Di sisi lain, kebutuhan psikologis lansia dengan penyakit kronis juga perlu mendapat perhatian serius dalam asuhan keperawatan. Lansia sering kali mengalami berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, perasaan kehilangan kontrol atas diri sendiri, hingga isolasi sosial yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya penyakit kronis. Kondisi psikologis

yang negatif ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan menurunkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perawat harus mampu memberikan dukungan psikologis secara efektif, termasuk di dalamnya teknik komunikasi terapeutik, konseling suportif, serta pendekatan empatik yang memungkinkan lansia merasa didengarkan, dihargai, dan didukung secara emosional. Perawat harus memiliki kemampuan dalam mendeteksi dini masalah psikologis serta mampu memberikan intervensi yang tepat untuk mencegah masalah psikologis yang lebih serius.

Selain aspek fisik dan psikologis, kebutuhan sosial lansia dengan penyakit kronis juga merupakan bagian penting yang tidak boleh terlewatkan dalam proses asuhan keperawatan. Lansia yang mengalami penyakit kronis biasanya menghadapi tantangan dalam mempertahankan hubungan sosial dan interaksi dengan keluarga, teman, maupun komunitas sekitar. Kondisi fisik yang menurun serta gejala-gejala penyakit yang berlangsung lama seringkali menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Akibatnya, mereka merasa terisolasi, kesepian, dan kehilangan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perawat harus mampu membantu lansia menjaga atau memperkuat jejaring sosialnya, seperti melibatkan keluarga dalam perawatan, mendorong partisipasi lansia dalam kegiatan komunitas, serta memfasilitasi berbagai bentuk aktivitas sosial yang sesuai dengan kemampuan lansia. Peran perawat dalam aspek ini sangat penting dalam memastikan bahwa lansia tetap merasa memiliki arti dan terhubung dengan lingkungan sosialnya.

Aspek spiritual juga menjadi elemen yang tak kalah penting dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit kronis. Lansia sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan spiritual yang muncul seiring dengan proses penuaan, seperti rasa takut menghadapi kematian, perasaan kehilangan makna hidup, serta kebutuhan akan ketenangan spiritual dalam menghadapi penderitaan yang dialami akibat penyakit kronis. Dalam hal ini, perawat memiliki peran untuk mengenali kebutuhan spiritual yang spesifik dari masing-masing lansia, menghormati keyakinan mereka, serta memberikan dukungan spiritual yang sesuai. Perawat dapat memfasilitasi lansia dalam melakukan aktivitas spiritual seperti berdoa, meditasi, atau praktik spiritual lainnya yang mampu memberikan rasa damai, harapan, serta makna yang lebih mendalam dalam kehidupan lansia.

B. Konsep Dasar Sindrom Geriatri (Jatuh, Inkontinensia Urin, Delirium)

Sindrom geriatri merupakan suatu kondisi klinis yang kompleks dan khas yang sering dialami oleh lansia, terutama yang menderita penyakit kronis. Sindrom geriatri tidak selalu merupakan bagian dari proses penuaan normal, tetapi lebih

sering terjadi akibat interaksi berbagai faktor risiko yang meningkat seiring bertambahnya usia. Sindrom geriatri yang paling sering ditemui dan perlu mendapat perhatian khusus dalam keperawatan gerontik di antaranya adalah jatuh, inkontinensia urin, serta delirium. Ketiga sindrom ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kualitas hidup lansia, sehingga pemahaman mendalam mengenai konsep dasar sindrom-sindrom tersebut menjadi kunci utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan komprehensif bagi lansia dengan penyakit kronis.

Sindrom jatuh pada lansia didefinisikan sebagai peristiwa di mana seorang lansia secara tiba-tiba jatuh ke lantai atau permukaan yang lebih rendah secara tidak sengaja, tanpa didahului oleh kehilangan kesadaran. Sindrom ini sering kali menjadi masalah yang serius dalam perawatan lansia karena berhubungan erat dengan berbagai komplikasi, seperti cedera ringan hingga berat, fraktur tulang, cedera kepala, hingga penurunan fungsi fisik dan meningkatnya ketergantungan terhadap orang lain. Penyebab utama terjadinya jatuh pada lansia dapat bersifat multifaktorial, mencakup faktor intrinsik seperti gangguan keseimbangan, penurunan kekuatan otot, gangguan penglihatan, efek samping obat-obatan, serta kondisi medis seperti stroke, diabetes mellitus, atau penyakit Parkinson. Faktor ekstrinsik yang berkontribusi antara lain kondisi lingkungan yang kurang aman seperti lantai licin, penerangan yang buruk, hingga keberadaan barang-barang yang dapat memicu tersandung. Dampak dari sindrom jatuh tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis, seperti munculnya rasa takut untuk jatuh kembali yang menyebabkan lansia membatasi aktivitas fisiknya, sehingga akhirnya menimbulkan isolasi sosial, kecemasan, serta depresi. Hal ini tentu saja secara signifikan akan menurunkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

Inkontinensia urin merupakan sindrom geriatri kedua yang juga sangat umum terjadi di kalangan lansia, terutama mereka yang memiliki penyakit kronis. Inkontinensia urin dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol buang air kecil, sehingga terjadi kebocoran urin secara tidak disengaja. Kondisi ini dapat bervariasi mulai dari kebocoran ringan yang terjadi saat batuk atau bersin, hingga inkontinensia total di mana lansia kehilangan kontrol penuh atas proses buang air kecil. Penyebab inkontinensia urin pada lansia antara lain adalah perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia seperti penurunan elastisitas otot dasar panggul, gangguan neurologis akibat stroke atau demensia, infeksi saluran kemih kronis, efek samping obat tertentu, serta pembesaran prostat pada lansia laki-laki. Faktor risiko lainnya meliputi obesitas, imobilitas, serta riwayat operasi pada organ panggul. Dampak inkontinensia urin terhadap lansia cukup besar, meliputi rasa malu, rendah diri, dan gangguan harga

diri, yang kemudian dapat menyebabkan lansia menarik diri dari interaksi sosial dan aktivitas rutin. Selain itu, inkontinensia urin juga berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi kulit akibat kelembaban terus-menerus, serta meningkatnya beban bagi keluarga dan pengasuh dalam memberikan perawatan.

Sindrom geriatri ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah delirium. Delirium merupakan gangguan kesadaran akut yang ditandai oleh perubahan mendadak dalam tingkat kesadaran, perhatian, serta fungsi kognitif lansia. Delirium biasanya berkembang dalam waktu singkat, bisa terjadi dalam hitungan jam atau hari, dan sering bersifat fluktuatif. Lansia dengan delirium biasanya mengalami disorientasi terhadap waktu, tempat, bahkan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga dapat mengalami halusinasi, perubahan perilaku seperti agitasi, gelisah, atau sebaliknya menjadi sangat lesu dan apatis. Penyebab delirium pada lansia sangat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan kombinasi berbagai faktor seperti infeksi akut (infeksi saluran kemih atau pneumonia), dehidrasi, efek samping obat-obatan, gangguan metabolik seperti hipoglikemia atau gangguan elektrolit, serta stres akibat rawat inap atau tindakan medis tertentu. Faktor risiko delirium semakin meningkat pada lansia dengan gangguan kognitif seperti demensia, lansia dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, serta lansia yang mengalami imobilisasi atau menjalani tindakan bedah. Dampak delirium sangat serius, karena selain menurunkan kualitas hidup, delirium juga berhubungan erat dengan meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas, perpanjangan masa rawat inap, peningkatan kebutuhan akan perawatan jangka panjang, serta meningkatkan risiko terjadinya gangguan kognitif permanen seperti demensia di kemudian hari.

Ketiga sindrom geriatri ini—jatuh, inkontinensia urin, dan delirium—tidak hanya berdiri sendiri-sendiri, namun sering kali saling terkait dan memperburuk satu sama lain, terutama pada lansia dengan penyakit kronis. Sebagai contoh, lansia yang mengalami inkontinensia urin mungkin terburu-buru menuju kamar mandi sehingga meningkatkan risiko jatuh. Lansia yang mengalami delirium sering kali menjadi bingung dan gelisah, sehingga juga meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perawat untuk memahami konsep dasar mengenai sindrom geriatri ini secara mendalam, termasuk mengenali faktor risiko, memahami penyebab serta mekanisme yang mendasarinya, serta memahami dampak fisik maupun psikologis yang timbul dari setiap sindrom ini. Pemahaman tersebut akan memungkinkan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif secara efektif dan tepat sasaran, sehingga kualitas hidup lansia dengan penyakit kronis tetap terjaga optimal.

C. Teknik Pengkajian dan Deteksi Dini Sindrom Geriatri

Pengkajian dan deteksi dini sindrom geriatri merupakan salah satu aspek penting dalam pemberian asuhan keperawatan pada lansia, terutama yang menderita penyakit kronis. Dengan melakukan pengkajian secara sistematis dan terstruktur, perawat mampu mengidentifikasi secara dini risiko dan kejadian sindrom geriatri yang umum terjadi, seperti jatuh, inkontinensia urin, serta delirium. Deteksi dini yang akurat dan tepat waktu sangat krusial, mengingat sindrom-sindrom tersebut memiliki dampak serius terhadap kualitas hidup lansia jika tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik sejak awal.

Salah satu teknik pengkajian sindrom geriatri yang penting adalah penggunaan alat ukur risiko jatuh, seperti Morse Fall Scale (MFS). Morse Fall Scale adalah instrumen pengkajian standar yang telah banyak digunakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi risiko jatuh pada lansia secara cepat dan efektif. Instrumen ini terdiri dari enam variabel penilaian, yaitu riwayat jatuh sebelumnya, diagnosis sekunder, penggunaan alat bantu ambulasi, pemasangan infus atau terapi intravena, gaya berjalan atau keseimbangan, dan status mental pasien. Setiap variabel diberikan skor tertentu berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi, yang kemudian dijumlahkan untuk menentukan tingkat risiko jatuh secara keseluruhan. Lansia dengan skor yang tinggi dikategorikan memiliki risiko tinggi untuk mengalami jatuh, sehingga memerlukan intervensi preventif segera. Penggunaan Morse Fall Scale membantu perawat untuk segera merancang rencana intervensi spesifik, seperti modifikasi lingkungan yang lebih aman, edukasi penggunaan alat bantu jalan, hingga edukasi mengenai pencegahan jatuh kepada keluarga dan lansia itu sendiri.

Selain risiko jatuh, perawat juga perlu melakukan pengkajian terhadap inkontinensia urin pada lansia sebagai bagian dari deteksi dini sindrom geriatri. Pengkajian inkontinensia urin dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, serta penggunaan instrumen skrining khusus yang terstandarisasi seperti International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ). Instrumen ini secara khusus dirancang untuk mengevaluasi frekuensi kebocoran urin, jumlah urin yang bocor, serta sejauh mana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari lansia. Selain itu, dalam pengkajian inkontinensia urin, perawat juga penting untuk mengevaluasi riwayat medis lansia secara lengkap, mengkaji penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan atau memperparah inkontinensia, serta melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi anatomi dan fungsi saluran kemih. Dengan informasi yang lengkap dan komprehensif dari hasil pengkajian tersebut, perawat mampu

mengidentifikasi lansia yang mengalami inkontinensia urin secara dini, serta merancang intervensi keperawatan yang tepat, mulai dari latihan penguatan otot dasar panggul hingga edukasi mengenai pola berkemih yang baik dan higienis.

Deteksi dini delirium pada lansia juga memerlukan metode dan instrumen khusus yang telah teruji secara klinis, salah satunya adalah Confusion Assessment Method (CAM). CAM merupakan instrumen yang dikembangkan secara khusus untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal delirium secara cepat dan akurat. Instrumen ini mencakup empat komponen utama yang harus dinilai, yaitu onset akut dan perubahan status mental secara fluktuatif, gangguan perhatian, pemikiran yang tidak terorganisasi, serta perubahan tingkat kesadaran. Dalam penggunaannya, CAM memerlukan observasi cermat oleh perawat yang mengenal kondisi pasien dengan baik. Jika ditemukan setidaknya dua tanda utama (onset akut dengan fluktuasi dan gangguan perhatian), serta minimal satu tanda tambahan seperti gangguan pemikiran atau perubahan tingkat kesadaran, maka lansia tersebut dianggap positif mengalami delirium. Selain instrumen CAM, pengkajian delirium juga melibatkan evaluasi faktor risiko seperti penggunaan obat-obatan tertentu, infeksi akut, gangguan metabolik, serta faktor lingkungan yang dapat memicu stres atau kecemasan pada lansia. Penggunaan CAM secara rutin di rumah sakit atau fasilitas pelayanan lansia lainnya membantu perawat dalam mengidentifikasi delirium sejak dini, sehingga dapat segera mengambil langkah intervensi yang diperlukan seperti pengelolaan lingkungan, pemberian orientasi waktu dan tempat secara teratur, serta kolaborasi dengan tim medis untuk mengatasi penyebab dasar delirium.

D. Intervensi Keperawatan Efektif pada Sindrom Geriatri

Intervensi keperawatan yang efektif pada sindrom geriatri merupakan komponen penting dalam memberikan asuhan yang komprehensif pada lansia dengan penyakit kronis. Lansia yang menderita penyakit kronis cenderung mengalami beberapa kondisi yang khas terkait penuaan, seperti risiko jatuh yang meningkat, inkontinensia urin, serta kondisi delirium. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan intervensi yang spesifik dan berbasis bukti untuk mengatasi masalah ini guna meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

Salah satu intervensi utama yang penting dilakukan adalah manajemen lingkungan fisik untuk mencegah risiko jatuh pada lansia. Pengaturan lingkungan yang aman dan nyaman menjadi sangat penting karena lansia sering mengalami penurunan fungsi fisik, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, dan mobilitas yang terbatas. Untuk mengurangi risiko jatuh, perawat perlu memastikan bahwa area tempat tinggal lansia bebas dari hambatan seperti karpet yang licin atau

kabel yang berserakan. Selain itu, penerangan yang cukup di semua area rumah, terutama pada malam hari, juga sangat membantu lansia dalam beraktivitas secara aman. Pemasangan pegangan tangan di kamar mandi dan toilet juga menjadi langkah penting untuk membantu lansia menjaga keseimbangan saat berpindah posisi atau berdiri. Penempatan barang-barang kebutuhan sehari-hari lansia di tempat yang mudah dijangkau tanpa perlu menggunakan alat bantu tinggi juga merupakan strategi efektif untuk mengurangi risiko jatuh. Intervensi ini terbukti efektif karena menciptakan kondisi yang aman, sehingga lansia merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam aktivitas sehari-hari.

Intervensi berikutnya yang efektif adalah latihan kandung kemih atau bladder training untuk mengatasi inkontinensia urin. Inkontinensia urin merupakan kondisi yang sering dialami oleh lansia, terutama mereka dengan penyakit kronis seperti diabetes atau stroke. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif secara fisik, tetapi juga menyebabkan gangguan emosional seperti malu, isolasi sosial, dan penurunan harga diri. Latihan kandung kemih merupakan intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kontrol lansia terhadap fungsi berkemihnya melalui jadwal berkemih yang teratur. Dalam pelaksanaannya, perawat akan membantu lansia untuk merancang jadwal pergi ke toilet secara rutin, misalnya setiap 2-3 jam sekali, dengan tujuan memperkuat kapasitas kandung kemih secara bertahap. Selain itu, latihan penguatan otot dasar panggul atau latihan Kegel juga penting untuk memperkuat otot-otot yang berperan dalam mengendalikan aliran urin. Perawat perlu secara aktif memberikan edukasi serta dukungan kepada lansia dan keluarga selama pelaksanaan intervensi ini. Dengan konsistensi dan motivasi yang baik, latihan ini terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi kebocoran urin, meningkatkan rasa percaya diri lansia, serta membantu mereka menjalani kehidupan sosial yang lebih aktif dan nyaman.

Selain dua intervensi di atas, pengelolaan delirium juga memerlukan perhatian khusus dari perawat melalui intervensi nonfarmakologis. Delirium adalah gangguan kognitif akut yang sering dialami oleh lansia, khususnya pada mereka yang memiliki penyakit kronis atau menjalani perawatan intensif. Kondisi ini ditandai oleh kebingungan mendadak, perubahan kesadaran, gangguan perhatian, hingga perubahan perilaku yang signifikan. Intervensi nonfarmakologis menjadi pendekatan utama karena terbukti aman dan efektif untuk mengelola delirium tanpa menambah risiko efek samping akibat obat-obatan. Salah satu teknik intervensi nonfarmakologis yang efektif adalah orientasi realitas secara teratur. Dalam teknik ini, perawat secara rutin memberikan informasi mengenai waktu, tempat, dan situasi kepada lansia dengan cara yang lembut dan jelas. Penggunaan jam, kalender, serta benda-benda yang familiar juga membantu lansia menjaga orientasinya terhadap

lingkungan. Selain itu, menciptakan lingkungan yang tenang dan stabil, seperti menghindari kebisingan yang berlebihan dan menjaga pencahayaan yang sesuai dengan siklus tidur dan bangun lansia, sangat membantu dalam mengurangi agitasi serta mempercepat pemulihan kondisi delirium.

Intervensi nonfarmakologis lainnya yang terbukti efektif dalam mengatasi delirium adalah peningkatan stimulasi sensorik dan komunikasi terapeutik. Perawat dapat mengajak lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas sederhana seperti berbicara ringan, mendengarkan musik yang disukai, atau aktivitas relaksasi yang lembut seperti sentuhan terapeutik. Kegiatan ini membantu mengurangi kecemasan dan kebingungan lansia, menciptakan rasa aman, serta meningkatkan kenyamanan mereka secara emosional. Dukungan keluarga juga merupakan faktor penting dalam intervensi nonfarmakologis ini, karena kehadiran keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang kuat serta mempercepat pemulihan lansia dari delirium. Oleh sebab itu, perawat juga bertugas memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara memberikan dukungan emosional serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi lansia yang mengalami delirium.

E. Pencegahan Sindrom Geriatri Melalui Edukasi Keluarga dan Lansia

Pencegahan sindrom geriatri melalui edukasi keluarga dan lansia merupakan langkah penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada populasi lanjut usia, khususnya mereka yang hidup dengan penyakit kronis. Sindrom geriatri seperti risiko jatuh, inkontinensia urin, dan delirium sering kali menyebabkan dampak serius terhadap kualitas hidup lansia, sehingga penting untuk menerapkan strategi pencegahan yang efektif. Salah satu pendekatan utama dalam pencegahan tersebut adalah dengan memberikan edukasi kesehatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan kepada lansia dan keluarga mereka.

Edukasi kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks keperawatan gerontik karena tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi umum yang dialami lansia, tetapi juga membangun kesadaran dan keterampilan keluarga serta lansia sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring bertambahnya usia. Melalui edukasi yang tepat dan efektif, lansia serta keluarga dapat mengantisipasi risiko munculnya sindrom geriatri, mengenali tanda-tanda dini dari kondisi tersebut, serta mampu melakukan intervensi sederhana secara mandiri sebelum kondisi menjadi lebih serius.

Dalam pelaksanaan edukasi ini, perawat memainkan peran sentral sebagai edukator yang terampil. Perawat perlu memahami bahwa lansia dan keluarganya sering kali memiliki keterbatasan dalam mengolah informasi yang kompleks, sehingga penting bagi perawat untuk menggunakan teknik edukasi yang sederhana,

mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang keluarga maupun lansia yang menjadi sasaran edukasi. Perawat juga harus memastikan bahwa informasi yang diberikan relevan dengan kehidupan sehari-hari lansia, sehingga mereka dapat langsung mempraktikkan pengetahuan yang diterima.

Salah satu teknik edukasi yang sangat efektif dalam pencegahan sindrom geriatri adalah pendekatan yang interaktif dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, edukasi tidak hanya diberikan secara pasif dalam bentuk ceramah atau penjelasan, tetapi juga melibatkan lansia dan keluarga secara aktif dalam diskusi, demonstrasi, serta praktik langsung. Contohnya, untuk mencegah risiko jatuh pada lansia, perawat bisa memberikan demonstrasi tentang bagaimana cara aman berdiri dan berjalan, penggunaan alat bantu berjalan seperti tongkat atau walker, serta mengatur lingkungan rumah agar lebih aman. Kemudian, perawat meminta lansia dan keluarga untuk mempraktikkan langsung keterampilan tersebut agar mereka lebih memahami dan terbiasa dengan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan.

Pendekatan edukasi lainnya yang efektif adalah dengan menggunakan media visual dan tertulis yang sederhana. Perawat dapat memanfaatkan alat bantu edukasi seperti brosur, pamflet, gambar, atau video yang jelas dan menarik untuk memperjelas pesan-pesan penting yang ingin disampaikan. Materi edukasi yang tertulis juga sangat berguna sebagai referensi bagi lansia dan keluarga agar dapat mengulang kembali informasi yang diberikan oleh perawat secara mandiri di rumah. Misalnya, brosur yang berisi langkah-langkah sederhana dalam mencegah inkontinensia urin, seperti jadwal latihan kandung kemih dan latihan Kegel, bisa membantu lansia dan keluarga memahami dengan baik intervensi yang bisa mereka lakukan secara mandiri.

Selain itu, perawat juga perlu menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga dalam edukasi kesehatan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung lansia, baik secara fisik maupun emosional. Edukasi yang diberikan kepada keluarga perlu mencakup bagaimana mendukung lansia dalam menjaga rutinitas harian yang sehat, memberikan stimulasi kognitif dan fisik secara teratur, serta menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan aman. Perawat juga harus memastikan bahwa keluarga mampu mengenali tanda-tanda awal dari sindrom geriatri, seperti kebingungan mendadak yang bisa menjadi indikasi delirium, atau perubahan pola berkemih yang dapat menjadi tanda awal inkontinensia urin.

Di sisi lain, penting juga untuk memberikan edukasi yang mengacu pada aspek psikologis dan emosional. Lansia dengan penyakit kronis sering kali merasa stres, cemas, atau bahkan depresi akibat tantangan fisik maupun psikologis yang

dihadapinya. Oleh karena itu, edukasi yang diberikan juga perlu mencakup teknik-teknik relaksasi sederhana, pengelolaan stres, serta pentingnya dukungan sosial yang positif dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Melalui edukasi ini, lansia akan lebih mampu mengatasi berbagai tekanan emosional, sehingga sindrom geriatri seperti delirium yang sering diperparah oleh kecemasan atau stres emosional dapat dicegah atau minimal dikurangi.

Selanjutnya, edukasi kesehatan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Mengingat kondisi lansia yang sering kali berubah secara cepat, perawat perlu memastikan bahwa edukasi dilakukan secara rutin dan terencana, dengan jadwal yang jelas. Perawat bisa menggunakan kunjungan rumah rutin, kelompok diskusi lansia, atau pertemuan keluarga secara berkala sebagai kesempatan untuk memberikan edukasi tambahan, mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, serta memberikan masukan atau koreksi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh lansia maupun keluarga.

F. Studi Kasus Penanganan Sindrom Geriatri Berbasis Bukti

Penanganan sindrom geriatri pada lansia dengan penyakit kronis dapat lebih jelas dipahami melalui studi kasus yang nyata, yang menggambarkan secara mendalam proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi intervensi. Studi kasus berikut akan menguraikan secara rinci bagaimana intervensi keperawatan berbasis bukti diterapkan dalam praktik nyata untuk mengelola sindrom geriatri yang dialami oleh lansia.

Sebagai ilustrasi, seorang pasien lansia perempuan berusia 78 tahun dengan riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi kronis dibawa oleh keluarganya ke puskesmas dengan keluhan sering jatuh di rumah, kebingungan yang muncul secara tiba-tiba terutama di malam hari, serta kesulitan mengontrol urin (inkontinensia). Pada tahap pengkajian awal, perawat melakukan wawancara terstruktur kepada pasien dan keluarganya untuk memperoleh informasi mendalam terkait riwayat jatuh, frekuensi terjadinya inkontinensia, serta kejadian delirium yang dirasakan keluarga. Perawat menggunakan berbagai instrumen valid untuk mendukung proses pengkajian, seperti Morse Fall Scale untuk mengukur risiko jatuh, Confusion Assessment Method (CAM) untuk mendeteksi gejala delirium, serta instrumen sederhana skrining inkontinensia urin.

Hasil dari pengkajian menunjukkan bahwa pasien memiliki risiko jatuh yang tinggi dengan skor Morse Fall Scale sebesar 60 (risiko tinggi), mengalami episode delirium terutama pada malam hari (disorientasi waktu dan tempat, kesulitan mempertahankan perhatian, perubahan kesadaran yang fluktuatif), serta inkontinensia urin yang terjadi 3 hingga 4 kali sehari. Berdasarkan temuan ini,

perawat kemudian melakukan analisis data dan merancang rencana intervensi keperawatan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis bukti.

Pada tahap perencanaan intervensi, perawat melibatkan pasien dan keluarganya secara aktif dalam proses diskusi untuk menentukan tujuan intervensi yang jelas dan realistis. Rencana intervensi meliputi tiga domain utama, yaitu pencegahan jatuh, penanganan inkontinensia urin, serta pengelolaan delirium. Dalam pencegahan jatuh, perawat merencanakan untuk memodifikasi lingkungan fisik pasien agar aman, seperti memasang pegangan tangan (handrail) di kamar mandi dan lorong, pencahayaan yang cukup di malam hari, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa menyebabkan jatuh seperti permadani atau kabel listrik yang melintang. Untuk masalah inkontinensia, perawat merancang intervensi latihan kandung kemih (bladder training) yang dilakukan secara terjadwal, disertai edukasi keluarga tentang pentingnya jadwal pengosongan kandung kemih serta asupan cairan yang tepat. Dalam mengatasi delirium, perawat merencanakan pendekatan nonfarmakologis seperti orientasi realitas secara teratur, pengaturan siklus tidur-bangun yang konsisten, serta lingkungan yang tenang terutama di malam hari.

Pada tahap implementasi intervensi, perawat bersama keluarga melakukan modifikasi lingkungan sesuai rencana yang telah disusun. Pegangan tangan dipasang di area strategis seperti kamar mandi, toilet, dan kamar tidur pasien. Lampu tidur yang redup juga dipasang untuk memudahkan pasien mengenali lingkungannya di malam hari sehingga risiko jatuh dapat dikurangi. Selain itu, perawat melatih pasien bersama keluarganya untuk menerapkan jadwal latihan kandung kemih yang terstruktur setiap 2-3 jam, disertai dengan edukasi intensif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap jadwal tersebut. Pasien juga diajarkan teknik latihan otot panggul (latihan Kegel) secara rutin, guna meningkatkan kontrol kandung kemihnya. Selanjutnya, untuk intervensi delirium, perawat melakukan orientasi realitas yang konsisten, misalnya dengan menempatkan jam besar dan kalender di kamar pasien serta mengingatkan pasien tentang waktu, tempat, dan situasi yang terjadi secara berulang dan sabar. Lingkungan sekitar pasien juga dijaga tetap tenang dan nyaman, terutama menjelang waktu tidur malam, untuk mengurangi rangsangan yang dapat memperburuk delirium.

Setelah beberapa minggu implementasi intervensi secara konsisten, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas intervensi tersebut. Evaluasi menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kondisi pasien. Risiko jatuh berhasil menurun yang dibuktikan dengan tidak adanya episode jatuh baru selama periode evaluasi. Pasien dan keluarganya melaporkan bahwa pasien menjadi lebih percaya diri dalam mobilitas sehari-hari berkat lingkungan yang telah

dimodifikasi secara aman. Untuk masalah inkontinensia urin, pasien berhasil mengurangi frekuensi inkontinensia secara nyata dari 4 kali sehari menjadi hanya sekali sehari, seiring dengan kepatuhan pasien terhadap jadwal latihan kandung kemih yang diajarkan perawat. Demikian pula dengan latihan otot panggul yang dilakukan secara rutin, yang memberikan efek positif dalam pengendalian urin pasien. Dalam aspek delirium, pasien menunjukkan peningkatan orientasi waktu dan tempat yang lebih baik, episode kebingungan di malam hari juga berkurang secara signifikan setelah implementasi orientasi realitas yang konsisten serta pengaturan pola tidur yang teratur.

Hasil positif dari evaluasi intervensi ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan keperawatan berbasis bukti dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dengan sindrom geriatri. Studi kasus ini tidak hanya menunjukkan pentingnya intervensi yang didasarkan pada pengkajian dan perencanaan yang matang, tetapi juga menggambarkan bahwa kolaborasi erat antara perawat, pasien, dan keluarga merupakan kunci utama keberhasilan dari asuhan keperawatan yang diberikan.

G. Simpulan

Asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit kronis merupakan suatu pendekatan keperawatan yang kompleks dan komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Lansia dengan penyakit kronis menghadapi berbagai tantangan unik, termasuk kondisi kesehatan yang progresif, perubahan fisiologis, serta dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar sindrom geriatri seperti jatuh, inkontinensia urin, dan delirium, serta keterampilan yang baik dalam pengkajian dan deteksi dini kondisi tersebut.

Implementasi intervensi keperawatan yang efektif berbasis bukti, seperti manajemen lingkungan untuk mencegah jatuh, latihan kandung kemih untuk mengatasi inkontinensia urin, dan intervensi nonfarmakologis untuk mengelola delirium, terbukti secara nyata meningkatkan kualitas hidup lansia. Selain itu, edukasi kesehatan yang tepat kepada lansia dan keluarganya juga memainkan peran krusial dalam pencegahan sindrom geriatri. Edukasi yang terstruktur, sistematis, dan interaktif memungkinkan lansia dan keluarga mampu mengelola dan mencegah berbagai kondisi yang dapat memperburuk keadaan lansia dengan penyakit kronis.

Studi kasus dalam bab ini menggambarkan bahwa keberhasilan penanganan sindrom geriatri sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara perawat, pasien, dan keluarga. Pendekatan berbasis bukti yang dilakukan secara terencana, implementasi intervensi secara konsisten, serta evaluasi yang cermat, mampu

memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Dengan demikian, asuhan keperawatan yang komprehensif, berbasis bukti, dan didukung oleh edukasi yang efektif, menjadi fondasi penting dalam pelayanan kesehatan lansia dengan penyakit kronis, serta secara nyata mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

H. Referensi

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Flynn Makic, M. B., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2019). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care* (12th ed.). Elsevier Health Sciences.
- American Geriatrics Society. (2018). AGS/BGS Clinical Practice Guideline: Prevention of falls in older persons. *Journal of the American Geriatrics Society*, 66(1), 202-209. <https://doi.org/10.1111/jgs.15294>
- Bardsley, A. (2016). Assessment and management of delirium in older adults. *Nursing Older People*, 28(1), 16-21. <https://doi.org/10.7748/nop.28.1.16.s19>
- Eliopoulos, C. (2018). *Gerontological nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2018). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions & classification 2018-2020* (11th ed.). Thieme Publishers.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Huang, A. J., Brown, J. S., Kanaya, A. M., Creasman, J. M., & Ragins, A. I. (2016). Quality-of-life impact and treatment of urinary incontinence in elderly women. *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(5), 1056-1063. <https://doi.org/10.1111/jgs.14018>
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Inouye, S. K., Westendorp, R. G. J., & Saczynski, J. S. (2016). Delirium in elderly people. *The Lancet*, 383(9920), 911-922. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60688-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60688-1)
- Mauk, K. L. (2018). *Gerontological nursing: Competencies for care* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Morse, J. M. (2009). *Preventing patient falls: Establishing a fall intervention program* (2nd ed.). Springer Publishing Company.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Registered Nurses' Association of Ontario. (2017). *Preventing falls and reducing*

injury from falls. Clinical best practice guidelines. RNAO.

Touhy, T. A., & Jett, K. (2017). Ebersole and Hess' Gerontological Nursing & Healthy Aging (5th ed.). Elsevier Health Sciences.

World Health Organization. (2017). Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. WHO Press.

I. Glosarium

Asuhan Keperawatan

Pelayanan profesional oleh perawat yang meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien secara menyeluruh dan komprehensif.

Penyakit Kronis

Kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, umumnya bersifat progresif, tidak dapat sembuh sepenuhnya, dan memerlukan perawatan serta pemantauan secara terus-menerus.

Lansia

Kelompok individu yang telah memasuki usia lanjut (umumnya di atas 60 tahun), ditandai dengan perubahan signifikan secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual akibat proses penuaan alami.

Sindrom Geriatri

Kelompok kondisi klinis kompleks yang sering terjadi pada lansia akibat interaksi dari berbagai faktor risiko terkait usia lanjut, bukan merupakan bagian dari proses penuaan normal, seperti jatuh, inkontinensia urin, dan delirium.

Sindrom Jatuh (Fall Syndrome)

Kejadian di mana lansia jatuh secara tidak sengaja ke permukaan yang lebih rendah tanpa kehilangan kesadaran sebelumnya, sering menyebabkan komplikasi fisik dan psikologis serta meningkatkan risiko penurunan kualitas hidup.

Inkontinensia Urin

Ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol proses buang air kecil, menyebabkan kebocoran urin yang tidak disengaja, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup lansia.

Delirium

Gangguan akut pada kesadaran dan perhatian, ditandai dengan perubahan mendadak dalam kemampuan kognitif, orientasi, dan perilaku, biasanya muncul dalam hitungan jam hingga hari, dan bersifat fluktuatif.

Morse Fall Scale (MFS)

Instrumen pengkajian standar yang digunakan untuk menilai risiko jatuh pada lansia, mencakup berbagai faktor seperti riwayat jatuh, gaya berjalan, status mental, serta penggunaan alat bantu berjalan atau pemasangan infus.

Confusion Assessment Method (CAM)

Instrumen yang digunakan untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda delirium pada lansia, mencakup penilaian terhadap onset akut dan perubahan status mental, gangguan perhatian, pemikiran yang tidak terorganisasi, serta perubahan tingkat kesadaran.

Bladder Training (Latihan Kandung Kemih)

Metode intervensi nonfarmakologis berupa latihan yang bertujuan meningkatkan kontrol lansia terhadap proses berkemih melalui jadwal rutin, dengan tujuan mengurangi atau mencegah inkontinensia urin secara efektif.

CHAPTER 6

KESEHATAN MENTAL PADA LANSIA

Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental pada kelompok lanjut usia (lansia) merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Seiring bertambahnya usia, seseorang mengalami berbagai perubahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Perubahan-perubahan tersebut, jika tidak ditangani secara tepat dan efektif, dapat memicu munculnya berbagai masalah psikologis, seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan kognitif. Dalam konteks ini, perhatian khusus terhadap kesehatan mental lansia menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam upaya menjaga kesejahteraan mereka secara holistik.

Kecemasan merupakan salah satu tantangan psikologis yang paling sering dialami oleh lansia. Kondisi ini muncul karena berbagai faktor, seperti ketakutan terhadap masa depan yang tidak pasti, kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan yang semakin menurun, serta kecemasan tentang beban yang akan mereka timbulkan bagi keluarga atau orang-orang terdekat. Lansia yang mengalami kecemasan biasanya menunjukkan gejala berupa rasa khawatir berlebihan yang tidak rasional, mudah tersinggung, insomnia, gangguan nafsu makan, serta gangguan fisik seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan. Jika tidak segera diatasi, kecemasan kronis yang dialami lansia dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta meningkatkan risiko isolasi sosial karena lansia cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar.

Depresi juga menjadi tantangan kesehatan mental yang signifikan pada lansia. Depresi pada lansia sering kali tidak terdeteksi atau dianggap sebagai kondisi normal dalam proses penuaan, padahal kondisi ini merupakan gangguan psikologis serius yang membutuhkan perhatian khusus. Depresi pada lansia umumnya disebabkan oleh kehilangan pasangan hidup, pensiun dari pekerjaan yang telah lama dijalani, perasaan kesepian, serta ketidakmampuan fisik yang semakin membatasi aktivitas sehari-hari. Gejala depresi pada lansia antara lain kehilangan minat atau semangat hidup, perasaan sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, kelelahan yang terus-menerus, dan bahkan pikiran tentang kematian. Depresi yang tidak ditangani dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik yang drastis,

mempercepat timbulnya berbagai penyakit kronis, dan secara langsung mengganggu kemampuan lansia untuk menjaga kemandiriannya.

Selain kecemasan dan depresi, gangguan kognitif merupakan tantangan psikologis lainnya yang lazim ditemui pada lansia. Penurunan fungsi kognitif pada lansia dapat berkisar dari yang ringan, seperti gangguan memori jangka pendek atau kesulitan dalam mengambil keputusan sederhana, hingga kondisi yang lebih berat seperti demensia atau penyakit Alzheimer. Gangguan kognitif sering kali menyebabkan lansia mengalami kebingungan, disorientasi, gangguan komunikasi, kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, serta perubahan perilaku yang signifikan seperti agitasi, agresivitas, atau apatis. Dampak gangguan kognitif sangat luas, tidak hanya memengaruhi kehidupan lansia sendiri, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi keluarga yang merawat lansia tersebut.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kognitif memiliki dampak yang serius terhadap kualitas hidup lansia. Lansia dengan gangguan kesehatan mental sering kali mengalami penurunan drastis dalam kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri, hilangnya rasa percaya diri, peningkatan risiko isolasi sosial, serta secara langsung mengurangi kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan lingkaran negatif, di mana kondisi psikologis yang buruk memperburuk kondisi fisik, dan sebaliknya.

B. Hubungan antara Sindrom Geriatri dengan Kesehatan Mental

Sindrom geriatri merupakan serangkaian kondisi klinis yang umum terjadi pada lansia akibat proses penuaan, penurunan fungsi organ tubuh, serta berbagai faktor internal dan eksternal lainnya. Kondisi yang termasuk dalam sindrom geriatri seperti jatuh (fall), inkontinensia urin, dan delirium, ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan munculnya berbagai masalah kesehatan mental pada lansia. Hal ini disebabkan oleh dampak dari sindrom geriatri yang tidak hanya sebatas aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis yang sangat dalam.

Jatuh merupakan salah satu kondisi sindrom geriatri yang paling sering dialami lansia. Secara fisik, jatuh dapat menyebabkan cedera seperti patah tulang, luka memar, atau bahkan trauma kepala. Namun, dampak psikologis dari kejadian jatuh sering kali lebih dalam dan bertahan lama dibandingkan dengan cedera fisik yang dialami. Lansia yang pernah mengalami jatuh, khususnya jika terjadi berulang kali, cenderung akan mengalami trauma psikologis berupa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan terhadap kemungkinan jatuh lagi di kemudian hari. Kecemasan ini mendorong lansia untuk mengurangi aktivitas fisik mereka, membatasi mobilitas,

dan akhirnya menyebabkan isolasi sosial karena takut bergerak bebas. Pembatasan aktivitas ini pada akhirnya juga menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, penurunan kualitas hidup secara signifikan, dan sering kali memicu depresi yang berkelanjutan. Kondisi depresi tersebut semakin memperburuk kondisi fisik dan memperbesar risiko jatuh yang berulang, menciptakan siklus negatif yang sulit diputus.

Selanjutnya, inkontinensia urin adalah kondisi lain yang juga memiliki dampak besar pada kesehatan mental lansia. Lansia yang mengalami inkontinensia urin sering kali merasa malu, tidak nyaman, dan merasa kehilangan martabat karena ketidakmampuan untuk mengontrol fungsi tubuh secara optimal. Kondisi ini menyebabkan rasa rendah diri, stres psikologis yang signifikan, kecemasan terhadap situasi sosial, serta meningkatkan risiko depresi akibat isolasi yang mereka pilih untuk hindari rasa malu. Banyak lansia dengan inkontinensia urin akhirnya menarik diri dari interaksi sosial karena khawatir urin keluar tanpa disadari atau takut menimbulkan bau yang tidak sedap. Kecemasan yang terus-menerus ini semakin memperparah kondisi psikologis mereka, membuat lansia merasa tidak berguna, merasa ditolak, dan kehilangan motivasi hidup. Jika tidak segera ditangani secara holistik, dampak psikologis inkontinensia urin akan semakin berat, bahkan hingga memicu gangguan kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi kronis.

Delirium, yang merupakan gangguan akut yang ditandai oleh kebingungan mendadak, disorientasi, dan gangguan persepsi, juga berhubungan erat dengan masalah kesehatan mental. Lansia yang mengalami delirium, terutama dalam setting rawat inap di rumah sakit, mengalami tekanan psikologis yang sangat tinggi. Mereka sering kali merasakan ketakutan yang luar biasa karena kebingungan mengenai kondisi mereka, merasa terancam, cemas, dan sulit tidur. Kondisi psikologis ini menyebabkan tingkat stres yang sangat tinggi, memperparah kondisi delirium yang mereka alami. Selain itu, lansia yang pernah mengalami delirium akut cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kognitif permanen, seperti demensia, serta gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang bertahan lama setelah kondisi akutnya teratasi. Keluarga dan pengasuh juga turut mengalami tekanan emosional yang berat, karena mereka harus menghadapi perilaku lansia yang tidak dapat diprediksi, seperti agitasi, agresivitas, atau bahkan halusinasi. Beban psikologis yang dirasakan oleh keluarga juga turut memperparah situasi, menciptakan suasana perawatan yang semakin sulit dan kompleks.

Hubungan antara sindrom geriatri dan kesehatan mental lansia mencerminkan kompleksitas dalam perawatan lansia, yang menuntut pendekatan intervensi holistik dan terintegrasi. Dampak fisik dari sindrom geriatri, baik jatuh, inkontinensia urin, maupun delirium, secara langsung maupun tidak langsung memicu timbulnya stres

psikologis, kecemasan, depresi, hingga isolasi sosial. Perasaan rendah diri, kehilangan martabat, ketakutan akan kehilangan kemandirian, serta beban psikologis terhadap keluarga, semuanya menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia.

C. Konsep Dasar Sindrom Geriatri (Jatuh, Inkontinensia Urin, Delirium)

Sindrom geriatri adalah kumpulan berbagai kondisi kesehatan yang umum terjadi pada kelompok usia lanjut, terutama akibat proses penuaan, penurunan fungsi fisiologis tubuh, serta interaksi antara faktor internal dan eksternal yang kompleks. Sindrom ini memiliki ciri khas multifaktorial, artinya penyebabnya tidak hanya berasal dari satu faktor tunggal saja, tetapi merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor sekaligus, baik itu kondisi medis, psikologis, maupun lingkungan. Tiga kondisi utama yang paling sering dikategorikan sebagai sindrom geriatri adalah jatuh (fall), inkontinensia urin, dan delirium. Ketiga kondisi ini sangat signifikan karena selain dampaknya yang besar pada kondisi fisik lansia, juga berkontribusi besar terhadap munculnya gangguan kesehatan mental yang memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan.

Pertama, jatuh merupakan kejadian yang sangat umum dialami lansia, dengan definisi umum sebagai kondisi ketika seseorang tiba-tiba kehilangan keseimbangan tubuh, yang berakibat tubuhnya terjatuh ke tanah atau permukaan lainnya secara tidak sengaja. Faktor risiko utama terjadinya jatuh pada lansia meliputi penurunan fungsi muskuloskeletal, melemahnya otot-otot penyangga tubuh, gangguan keseimbangan tubuh, gangguan penglihatan atau pendengaran, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat antihipertensi atau sedatif yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Selain itu, faktor lingkungan juga berkontribusi signifikan dalam kejadian jatuh, seperti kondisi lantai licin, pencahayaan ruangan yang buruk, atau penggunaan alas kaki yang tidak sesuai. Manifestasi klinis jatuh meliputi cedera fisik seperti luka ringan hingga patah tulang serius, memar, hingga trauma kepala. Secara psikologis, lansia yang mengalami jatuh sering mengalami ketakutan berlebih, cemas akan mengalami kejadian yang sama kembali, yang kemudian menyebabkan mereka memilih untuk membatasi aktivitasnya. Dampak jangka panjang dari jatuh meliputi penurunan rasa percaya diri, isolasi sosial, depresi, hingga penurunan kualitas hidup yang signifikan, karena mereka merasa tidak lagi mampu hidup secara mandiri atau aktif seperti sebelumnya.

Kedua, inkontinensia urin merupakan kondisi ketidakmampuan lansia untuk mengendalikan keluarnya urin secara sadar, yang menyebabkan kebocoran urin tanpa disengaja. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh melemahnya otot-otot dasar

panggul yang mendukung fungsi kandung kemih, gangguan pada persarafan yang mengatur proses berkemih, atau penyakit kronis seperti diabetes, stroke, dan penyakit Parkinson. Faktor risiko lainnya termasuk jenis kelamin perempuan, obesitas, riwayat persalinan berulang, serta imobilitas atau kurang aktif secara fisik. Manifestasi klinis inkontinensia urin antara lain urin keluar secara tidak sengaja, meningkatnya frekuensi berkemih tanpa terkendali, serta kesulitan untuk menahan urin ketika merasa ingin buang air kecil. Dampak inkontinensia urin terhadap kesehatan mental lansia sangat besar karena kondisi ini sering menyebabkan perasaan malu, ketidaknyamanan, rendah diri, dan kecemasan dalam menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Akibatnya, lansia sering kali menarik diri dari interaksi sosial, mengalami isolasi, merasa depresi, hingga mengalami gangguan kecemasan yang persisten. Tanpa intervensi tepat, kondisi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup secara emosional, tetapi juga mengganggu hubungan interpersonal dan interaksi sosial lansia.

Ketiga, delirium adalah kondisi akut yang ditandai dengan perubahan kesadaran yang mendadak, gangguan perhatian, kebingungan, serta gangguan pada proses berpikir dan persepsi. Delirium biasanya berkembang dalam waktu singkat, mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari, dan umumnya ditemukan pada lansia yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau menderita kondisi medis akut. Penyebab delirium sangat beragam, antara lain infeksi akut, gangguan metabolik seperti ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat penenang, gangguan tidur berat, hingga nyeri yang tidak terkendali. Faktor risiko utama delirium termasuk usia lanjut, demensia atau gangguan kognitif sebelumnya, kondisi sakit yang berat, serta lingkungan rumah sakit yang tidak mendukung, seperti ruangan yang berisik atau pencahayaan yang buruk. Manifestasi klinis delirium meliputi disorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang, munculnya halusinasi visual atau auditif, agitasi, gelisah, gangguan tidur, serta gangguan perhatian yang jelas terlihat. Dampak delirium pada kesehatan mental lansia sangat signifikan karena kondisi ini menyebabkan lansia merasa ketakutan, cemas berlebihan, paranoid, hingga depresi akut. Keluarga lansia yang merawat juga mengalami tekanan psikologis yang besar akibat perubahan mendadak perilaku lansia, sehingga memperparah situasi secara emosional. Kondisi delirium juga memiliki konsekuensi jangka panjang, seperti meningkatkan risiko munculnya gangguan kognitif permanen, memperlama masa rawat inap di rumah sakit, hingga meningkatkan risiko komplikasi serius lainnya seperti jatuh atau cedera fisik tambahan.

D. Teknik Pengkajian dan Deteksi Dini Sindrom Geriatri

Pengkajian dan deteksi dini sindrom geriatri merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan lansia, karena kondisi ini memiliki dampak luas terhadap kesehatan fisik maupun mental lansia. Tujuan dari pengkajian secara dini adalah untuk mendeteksi kondisi yang berisiko berkembang menjadi komplikasi lebih lanjut, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan. Teknik pengkajian sindrom geriatri ini meliputi berbagai metode yang mencakup pengkajian fisik secara menyeluruh, penggunaan instrumen khusus, skrining cepat, observasi klinis yang cermat, serta wawancara terstruktur dengan lansia maupun keluarganya.

Pengkajian fisik merupakan langkah awal yang sangat esensial dalam proses deteksi sindrom geriatri. Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan data objektif mengenai kondisi kesehatan lansia secara umum. Dalam pengkajian fisik, perawat melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fungsi tubuh seperti fungsi muskuloskeletal untuk menilai tingkat keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan pola berjalan lansia. Misalnya, perawat mengobservasi lansia saat bangkit dari duduk ke posisi berdiri, cara berjalan, maupun saat melakukan gerakan sederhana seperti mengambil benda ringan. Pengamatan ini berguna untuk mendeteksi adanya gangguan fisik yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Selain itu, pemeriksaan neurologis juga penting dilakukan untuk mengevaluasi fungsi persarafan yang berkaitan dengan inkontinensia urin atau delirium, termasuk pemeriksaan refleks, tingkat kesadaran, tonus otot, serta orientasi lansia terhadap lingkungan sekitar.

Selain pemeriksaan fisik, penggunaan instrumen khusus juga memegang peranan penting dalam mendeteksi sindrom geriatri secara cepat dan akurat. Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam menilai risiko jatuh adalah Morse Fall Scale (MFS). Alat ini terdiri dari beberapa indikator yang mencakup riwayat jatuh sebelumnya, status mental lansia, penggunaan alat bantu seperti tongkat atau walker, pola berjalan, serta adanya kondisi medis tertentu yang meningkatkan risiko jatuh. Skor yang dihasilkan dari instrumen ini membantu perawat dalam mengklasifikasikan risiko jatuh, sehingga langkah-langkah pencegahan yang sesuai dapat segera diterapkan.

Untuk mendeteksi inkontinensia urin, instrumen seperti Bladder Diary atau catatan harian kandung kemih sering kali digunakan. Instrumen ini berupa catatan terstruktur yang membantu lansia maupun perawat mencatat pola berkemih selama 24 jam, frekuensi berkemih, volume urin yang keluar, serta situasi atau aktivitas yang memicu kebocoran urin. Dengan data ini, perawat dapat mengidentifikasi pola spesifik yang mendasari munculnya inkontinensia, sehingga dapat dirancang

intervensi khusus seperti pelatihan kandung kemih atau latihan penguatan otot panggul secara tepat.

Sementara itu, delirium dapat dideteksi secara dini menggunakan instrumen Confusion Assessment Method (CAM). Alat ini merupakan instrumen valid yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan kesadaran secara mendadak, gangguan perhatian, serta disorientasi lansia terhadap waktu, tempat, dan orang secara akurat. CAM membantu perawat dalam membedakan kondisi delirium dari demensia atau gangguan kognitif lain yang sifatnya lebih kronis. Penggunaan CAM memungkinkan perawat mendeteksi delirium sejak awal sehingga intervensi seperti koreksi gangguan elektrolit, hidrasi, atau intervensi psikososial dapat segera dilakukan sebelum kondisinya semakin buruk.

Selain penggunaan instrumen khusus, skrining cepat juga menjadi metode penting yang harus dikuasai oleh perawat. Skrining cepat ini umumnya berupa pertanyaan singkat yang diajukan kepada lansia atau keluarganya pada saat pertama kali kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya, perawat dapat menanyakan apakah lansia mengalami jatuh dalam enam bulan terakhir, apakah lansia pernah mengalami kehilangan urin secara tiba-tiba dalam satu minggu terakhir, atau apakah ada perubahan perilaku mendadak yang menunjukkan gangguan kesadaran atau perhatian. Skrining cepat ini memberikan gambaran awal yang membantu perawat menentukan apakah diperlukan pengkajian lanjutan atau tidak.

Observasi klinis juga merupakan teknik pengkajian yang sangat efektif dalam mendeteksi sindrom geriatri. Observasi ini dilakukan dengan memperhatikan perilaku lansia selama aktivitas sehari-hari atau saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam observasi ini, perawat dapat mendeteksi risiko jatuh dengan memperhatikan kestabilan lansia saat berjalan, adanya gangguan keseimbangan, atau gangguan penglihatan dan pendengaran yang jelas terlihat. Demikian pula untuk inkontinensia urin, observasi terhadap frekuensi lansia menuju toilet, adanya aroma urin yang khas, atau kondisi basah pada pakaian lansia sangat membantu dalam mengenali masalah ini. Sedangkan untuk delirium, observasi klinis dapat meliputi pengamatan terhadap munculnya perubahan perilaku secara tiba-tiba seperti kebingungan, gelisah berlebihan, gangguan tidur yang mendadak, atau perilaku agitasi yang tidak biasa pada lansia.

Langkah terakhir dalam teknik pengkajian sindrom geriatri adalah wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung dengan lansia dan keluarganya. Wawancara ini sangat penting karena memberikan informasi subjektif yang sering kali tidak dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik maupun observasi klinis. Dalam wawancara, perawat dapat menggali secara mendalam mengenai riwayat jatuh,

faktor risiko yang mungkin ada di lingkungan rumah, kebiasaan berkemih sehari-hari, riwayat penggunaan obat yang dapat memicu delirium, serta perubahan perilaku lansia yang dilaporkan keluarga. Wawancara terstruktur juga memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mengungkapkan kesulitan yang mereka alami dalam merawat lansia, yang kemudian dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Keseluruhan teknik pengkajian ini, mulai dari pemeriksaan fisik, instrumen pengkajian khusus, skrining cepat, observasi klinis, hingga wawancara terstruktur, merupakan rangkaian metode yang saling melengkapi satu sama lain. Dengan mengintegrasikan berbagai metode tersebut secara sistematis, tenaga kesehatan khususnya perawat dapat melakukan deteksi dini sindrom geriatri secara lebih komprehensif, akurat, dan tepat waktu, sehingga intervensi yang diberikan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup lansia secara optimal.

E. Intervensi Keperawatan Efektif pada Sindrom Geriatri

Intervensi keperawatan yang efektif pada lansia dengan sindrom geriatri memerlukan pendekatan komprehensif berbasis bukti (evidence-based practice) yang tidak hanya menangani aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis atau kesehatan mental lansia secara menyeluruh. Pendekatan ini harus mencakup berbagai tindakan yang sifatnya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan melibatkan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan profesional, keluarga, dan komunitas secara luas. Pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani sindrom geriatri terletak pada kompleksitas sindrom tersebut, yang sering kali mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan lansia, termasuk aspek psikologis seperti kecemasan, depresi, dan isolasi sosial.

Dalam aspek preventif, intervensi keperawatan yang efektif dimulai dengan upaya identifikasi dini faktor risiko yang mungkin memicu munculnya sindrom geriatri. Untuk mencegah kejadian jatuh pada lansia, perawat perlu melakukan modifikasi lingkungan secara signifikan, misalnya dengan memasang pegangan tangan di kamar mandi atau tangga, menjaga lantai tetap kering, serta memastikan pencahayaan ruangan cukup terang terutama pada malam hari. Selain modifikasi lingkungan, latihan fisik secara teratur juga sangat dianjurkan sebagai langkah preventif. Latihan ini dapat berupa latihan keseimbangan, latihan fleksibilitas, serta latihan penguatan otot untuk meningkatkan stabilitas fisik lansia dan mengurangi risiko jatuh secara signifikan.

Intervensi preventif pada kasus inkontinensia urin dapat dilakukan melalui pelatihan kandung kemih (bladder training) yang bertujuan membantu lansia membentuk pola berkemih yang lebih teratur. Latihan ini dilakukan dengan

menetapkan jadwal tetap ke kamar mandi setiap beberapa jam sekali, dan secara bertahap interval waktu ini diperpanjang sesuai toleransi lansia. Perawat juga dapat mengajarkan latihan Kegel, yaitu latihan sederhana untuk menguatkan otot dasar panggul secara rutin, sehingga lansia dapat meningkatkan kontrol kandung kemih dan mengurangi insiden inkontinensia urin.

Sementara itu, dalam pencegahan delirium, intervensi preventif yang dapat diterapkan meliputi pemantauan ketat terhadap konsumsi obat-obatan, memastikan kecukupan hidrasi dan nutrisi, serta menciptakan lingkungan perawatan yang nyaman dan tenang, terutama bagi lansia yang sedang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan. Lingkungan yang kondusif ini mampu mengurangi stres dan gangguan tidur yang dapat memicu timbulnya delirium.

Dalam aspek promotif, intervensi keperawatan difokuskan pada edukasi kesehatan yang intensif, baik bagi lansia maupun keluarga mereka. Pendidikan ini meliputi pentingnya menjaga gaya hidup sehat seperti pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, hidrasi yang baik, dan manajemen stres yang efektif. Selain itu, edukasi juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, sebagai bagian dari upaya deteksi dini sindrom geriatri maupun kondisi kesehatan lain yang mungkin memperparah keadaan. Perawat dapat menggunakan metode edukasi kelompok, diskusi interaktif, maupun demonstrasi langsung untuk memastikan bahwa lansia dan keluarga benar-benar memahami informasi yang disampaikan.

Intervensi promotif juga harus memperhatikan kesehatan mental lansia. Aktivitas sosial yang rutin, seperti bergabung dalam kelompok lansia di komunitas atau kegiatan keagamaan, sangat dianjurkan karena terbukti dapat mencegah isolasi sosial, depresi, dan kecemasan. Keterlibatan sosial yang aktif dapat membantu lansia mempertahankan hubungan emosional positif dengan orang lain, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.

Pada aspek kuratif, intervensi keperawatan bertujuan mengatasi sindrom geriatri yang telah muncul. Dalam penanganan jatuh, intervensi pertama yang harus dilakukan adalah memastikan stabilisasi kondisi lansia pasca jatuh, kemudian segera mengevaluasi tingkat cedera yang dialami seperti patah tulang, luka memar, atau trauma kepala. Perawat harus segera melakukan koordinasi dengan tim medis untuk memberikan penanganan yang tepat, termasuk mengontrol rasa nyeri, mengatasi cedera yang terjadi, serta memastikan kenyamanan psikologis lansia melalui pendekatan empatik dan suportif.

Untuk penanganan inkontinensia urin secara kuratif, perawat perlu membantu lansia dengan pengaturan cairan yang adekuat dan tepat waktu, menyediakan akses cepat ke kamar mandi atau alat bantu seperti urinal, serta menjaga kebersihan lansia

secara optimal untuk mencegah iritasi kulit atau infeksi. Selain itu, penting juga bagi perawat untuk membantu lansia mengatasi perasaan malu atau kecemasan akibat kondisi ini, dengan memberikan dukungan emosional serta edukasi kepada keluarga mengenai cara terbaik untuk memberikan dukungan tanpa membuat lansia merasa rendah diri.

Dalam kasus delirium, intervensi kuratif melibatkan identifikasi cepat dan tepat terhadap penyebab yang mendasarinya, seperti infeksi, gangguan metabolik, atau efek samping obat. Setelah penyebabnya diketahui, perawat harus bekerja sama dengan dokter untuk segera mengatasinya secara medis. Selama proses perawatan, pendekatan psikososial juga sangat diperlukan, seperti terapi realitas dengan mengorientasikan kembali lansia terhadap tempat, waktu, dan lingkungan sekitar secara rutin, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, dan familiar. Keluarga juga perlu dilibatkan secara aktif untuk memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga kondisi psikologis lansia menjadi lebih stabil.

Pada aspek rehabilitatif, intervensi keperawatan diarahkan pada pemulihan fungsi dan kemandirian lansia pasca mengalami sindrom geriatri. Misalnya, rehabilitasi pada lansia yang pernah mengalami jatuh dapat melibatkan latihan fisik intensif bersama fisioterapis untuk memulihkan fungsi otot dan keseimbangan tubuh. Dukungan psikologis seperti terapi kelompok atau konseling juga diperlukan untuk membantu lansia mengatasi trauma pasca jatuh dan meningkatkan kembali rasa percaya diri mereka.

Rehabilitasi untuk inkontinensia urin mencakup latihan berkelanjutan yang memperkuat otot dasar panggul, serta edukasi lanjutan untuk menjaga kepercayaan diri lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk lansia yang mengalami delirium, rehabilitasi psikososial seperti kegiatan stimulasi kognitif, terapi realitas, serta terapi okupasi perlu diberikan untuk mengembalikan fungsi kognitif dan keterampilan sosial mereka.

F. Pencegahan Sindrom Geriatri melalui Edukasi Keluarga dan Lansia

Edukasi kesehatan merupakan salah satu komponen esensial dalam pencegahan sindrom geriatri, khususnya melalui keterlibatan aktif keluarga dan lansia sendiri. Pentingnya edukasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar sindrom geriatri dapat dicegah atau setidaknya dikurangi risikonya melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta keterampilan praktis yang dimiliki oleh lansia maupun keluarga yang merawatnya. Melalui edukasi kesehatan yang terencana dengan baik, keluarga dan lansia dapat memahami secara mendalam tentang berbagai risiko yang berpotensi menyebabkan jatuh, inkontinensia urin, delirium, serta bagaimana ketiga kondisi tersebut secara langsung maupun tidak

langsung memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

Dalam upaya edukasi pencegahan jatuh, materi yang disampaikan harus mencakup penjelasan tentang berbagai faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan lansia mengalami jatuh. Faktor tersebut meliputi penurunan keseimbangan tubuh akibat proses penuaan, gangguan penglihatan, penggunaan obat-obatan yang menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan, serta lingkungan rumah yang tidak aman seperti lantai licin, pencahayaan yang kurang, atau tidak tersedianya alat bantu yang tepat seperti pegangan tangan atau railing di area yang sering digunakan lansia. Edukasi ini juga harus melibatkan informasi praktis mengenai cara membuat lingkungan fisik rumah yang lebih aman bagi lansia, seperti pemasangan alat bantu pegangan, memastikan pencahayaan yang cukup terang terutama pada malam hari, serta penggunaan alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Selain itu, lansia dan keluarganya perlu diajarkan latihan fisik sederhana yang terbukti efektif dalam meningkatkan keseimbangan tubuh, kekuatan otot, serta kepercayaan diri lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang secara signifikan dapat mengurangi risiko jatuh dan dampak psikologis yang menyertainya seperti trauma atau ketakutan berlebihan terhadap aktivitas fisik.

Untuk edukasi pencegahan inkontinensia urin, penting bagi keluarga dan lansia untuk memahami bahwa inkontinensia bukanlah kondisi yang perlu ditutup-tutupi atau dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Materi edukasi harus mencakup berbagai penyebab potensial dari inkontinensia, seperti melemahnya otot dasar panggul, penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, atau kondisi neurologis seperti stroke. Keluarga dan lansia juga perlu memahami dampak psikologis dari inkontinensia, termasuk rasa malu, cemas, atau depresi yang sering dialami oleh lansia yang mengalaminya. Edukasi ini mencakup pula pelatihan praktis seperti latihan Kegel yang bertujuan memperkuat otot dasar panggul secara rutin dan teknik pengaturan waktu berkemih yang lebih teratur. Selain itu, keluarga juga perlu diajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan area genital secara optimal untuk mencegah infeksi saluran kemih, serta bagaimana cara memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada lansia agar mereka tetap percaya diri dalam menjalani kehidupan sosial tanpa merasa rendah diri akibat kondisinya.

Dalam upaya edukasi pencegahan delirium, materi yang perlu diberikan kepada keluarga dan lansia meliputi penjelasan tentang faktor pemicu delirium, seperti infeksi akut, gangguan metabolisme, konsumsi atau penghentian obat-obatan tertentu secara tiba-tiba, dehidrasi, serta stres psikologis yang tinggi. Keluarga harus diajarkan mengenai pentingnya menjaga pola hidup lansia tetap stabil dan teratur, seperti memastikan asupan cairan yang cukup, nutrisi yang

seimbang, dan menjaga kualitas tidur lansia agar terhindar dari gangguan tidur yang bisa memperburuk risiko delirium. Selain itu, penting juga bagi keluarga untuk diajarkan tanda-tanda awal delirium, seperti perubahan perilaku secara mendadak, disorientasi terhadap waktu, tempat atau orang, serta gangguan perhatian dan konsentrasi yang tiba-tiba. Dengan memahami tanda-tanda tersebut, keluarga dapat lebih cepat merespons kondisi lansia dengan segera mencari pertolongan medis yang tepat dan mencegah kondisi delirium berkembang lebih parah.

Aspek lain yang juga sangat penting dalam edukasi ini adalah pemahaman keluarga dan lansia tentang dampak psikologis dari sindrom geriatri. Ketiga kondisi ini tidak hanya berdampak fisik semata, tetapi juga sering kali menimbulkan stres psikologis yang cukup serius, termasuk kecemasan berlebihan, depresi, atau isolasi sosial. Oleh karena itu, edukasi juga harus mencakup keterampilan khusus dalam memberikan dukungan emosional kepada lansia, seperti teknik komunikasi terapeutik yang empatik dan suportif, cara mengenali tanda-tanda stres atau depresi pada lansia, serta bagaimana cara memberikan intervensi psikologis sederhana seperti mendampingi lansia dalam aktivitas sosial, mengajak berbicara secara rutin, atau menciptakan lingkungan emosional yang hangat dan nyaman di rumah.

Dalam menyampaikan berbagai materi edukasi ini, sangat penting untuk menggunakan metode komunikasi yang efektif agar informasi dapat diterima dan dipahami secara maksimal oleh lansia maupun keluarga. Komunikasi tersebut harus dilakukan dengan bahasa yang jelas, sederhana, serta disampaikan secara perlahan agar lansia memiliki cukup waktu untuk memproses informasi yang diterima. Metode seperti diskusi interaktif, sesi tanya jawab yang terbuka, demonstrasi praktis langsung, serta pemberian materi visual seperti brosur atau video edukasi sangat dianjurkan karena terbukti lebih efektif dalam membantu lansia memahami materi secara menyeluruh. Perawat sebagai fasilitator edukasi juga harus memiliki keterampilan komunikasi terapeutik yang baik, seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik positif, serta menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka sehingga lansia dan keluarga merasa bebas bertanya atau menyampaikan kekhawatiran yang mereka rasakan.

Melalui kombinasi antara materi edukasi yang relevan, metode komunikasi efektif, serta pelatihan keterampilan praktis yang sesuai, edukasi keluarga dan lansia dapat menjadi strategi yang sangat efektif dalam mencegah atau setidaknya meminimalkan risiko sindrom geriatri. Strategi ini tidak hanya berdampak positif secara fisik, tetapi juga secara psikologis, di mana lansia merasa lebih percaya diri, dihargai, dan mampu menjalani kehidupan yang lebih sehat, mandiri, serta penuh makna di usia lanjut.

G. Studi Kasus Penanganan Sindrom Geriatri Berbasis Bukti

Penanganan sindrom geriatri pada lansia memerlukan pendekatan yang berbasis bukti agar hasil intervensi keperawatan dapat dipastikan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara holistik, baik secara fisik maupun mental. Beberapa studi kasus nyata berikut menggambarkan bagaimana sindrom geriatri berhasil diatasi melalui intervensi yang tepat, komprehensif, dan didukung oleh hasil penelitian terbaru serta praktik klinis terbaik. Setiap kasus akan dianalisis secara terperinci, mencakup langkah-langkah intervensi yang diberikan, evaluasi hasil setelah intervensi, serta dampaknya terhadap kesehatan mental lansia.

8. Kasus Pertama

Lansia perempuan berusia 78 tahun mengalami sindrom geriatri berupa jatuh berulang kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Pengkajian mendalam mengungkapkan bahwa lansia ini mengalami osteoarthritis lutut kanan, penurunan keseimbangan tubuh, serta gangguan penglihatan yang cukup signifikan. Selain dampak fisik berupa cedera ringan, kejadian jatuh yang berulang juga menyebabkan ketakutan berlebihan, rasa cemas yang meningkat, dan mulai muncul gejala depresi ringan berupa isolasi sosial, penurunan semangat, serta rasa rendah diri.

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, intervensi keperawatan yang diterapkan mencakup beberapa aspek. Secara preventif, tim keperawatan melakukan modifikasi lingkungan di rumah lansia seperti pemasangan pegangan tangan pada area yang berisiko tinggi seperti kamar mandi dan tangga, memastikan pencahayaan yang optimal di seluruh ruangan terutama pada malam hari, serta memastikan lantai rumah tidak licin. Intervensi promotif diberikan melalui edukasi kepada lansia dan keluarga mengenai pentingnya latihan fisik rutin berupa latihan keseimbangan sederhana selama 15-20 menit setiap hari yang dibantu oleh anggota keluarga terdekat. Secara rehabilitatif, fisioterapis dilibatkan untuk memberikan latihan penguatan otot tungkai secara rutin agar lansia memiliki kestabilan yang lebih baik dalam berjalan. Pendampingan psikologis juga diberikan melalui komunikasi terapeutik secara rutin yang bertujuan membangun kembali rasa percaya diri lansia.

Setelah tiga bulan menjalani intervensi tersebut, hasil evaluasi menunjukkan lansia mengalami penurunan frekuensi jatuh yang signifikan. Secara psikologis, lansia memperlihatkan perbaikan nyata dalam rasa percaya diri, mulai aktif berpartisipasi dalam aktivitas sosial di lingkungannya, serta menunjukkan berkurangnya gejala cemas dan depresi. Keluarga melaporkan bahwa lansia merasa lebih nyaman, aman, dan bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

di rumah. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi yang holistik berbasis bukti tidak hanya efektif dalam mengurangi risiko jatuh tetapi juga berdampak positif pada kesehatan mental lansia secara menyeluruh.

9. Kasus Kedua

Seorang lansia laki-laki berusia 80 tahun mengalami inkontinensia urin berat yang berlangsung lebih dari satu tahun. Pengkajian mendalam menemukan bahwa lansia ini memiliki riwayat diabetes mellitus selama lebih dari 10 tahun, kelemahan otot dasar panggul, serta mengalami stres psikologis yang cukup besar berupa rasa malu, menarik diri dari interaksi sosial, dan kecemasan berlebihan terutama ketika berada di luar rumah.

Intervensi keperawatan berbasis bukti yang diterapkan dalam kasus ini meliputi latihan pengaturan waktu berkemih (bladder training), yaitu dengan menjadwalkan waktu berkemih setiap 2-3 jam secara konsisten. Perawat juga memberikan edukasi khusus mengenai latihan Kegel yang bertujuan untuk memperkuat otot dasar panggul secara rutin, dua kali sehari. Selain intervensi fisik, lansia dan keluarga diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga asupan cairan yang cukup dan membatasi minuman pemicu inkontinensia seperti kopi atau minuman bersoda. Intervensi psikologis dilakukan dengan pendekatan suportif, berupa pendampingan empatik dan diskusi rutin yang membantu lansia mengekspresikan perasaan, kecemasan, serta ketidaknyamanan yang dirasakannya.

Setelah dua bulan intervensi ini berlangsung, evaluasi menunjukkan perbaikan signifikan dalam kemampuan lansia mengontrol berkemihnya, ditandai dengan penurunan frekuensi kebocoran urin hingga lebih dari 80%. Dampak positif juga dirasakan pada aspek mental lansia, yang menunjukkan penurunan kecemasan secara nyata serta mulai kembali aktif mengikuti kegiatan sosial di komunitasnya. Lansia tersebut juga mengaku merasa jauh lebih percaya diri, tidak lagi merasa malu atau takut beraktivitas di luar rumah. Keluarga melaporkan lansia tampak lebih ceria, bersemangat, serta memiliki kualitas tidur yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

10. Kasus Ketiga

Seorang lansia perempuan berusia 82 tahun dirawat di rumah sakit akibat pneumonia berat. Selama masa perawatan, lansia ini mengalami delirium akut yang ditandai dengan agitasi hebat, disorientasi waktu dan tempat, serta gangguan tidur yang parah. Kondisi tersebut diperparah oleh lingkungan rumah sakit yang bising, cahaya yang terang di malam hari, serta rasa ketidaknyamanan psikologis akibat perawatan medis yang intensif.

Tim keperawatan segera menerapkan intervensi yang komprehensif. Secara medis, dokter memberikan pengobatan pneumonia serta cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi ringan yang turut berkontribusi terhadap delirium. Secara keperawatan, pendekatan psikososial seperti terapi realitas dan orientasi secara rutin diterapkan untuk membantu lansia mengenali tempat, waktu, dan orang-orang di sekitarnya. Lingkungan rumah sakit disesuaikan agar lebih tenang, dengan pencahayaan yang redup saat malam hari, serta penjadwalan kegiatan perawatan yang lebih teratur untuk memperbaiki pola tidur lansia. Tim keperawatan juga melibatkan keluarga secara intensif untuk mendampingi lansia secara bergantian agar lansia merasa nyaman dan aman.

Setelah satu minggu penerapan intervensi ini, kondisi lansia mulai membaik. Agitasi berkurang drastis, lansia kembali mampu mengenali anggota keluarganya, orientasi tempat dan waktu membaik, dan pola tidur kembali normal. Evaluasi lanjutan setelah dua minggu menunjukkan bahwa delirium sudah teratasi sepenuhnya, pneumonia telah sembuh secara signifikan, dan lansia siap dipulangkan dalam kondisi yang jauh lebih stabil baik secara fisik maupun mental. Dampak intervensi pada kesehatan mental lansia terlihat dari ekspresi yang lebih tenang, rasa nyaman, serta berkurangnya kecemasan yang dirasakan selama masa perawatan.

Analisis terhadap ketiga studi kasus ini secara konsisten memperlihatkan bahwa intervensi keperawatan berbasis bukti mampu memberikan dampak yang sangat positif terhadap penanganan sindrom geriatri. Pendekatan holistik yang melibatkan aspek preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif sangat penting dalam memastikan keberhasilan intervensi. Lebih dari itu, intervensi ini juga memperlihatkan dampak nyata pada peningkatan kesehatan mental lansia, seperti berkurangnya kecemasan, depresi, peningkatan kepercayaan diri, serta meningkatnya partisipasi lansia dalam kehidupan sosial yang lebih aktif dan bermakna.

H. Strategi Penguatan Kesehatan Mental Lansia

Kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penuaan, namun seringkali masih diabaikan dibandingkan dengan kesehatan fisik. Seiring bertambahnya usia, lansia tidak hanya menghadapi tantangan fisik akibat penurunan fungsi tubuh, tetapi juga menghadapi beragam tantangan psikologis seperti kecemasan, depresi, penurunan fungsi kognitif, hingga perasaan isolasi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan khusus dalam praktik keperawatan untuk memperkuat kesehatan mental lansia, yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif.

Pendekatan keperawatan pertama yang efektif dalam penguatan kesehatan mental lansia adalah terapi psikososial. Terapi ini dirancang khusus untuk membantu lansia mengelola perasaan, pikiran, dan perilaku yang berkaitan erat dengan kondisi psikologis mereka. Salah satu bentuk terapi psikososial yang sering digunakan adalah terapi reminiscence atau terapi nostalgia. Melalui terapi ini, lansia diajak untuk berbagi cerita dan kenangan tentang masa lalu yang positif, dengan tujuan meningkatkan harga diri, rasa percaya diri, dan mengurangi perasaan sedih atau putus asa yang sering muncul akibat perubahan kondisi fisik atau kehilangan orang terdekat. Dengan mengingat kembali momen-momen bahagia dalam hidup, lansia secara tidak langsung akan merasakan kembali kebahagiaan tersebut, memperkuat hubungan emosional dengan lingkungan sosial mereka, serta meningkatkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri.

Selain terapi reminiscence, pendekatan lain dalam terapi psikososial adalah terapi realitas dan orientasi. Terapi ini terutama efektif bagi lansia yang mengalami gangguan kognitif seperti demensia atau delirium. Perawat secara rutin mengajak lansia berdiskusi mengenai peristiwa terkini, seperti tanggal, waktu, tempat, dan aktivitas harian yang sedang mereka jalani. Terapi ini membantu lansia mempertahankan orientasi terhadap lingkungan, mengurangi kebingungan, serta memperlambat progresivitas gangguan kognitif yang dialami. Efektivitas terapi realitas juga semakin meningkat jika dilakukan secara rutin, sabar, dan konsisten, dengan keterlibatan aktif keluarga atau caregiver utama.

Pendekatan keperawatan selanjutnya adalah konseling dukungan (supportive counseling). Konseling dukungan memiliki peran penting dalam membantu lansia menghadapi stres psikologis yang mungkin muncul akibat kondisi fisik yang menurun atau masalah emosional yang berkaitan dengan proses penuaan. Konseling ini biasanya dilakukan secara individual maupun kelompok, tergantung dari kondisi dan preferensi lansia. Dalam sesi konseling, lansia diberikan ruang yang aman dan nyaman untuk mengekspresikan emosi, kekhawatiran, maupun harapan mereka secara terbuka. Perawat atau tenaga kesehatan berperan aktif dalam memberikan empati, mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik positif, serta mendukung lansia dalam menemukan solusi praktis atas permasalahan yang sedang mereka alami. Konseling dukungan terbukti efektif dalam mengurangi perasaan tertekan, cemas, atau depresi, serta membantu lansia menemukan kembali makna dan tujuan hidup mereka di masa tua.

Strategi penting berikutnya dalam penguatan kesehatan mental lansia adalah melalui aktivitas stimulasi kognitif. Penurunan fungsi kognitif merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi lansia, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Aktivitas stimulasi kognitif dirancang khusus untuk menjaga dan

meningkatkan kemampuan berpikir, konsentrasi, memori, dan pengambilan keputusan lansia. Kegiatan ini mencakup permainan sederhana yang menantang secara kognitif seperti teka-teki silang, puzzle, catur, atau kegiatan seni seperti menggambar dan mewarnai. Selain itu, aktivitas seperti membaca, diskusi buku, mengikuti pelatihan keterampilan baru seperti menggunakan perangkat teknologi sederhana, juga terbukti efektif dalam memperlambat penurunan fungsi kognitif. Stimulasi kognitif yang rutin dilakukan tidak hanya memperkuat fungsi otak, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri lansia dan mengurangi risiko gangguan kognitif yang lebih serius seperti demensia.

Lebih lanjut lagi, lansia sering mengalami perasaan kesepian atau isolasi sosial akibat berbagai faktor seperti kehilangan pasangan hidup, tinggal sendiri, atau berkurangnya mobilitas fisik. Oleh karena itu, intervensi yang dirancang khusus untuk mengurangi isolasi sosial juga merupakan bagian penting dari strategi penguatan kesehatan mental lansia. Perawat dapat mendorong lansia untuk terlibat aktif dalam kegiatan komunitas lokal, seperti klub sosial, kelompok hobi, senam lansia, atau kegiatan keagamaan yang memberikan rasa kebersamaan dan memperkuat jaringan sosial lansia. Aktivitas ini secara efektif membantu lansia membangun hubungan sosial baru, menemukan kembali kebahagiaan dalam berinteraksi dengan sesama, serta mengurangi risiko depresi dan ansietas yang sering muncul akibat isolasi sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, kegiatan berbasis keluarga seperti acara keluarga rutin, kunjungan rutin dari anggota keluarga, atau aktivitas rekreasi bersama juga merupakan intervensi yang sangat penting untuk menjaga keterhubungan emosional lansia dengan keluarga mereka. Keterlibatan keluarga yang aktif dalam kehidupan sehari-hari lansia terbukti mampu meningkatkan rasa nyaman, aman, dan bahagia, yang secara langsung memperkuat kesehatan mental lansia.

Terakhir, strategi penguatan kesehatan mental lansia juga mencakup intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan emosional secara umum. Pendekatan seperti meditasi, teknik relaksasi sederhana, latihan pernapasan dalam, atau yoga lansia terbukti efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, serta meningkatkan ketenangan pikiran. Perawat atau tenaga kesehatan dapat memberikan pelatihan singkat mengenai teknik-teknik ini kepada lansia maupun keluarga mereka untuk dipraktikkan secara mandiri di rumah secara rutin.

I. Evaluasi Keberhasilan Intervensi terhadap Kesehatan Mental Lansia

Evaluasi merupakan tahapan penting dan tidak terpisahkan dalam proses pemberian intervensi keperawatan, terutama dalam konteks kesehatan mental lansia. Setelah berbagai intervensi seperti terapi psikososial, konseling dukungan,

stimulasi kognitif, hingga intervensi sosial diterapkan, sangat penting untuk melakukan evaluasi secara komprehensif guna menilai efektivitas intervensi tersebut. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tujuan intervensi telah tercapai, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan atau adaptasi intervensi lanjutan agar hasil yang diperoleh semakin optimal.

Dalam proses evaluasi keberhasilan intervensi terhadap kesehatan mental lansia, terdapat beberapa indikator penting yang harus diperhatikan secara cermat. Indikator-indikator tersebut meliputi berbagai aspek seperti perubahan dalam kondisi emosional, fungsi kognitif, tingkat kecemasan dan depresi, interaksi sosial, serta tingkat kemandirian lansia dalam aktivitas sehari-hari. Secara emosional, indikator keberhasilan intervensi dapat terlihat dari peningkatan suasana hati, berkurangnya keluhan perasaan sedih atau kesepian, serta adanya perasaan optimis yang muncul kembali dalam kehidupan lansia sehari-hari. Lansia yang sebelumnya tampak murung, menarik diri, atau menunjukkan gejala depresi, akan mulai menampilkan ekspresi yang lebih positif, lebih banyak tersenyum, dan mulai aktif dalam berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Pada aspek kognitif, keberhasilan intervensi dapat dievaluasi dari peningkatan fungsi berpikir, perhatian, memori, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Lansia yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengingat informasi sederhana atau menjalani aktivitas rutin, setelah diberikan stimulasi kognitif, akan menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini dapat terlihat melalui kemampuan lansia dalam mengingat detail penting, melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi lebih baik, serta peningkatan orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang di sekitarnya.

Sementara itu, indikator keberhasilan dari segi interaksi sosial juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi intervensi. Keberhasilan intervensi tercermin dari semakin meningkatnya keterlibatan lansia dalam berbagai aktivitas sosial, seperti bergabung dengan kelompok hobi, aktif mengikuti kegiatan komunitas, atau berpartisipasi dalam kegiatan keluarga secara rutin. Lansia yang berhasil melewati masa isolasi sosial akan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam membangun komunikasi, merasa nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki jaringan sosial yang lebih luas. Keberhasilan ini juga berdampak pada peningkatan rasa percaya diri, penghargaan diri, serta menurunkan tingkat stres psikologis yang dialami lansia.

Selain aspek-aspek tersebut, tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (Activities of Daily Living/ADL) juga merupakan indikator penting yang harus dievaluasi. Intervensi yang berhasil biasanya ditandai dengan meningkatnya

kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti mandi, berpakaian, menyiapkan makanan sederhana, hingga menjaga kebersihan pribadi tanpa banyak bergantung pada bantuan orang lain. Tingkat kemandirian yang tinggi ini merupakan cerminan positif dari kesehatan mental yang stabil dan kualitas hidup yang baik.

Untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pencapaian indikator tersebut, evaluasi perlu dilakukan dengan metode yang terstruktur dan sistematis. Metode evaluasi yang sering digunakan meliputi pengkajian ulang secara berkala, observasi langsung terhadap aktivitas sehari-hari lansia, wawancara mendalam dengan lansia dan keluarga, serta penggunaan berbagai instrumen evaluasi standar yang divalidasi secara ilmiah. Pengkajian ulang biasanya dilakukan dengan interval waktu tertentu, seperti setiap bulan atau setiap tiga bulan setelah intervensi dilakukan. Pada tahap ini, tenaga kesehatan atau perawat melakukan penilaian ulang terhadap kondisi fisik, kognitif, dan emosional lansia, lalu membandingkan hasilnya dengan kondisi sebelum intervensi diterapkan.

Observasi langsung sangat penting untuk melihat perubahan nyata dalam perilaku dan aktivitas lansia sehari-hari. Perawat atau caregiver dapat mengamati secara langsung bagaimana lansia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, apakah terdapat peningkatan partisipasi dalam aktivitas bersama keluarga atau komunitas, serta bagaimana lansia mengelola emosi atau stres psikologis dalam situasi nyata. Observasi ini memberikan data berharga yang dapat melengkapi hasil pengkajian formal.

Selanjutnya, wawancara mendalam dengan lansia dan keluarga menjadi bagian esensial dari proses evaluasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lansia dan keluarga merasakan manfaat dari intervensi yang telah diberikan, serta mendapatkan masukan subjektif yang menggambarkan perubahan psikologis dan emosional secara lebih jelas. Lansia dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti terapi atau intervensi tertentu, sementara keluarga bisa menjelaskan tentang perubahan sikap, perilaku, atau kondisi umum lansia yang mereka amati sehari-hari.

Di samping metode tersebut, instrumen evaluasi standar juga digunakan untuk mendapatkan data yang lebih terukur dan objektif. Beberapa instrumen evaluasi kesehatan mental lansia yang sering digunakan antara lain adalah Geriatric Depression Scale (GDS) untuk menilai tingkat depresi, Mini Mental State Examination (MMSE) atau Montreal Cognitive Assessment (MoCA) untuk menilai fungsi kognitif, serta instrumen lain seperti Quality of Life Scale untuk mengevaluasi peningkatan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Dengan menggunakan

instrumen tersebut, hasil evaluasi dapat disusun secara lebih valid dan reliabel, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan keberhasilan intervensi.

Setelah melakukan evaluasi secara terstruktur dan memperoleh hasilnya, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk menentukan apakah intervensi yang diberikan sudah efektif, atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan intervensi telah tercapai dengan baik, maka pendekatan yang digunakan dapat dipertahankan dan ditingkatkan konsistensinya. Namun, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi kurang efektif atau belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, maka modifikasi atau adaptasi intervensi perlu segera dilakukan.

Modifikasi intervensi dapat berupa penyesuaian frekuensi atau intensitas intervensi yang diberikan, misalnya meningkatkan durasi terapi atau menambah frekuensi kunjungan perawat ke rumah lansia. Adaptasi intervensi juga bisa mencakup penggabungan beberapa pendekatan intervensi yang berbeda, seperti kombinasi terapi psikososial dengan stimulasi kognitif, atau penambahan pendekatan lain seperti konseling keluarga untuk meningkatkan dukungan sosial bagi lansia. Selain itu, adaptasi juga dapat melibatkan penambahan anggota tim multidisiplin seperti psikolog, pekerja sosial, atau fisioterapis untuk memperluas lingkup dukungan yang diberikan kepada lansia.

J. Tantangan dalam Menjaga Kesehatan Mental pada Lansia dengan Sindrom Geriatri

Menjaga kesehatan mental lansia yang mengalami sindrom geriatri merupakan sebuah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam proses asuhan keperawatan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup komunikasi, keterbatasan sumber daya, hambatan kolaborasi multidisiplin, serta berbagai faktor psikologis yang melekat pada lansia dan keluarga yang terlibat langsung dalam perawatan. Memahami tantangan ini secara mendalam menjadi kunci penting dalam memberikan pelayanan keperawatan yang efektif, komprehensif, serta berdampak positif terhadap kesejahteraan mental lansia.

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi dalam menjaga kesehatan mental lansia dengan sindrom geriatri adalah tantangan komunikasi. Lansia yang mengalami kondisi seperti delirium atau gangguan kognitif ringan hingga demensia sering kali mengalami penurunan kemampuan komunikasi yang signifikan. Mereka mungkin mengalami kesulitan memahami pertanyaan, instruksi, atau informasi yang diberikan oleh perawat, dokter, atau bahkan keluarga. Kondisi seperti gangguan pendengaran terkait usia (presbikusis) dan gangguan penglihatan seperti katarak juga memperparah hambatan komunikasi ini. Akibatnya, lansia

menjadi rentan mengalami frustrasi, cemas, dan perasaan tidak dimengerti, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Untuk mengatasi tantangan komunikasi ini, diperlukan keterampilan komunikasi yang sangat baik dari tenaga kesehatan, termasuk kemampuan menggunakan pendekatan empatik, sabar, serta memanfaatkan alat bantu komunikasi visual atau nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah secara efektif.

Selain tantangan komunikasi, keterbatasan sumber daya merupakan kendala yang sering ditemui dalam upaya menjaga kesehatan mental lansia dengan sindrom geriatri. Keterbatasan sumber daya ini tidak hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga mencakup sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang geriatri, sarana dan prasarana yang memadai, serta waktu yang cukup untuk memberikan perhatian intensif kepada lansia. Di banyak fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas, jumlah perawat atau tenaga kesehatan yang terlatih khusus dalam bidang geriatri masih jauh dari mencukupi. Rasio yang tidak ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah pasien lansia menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal, sehingga intervensi kesehatan mental yang komprehensif sulit diterapkan secara optimal. Kondisi ini semakin kompleks karena keterbatasan dalam pengadaan alat bantu seperti pegangan tangan, railing, kursi roda, atau bahkan alat komunikasi khusus yang dapat membantu lansia dalam menjaga mobilitas dan interaksi sosialnya. Solusi atas tantangan ini membutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun institusi kesehatan, untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan khusus tenaga geriatri dan penyediaan sarana pendukung yang lebih baik.

Hambatan kolaborasi multidisiplin juga menjadi tantangan penting dalam menjaga kesehatan mental lansia dengan sindrom geriatri. Sindrom geriatri sendiri merupakan kondisi multifaktorial yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dari berbagai disiplin ilmu kesehatan, seperti keperawatan, kedokteran, psikologi, fisioterapi, nutrisi, hingga terapi okupasi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dan komunikasi antar tenaga profesional dari disiplin yang berbeda sering kali tidak berjalan mulus atau optimal. Kurangnya komunikasi efektif, perbedaan persepsi dalam menyusun rencana asuhan, hingga tumpang tindih tanggung jawab merupakan beberapa hambatan yang sering terjadi. Hambatan ini dapat mengakibatkan lansia tidak mendapatkan perawatan terpadu yang benar-benar menyeluruh, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kondisi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan komunikasi efektif antar tim multidisiplin melalui pertemuan rutin, penyusunan rencana asuhan secara kolaboratif, dan pelatihan bersama untuk membangun pemahaman yang sama tentang peran masing-masing anggota tim.

Tantangan lainnya adalah faktor psikologis dari lansia itu sendiri. Lansia dengan sindrom geriatri cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lansia tanpa sindrom tersebut. Perasaan tidak berguna, khawatir menjadi beban bagi keluarga, atau kehilangan kemandirian akibat kondisi seperti inkontinensia urin atau jatuh, sering kali menjadi pemicu utama munculnya masalah kesehatan mental. Lansia yang pernah mengalami jatuh biasanya cenderung merasa takut untuk bergerak, merasa cemas berlebihan terhadap risiko jatuh kembali, sehingga memilih membatasi aktivitas sehari-harinya. Kondisi ini kemudian memicu isolasi sosial yang pada akhirnya memperburuk gangguan mental. Sementara itu, lansia yang mengalami inkontinensia urin sering kali merasa malu atau rendah diri, sehingga menarik diri dari kegiatan sosial. Mengatasi tantangan psikologis ini membutuhkan intervensi psikososial yang intensif, termasuk konseling dukungan, terapi psikologis yang empatik, serta dukungan emosional yang konsisten baik dari tenaga kesehatan maupun keluarga.

Keterlibatan keluarga merupakan tantangan terakhir yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental lansia dengan sindrom geriatri. Dalam banyak budaya, keluarga memegang peranan sentral dalam perawatan lansia, tetapi sering kali keluarga tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam memberikan dukungan yang tepat. Ketidaktahuan keluarga mengenai tanda-tanda awal gangguan mental, teknik komunikasi efektif, atau bagaimana menghadapi perubahan perilaku lansia dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan yang sesuai. Selain itu, beban fisik dan emosional yang dialami keluarga dalam merawat lansia juga sangat besar, sehingga keluarga sendiri rentan mengalami stres atau kelelahan emosional (*burnout caregiver*). Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan dukungan terus-menerus kepada keluarga, termasuk pelatihan keterampilan perawatan dasar, manajemen stres, dan informasi mengenai layanan dukungan yang tersedia di masyarakat. Dengan memberdayakan keluarga secara tepat, maka dukungan psikososial yang diberikan kepada lansia bisa lebih optimal.

K. Simpulan

Kesehatan mental pada lansia merupakan aspek penting dalam upaya menjaga kualitas hidup secara menyeluruh, khususnya ketika lansia menghadapi berbagai tantangan akibat sindrom geriatri seperti jatuh, inkontinensia urin, dan delirium. Berbagai tantangan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kognitif merupakan permasalahan yang lazim dialami oleh lansia, yang jika tidak dikelola secara tepat akan menurunkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kondisi-kondisi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan manifestasi fisik sindrom geriatri, yang

saling memperburuk dalam sebuah siklus yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan intervensi yang holistik dan multidisiplin.

Teknik pengkajian dan deteksi dini sindrom geriatri menjadi landasan penting dalam memberikan intervensi yang tepat waktu dan efektif. Penggunaan berbagai instrumen khusus seperti Morse Fall Scale, Bladder Diary, dan Confusion Assessment Method (CAM) membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi risiko jatuh, inkontinensia urin, dan delirium secara dini, sehingga intervensi preventif maupun kuratif dapat segera dilakukan. Intervensi keperawatan yang berbasis bukti telah terbukti efektif dalam menangani berbagai sindrom geriatri melalui pendekatan yang mencakup tindakan preventif, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan aspek fisik, tetapi juga secara khusus memperhatikan aspek psikologis atau kesehatan mental lansia, seperti mengurangi kecemasan, depresi, dan meningkatkan rasa percaya diri serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Strategi pencegahan sindrom geriatri melalui edukasi yang intensif kepada keluarga dan lansia juga memainkan peranan kunci dalam mencegah timbulnya komplikasi lebih lanjut. Edukasi mengenai faktor risiko jatuh, inkontinensia urin, delirium, dan dampaknya terhadap kesehatan mental membantu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan praktis keluarga dalam memberikan dukungan yang optimal kepada lansia. Metode komunikasi efektif serta pelatihan keterampilan khusus kepada keluarga juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas intervensi.

Evaluasi keberhasilan intervensi merupakan tahapan kritis yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas berbagai intervensi yang telah diberikan terhadap kondisi kesehatan mental lansia. Indikator seperti perubahan suasana hati, fungsi kognitif, interaksi sosial, serta tingkat kemandirian lansia merupakan parameter penting yang perlu dievaluasi secara sistematis dan berkala. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah intervensi perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak anggota tim multidisiplin.

Namun demikian, implementasi intervensi kesehatan mental pada lansia dengan sindrom geriatri tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama meliputi komunikasi yang efektif dengan lansia, keterbatasan sumber daya baik manusia maupun fasilitas pendukung, hambatan dalam kolaborasi multidisiplin, serta faktor psikologis lansia sendiri termasuk keterlibatan keluarga yang seringkali kurang optimal. Upaya mengatasi tantangan tersebut memerlukan pendekatan holistik, pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan,

peningkatan kerja sama antar disiplin ilmu, serta edukasi dan pemberdayaan keluarga secara aktif.

L. Referensi

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., Text Revision DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Bickford, D., Morin, R. T., & Thomas, K. S. (2020). Geriatric syndromes and mental health: Exploring the interconnectedness. *Journal of the American Geriatrics Society*, 68(11), 2618–2625. <https://doi.org/10.1111/jgs.16838>
- Clegg, A., Young, J., Iliffe, S., Rikkert, M. O., & Rockwood, K. (2019). Frailty in elderly people: Understanding geriatric syndromes and management strategies. *The Lancet*, 381(9868), 752–762. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)62167-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)62167-9)
- Fong, T. G., Davis, D., Growdon, M. E., Albuquerque, A., & Inouye, S. K. (2019). Delirium in elderly adults: Diagnosis, prevention, and management. *Nature Reviews Neurology*, 15(4), 210–223. <https://doi.org/10.1038/s41582-019-0134-3>
- Inouye, S. K., Westendorp, R. G., & Saczynski, J. S. (2019). Delirium in elderly people. *The Lancet*, 383(9920), 911–922. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60688-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60688-1)
- National Institute on Aging. (2021). Understanding anxiety disorders in older adults. Retrieved from <https://www.nia.nih.gov/health/anxiety-older-adults>
- Overcash, J. (2021). Geriatric assessment and intervention in older adults with mental health disorders. *Clinical Journal of Oncology Nursing*, 25(1), 24–29. <https://doi.org/10.1188/21.CJON.24-29>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Quinn, K., Herman, L., & Wagner, C. (2020). Preventing falls in older adults: Interventions and implications for mental health. *Journal of Gerontological Nursing*, 46(4), 17–22. <https://doi.org/10.3928/00989134-20200305-03>
- Resnick, B. (Ed.). (2019). *Geriatric nursing review syllabus: A core curriculum in advanced practice geriatric nursing* (5th ed.). American Geriatrics Society.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2021). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry* (12th ed.). Wolters Kluwer.
- Stewart, R., & Arlt, S. (2020). Depression and cognitive impairment in older adults: Interactions, management, and implications for nursing practice. *International Journal of Older People Nursing*, 15(3), e12305. <https://doi.org/10.1111/opn.12305>

Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2022). Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging (6th ed.). Elsevier Health Sciences.

World Health Organization. (2021). Mental health of older adults. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>

M. Glosarium

Agitasi: Kondisi emosional yang ditandai oleh kegelisahan ekstrem, kecemasan, dan ketidakmampuan untuk tetap tenang, sering kali disertai gerakan tubuh yang gelisah atau perilaku impulsif.

Delirium: Gangguan akut pada kesadaran dan perhatian yang ditandai oleh kebingungan, disorientasi, halusinasi, serta perubahan perilaku yang terjadi dalam waktu singkat.

Demensia: Sindrom kronis yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif progresif seperti gangguan memori, berpikir, orientasi, pemahaman, bahasa, dan kemampuan pengambilan keputusan.

Depresi: Gangguan suasana hati serius yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, hilangnya minat atau semangat hidup, kelelahan kronis, gangguan tidur, dan pikiran negatif termasuk tentang kematian.

Disorientasi: Kondisi ketidakmampuan seseorang mengenali waktu, tempat, atau orang di sekitarnya, sering kali terkait dengan gangguan kognitif atau delirium.

Geriatri: Cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan penyakit pada populasi lanjut usia, termasuk penanganan berbagai kondisi yang khas dialami lansia.

Inkontinensia Urin: Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol pengeluaran urin secara sadar, mengakibatkan kebocoran urin tanpa disengaja, dan berdampak signifikan pada kondisi emosional lansia.

Isolasi Sosial: Kondisi ketika seseorang merasa terpisah atau menjauh dari lingkungan sosialnya, seringkali disebabkan oleh perasaan malu, rendah diri, atau kondisi kesehatan yang membatasi aktivitas sosial.

Kecemasan: Kondisi psikologis yang ditandai rasa takut atau khawatir yang berlebihan dan tidak rasional, sering kali disertai gejala fisik seperti sakit kepala, insomnia, gangguan pencernaan, dan iritabilitas.

Kognitif: Berkaitan dengan proses berpikir, termasuk kemampuan memori, perhatian, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan.

Lingkaran Negatif: Kondisi di mana masalah kesehatan fisik memperburuk kondisi psikologis, dan sebaliknya, sehingga menciptakan siklus terus-menerus yang memperparah kondisi keseluruhan lansia.

Multifaktorial: Melibatkan banyak faktor atau penyebab yang saling terkait, digunakan dalam konteks menjelaskan penyebab kondisi seperti sindrom geriatri yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor tunggal.

Orientasi: Kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali waktu, tempat, dan situasi yang dihadapinya, penting dalam mempertahankan kesehatan mental dan kestabilan psikologis.

Pengkajian: Proses sistematis pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan atau risiko yang dimiliki pasien, khususnya dalam konteks keperawatan lansia.

Preventif: Upaya atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kondisi penyakit atau gangguan kesehatan.

Promotif: Tindakan atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu melalui edukasi, sosialisasi, atau perubahan gaya hidup sehat.

Psikososial: Aspek yang melibatkan interaksi antara faktor psikologis (seperti emosi, pikiran) dan faktor sosial (seperti hubungan interpersonal, lingkungan sosial).

Rehabilitatif: Tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan kemampuan individu semaksimal mungkin setelah mengalami kondisi penyakit atau cedera tertentu.

Sindrom Geriatri: Serangkaian kondisi kesehatan yang khas terjadi pada lansia, seperti jatuh, inkontinensia urin, delirium, yang biasanya disebabkan oleh proses penuaan dan interaksi berbagai faktor risiko.

Stimulasi Kognitif: Aktivitas yang bertujuan meningkatkan atau mempertahankan fungsi kognitif, seperti memori, perhatian, pemikiran logis, dan kemampuan mengambil keputusan, melalui berbagai aktivitas terstruktur.

Terapi Nostalgia (Reminiscence): Terapi psikososial di mana lansia diajak mengingat kembali pengalaman positif di masa lalu, bertujuan meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.

Terapi Realitas dan Orientasi: Pendekatan terapi yang membantu individu dengan gangguan kognitif menjaga kesadaran tentang waktu, tempat, dan situasi, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan kecemasan.

Wawancara Terstruktur: Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan spesifik dan sistematis untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kondisi kesehatan dan psikologis seseorang.

CHAPTER 7

MANAJEMEN NUTRISI DAN HIDRASI PADA LANSIA

Nurhayati, SKM., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Manajemen nutrisi dan hidrasi merupakan komponen esensial dalam menjaga kualitas hidup lansia, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak proses penuaan yang tidak bisa dihindari. Kelompok lanjut usia (lansia) menghadapi berbagai tantangan khusus terkait pemenuhan kebutuhan gizi dan cairan, yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisiologis, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, perhatian serius dan pendekatan yang tepat dalam manajemen nutrisi dan hidrasi sangat diperlukan untuk mempertahankan kesehatan optimal, memperpanjang harapan hidup yang berkualitas, serta meminimalkan risiko penyakit kronis atau komplikasi kesehatan lainnya yang sering dialami lansia.

Secara fisiologis, seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan yang berdampak langsung pada status nutrisi dan hidrasi mereka. Salah satu perubahan utama adalah penurunan massa otot yang dikenal sebagai sarcopenia, kondisi ini menyebabkan berkurangnya kemampuan fisik dan meningkatnya kebutuhan protein guna mempertahankan kekuatan dan fungsi otot secara optimal. Selain itu, lansia juga mengalami perubahan sistem pencernaan seperti berkurangnya produksi enzim, penurunan motilitas usus, serta perubahan selera makan yang menurun drastis akibat menurunnya sensitivitas terhadap rasa dan aroma makanan. Kondisi-kondisi ini secara langsung mengurangi jumlah asupan nutrisi lansia dan meningkatkan risiko malnutrisi yang jika tidak ditangani segera akan memicu berbagai masalah kesehatan serius.

Selain nutrisi, kebutuhan cairan pada lansia juga memerlukan perhatian khusus karena terjadi penurunan signifikan pada fungsi fisiologis yang mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Lansia umumnya mengalami penurunan rasa haus yang sangat drastis, meskipun tubuh sebenarnya membutuhkan cairan yang cukup untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis secara efektif. Kondisi ini menyebabkan lansia cenderung kurang minum dan berisiko tinggi mengalami dehidrasi kronis. Dehidrasi kronis yang tidak segera diatasi akan memicu berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi ginjal, konstipasi, gangguan elektrolit, bahkan gangguan kognitif akut seperti delirium. Oleh karena itu, pemahaman

mengenai pentingnya hidrasi yang tepat serta strategi untuk memastikan kecukupan asupan cairan secara rutin menjadi sangat krusial dalam merawat lansia.

Dari sisi psikologis, perubahan emosi seperti depresi, kesepian, dan isolasi sosial sering terjadi pada lansia. Kondisi emosional yang buruk ini dapat menyebabkan penurunan minat terhadap makanan, bahkan seringkali menyebabkan lansia melewatkan waktu makan secara rutin. Akibatnya, pola makan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan penurunan status gizi secara bertahap namun pasti, yang jika dibiarkan tanpa penanganan khusus akan memperparah berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan dalam manajemen nutrisi lansia harus melibatkan aspek psikososial seperti pemberian dukungan emosional, pendampingan selama waktu makan, serta menciptakan lingkungan makan yang nyaman dan menyenangkan.

Sementara itu, dari perspektif sosial dan lingkungan, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan air minum yang memadai juga menjadi tantangan utama yang dihadapi lansia. Banyak lansia yang tinggal sendirian di rumah tanpa pendamping atau keluarga yang memadai, sehingga sering mengalami kesulitan dalam menyiapkan makanan bergizi secara teratur dan memenuhi kebutuhan hidrasi mereka dengan baik. Selain itu, beberapa lansia menghadapi hambatan seperti kesulitan finansial dalam membeli bahan makanan bergizi atau kendala fisik yang membatasi mobilitas mereka untuk mendapatkan akses makanan dan cairan. Oleh karena itu, manajemen nutrisi dan hidrasi harus melibatkan keluarga maupun komunitas secara aktif dalam memastikan bahwa lansia memiliki akses yang cukup terhadap makanan dan cairan bergizi secara teratur.

B. Pentingnya Manajemen Nutrisi dan Hidrasi pada Lansia

Manajemen nutrisi dan hidrasi merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan secara serius pada kelompok lanjut usia (lansia), terutama karena adanya perubahan fisiologis yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Perubahan-perubahan fisiologis tersebut berdampak signifikan terhadap kebutuhan nutrisi dan hidrasi yang harus dipenuhi agar lansia dapat tetap menjaga kesehatan optimal. Salah satu perubahan utama yang terjadi pada lansia adalah penurunan massa otot atau yang dikenal sebagai sarkopenia. Kondisi ini secara alami terjadi akibat proses penuaan, ditandai dengan berkurangnya jumlah dan kualitas massa otot, yang berdampak langsung pada menurunnya kemampuan fisik lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, lansia membutuhkan asupan nutrisi yang lebih spesifik, khususnya protein dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan otot agar tidak semakin melemah.

Selain penurunan massa otot, sistem pencernaan pada lansia juga mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Fungsi organ-organ pencernaan mulai menurun, yang menyebabkan gangguan dalam penyerapan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan protein. Misalnya, produksi enzim pencernaan mulai berkurang, pergerakan usus melambat, dan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi menjadi tidak maksimal. Akibatnya, lansia sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, kembung, atau bahkan diare kronis yang pada akhirnya menyebabkan mereka malas atau enggan makan. Selain itu, sensitivitas indera pengecap dan penciuman pada lansia juga berkurang, sehingga makanan yang tadinya terasa nikmat menjadi kurang menggugah selera makan. Faktor-faktor ini mengakibatkan lansia cenderung mengurangi jumlah makanannya atau memilih jenis makanan tertentu yang kurang bergizi, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi.

Di sisi lain, lansia juga mengalami penurunan sensitivitas terhadap rasa haus, sebuah mekanisme tubuh yang seharusnya membantu individu untuk tetap menjaga hidrasi secara optimal. Penurunan rasa haus ini menyebabkan lansia tidak menyadari bahwa tubuh mereka sedang mengalami kekurangan cairan, bahkan meskipun tubuh sebenarnya sangat membutuhkan hidrasi yang cukup. Kondisi ini meningkatkan risiko lansia mengalami dehidrasi kronis yang berlangsung secara bertahap tanpa disadari. Jika tidak segera diatasi, dehidrasi dapat menyebabkan berbagai gangguan serius pada lansia, seperti gangguan fungsi ginjal, gangguan elektrolit yang berbahaya, hingga penurunan kemampuan kognitif yang secara akut dapat berkembang menjadi kondisi seperti delirium atau kebingungan mendadak.

Pentingnya manajemen nutrisi dan hidrasi pada lansia juga dapat dilihat dari hubungannya dengan kualitas hidup dan pencegahan penyakit kronis. Kebutuhan nutrisi dan hidrasi yang terpenuhi dengan baik memungkinkan lansia untuk menjaga tingkat energi dan daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Status nutrisi yang baik akan membantu menjaga fungsi kekebalan tubuh, mengurangi risiko terkena infeksi atau penyakit degeneratif, serta mempercepat proses pemulihan bila terjadi sakit atau cedera. Di sisi lain, hidrasi yang cukup akan membantu menjaga keseimbangan elektrolit, fungsi ginjal, serta fungsi kognitif yang optimal, yang secara keseluruhan berperan besar dalam mempertahankan kualitas hidup yang tinggi di usia lanjut.

Sebaliknya, apabila manajemen nutrisi dan hidrasi pada lansia diabaikan atau tidak terpenuhi secara optimal, maka berbagai konsekuensi serius akan terjadi pada kondisi fisik maupun mental lansia tersebut. Malnutrisi, misalnya, merupakan kondisi yang sering dialami oleh lansia yang tidak mendapatkan nutrisi seimbang dalam waktu yang cukup lama. Malnutrisi ini akan menyebabkan berbagai masalah seperti

melemahnya sistem imun, meningkatnya risiko infeksi, osteoporosis, anemia, dan bahkan dapat memicu gangguan fungsi organ-organ penting dalam tubuh. Secara mental, malnutrisi juga berdampak negatif terhadap mood dan kesejahteraan psikologis lansia, meningkatkan risiko depresi dan kecemasan akibat tubuh yang lemah serta rasa tidak nyaman secara fisik.

Demikian pula halnya dengan dehidrasi, yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak serius bagi lansia, seperti gangguan pada fungsi ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal kronis, gangguan fungsi jantung akibat ketidakseimbangan elektrolit, dan meningkatnya risiko jatuh akibat pusing atau hipotensi ortostatik (penurunan tekanan darah saat berdiri). Dehidrasi kronis juga dapat menyebabkan gangguan kognitif seperti kebingungan akut (delirium), hilangnya orientasi, gangguan konsentrasi, hingga meningkatkan risiko terjadinya demensia yang memperburuk kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

C. Teknik Pengkajian Status Gizi dan Hidrasi pada Lansia

Pengkajian status gizi dan hidrasi pada lansia merupakan tahap awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan nutrisi dan cairan lansia terpenuhi secara optimal. Dengan pengkajian yang tepat, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya dapat mengidentifikasi secara dini berbagai gangguan atau risiko malnutrisi dan dehidrasi yang mungkin dialami oleh lansia. Pengkajian yang komprehensif ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari pemeriksaan fisik dan antropometri hingga penggunaan instrumen khusus serta observasi klinis dan pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan fisik dan antropometri adalah langkah pertama dalam proses pengkajian status gizi lansia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan data objektif mengenai kondisi fisik lansia yang berkaitan langsung dengan status nutrisi mereka. Dalam pemeriksaan fisik, tenaga kesehatan secara seksama mengamati tanda-tanda klinis yang menunjukkan adanya gangguan nutrisi atau hidrasi. Misalnya, lansia yang mengalami malnutrisi sering menunjukkan gejala seperti penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu singkat, penurunan massa otot yang jelas, kulit kering dan kusam, serta rambut yang mudah rontok dan rapuh. Selain itu, lansia dengan gangguan hidrasi dapat memperlihatkan tanda-tanda seperti kulit yang kering dan kurang elastis, bibir yang pecah-pecah, lidah kering, serta penurunan produksi air mata atau saliva.

Selain pengamatan klinis tersebut, pengukuran antropometri juga sangat penting untuk mendapatkan gambaran kuantitatif tentang status nutrisi lansia. Pengukuran ini mencakup berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), lingkar lengan atas (LLA), dan lingkar betis. Berat badan dan tinggi badan lansia

sangat penting diukur secara rutin karena keduanya dapat menggambarkan perubahan signifikan dalam status nutrisi. Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan apakah lansia berada dalam kategori normal, kurus, atau gemuk, yang nantinya berguna dalam menentukan intervensi nutrisi yang tepat. Pengukuran lingkaran lengan atas (LLA) dan lingkaran betis khususnya berguna untuk mengevaluasi massa otot yang sering kali menurun pada lansia akibat proses penuaan atau malnutrisi. Dengan rutin melakukan pemeriksaan antropometri ini, tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan atau perubahan status gizi lansia dari waktu ke waktu.

Di samping pemeriksaan fisik dan antropometri, penggunaan instrumen khusus seperti Mini Nutritional Assessment (MNA) menjadi bagian integral dari teknik pengkajian status gizi lansia. MNA merupakan instrumen yang telah divalidasi secara luas untuk menilai risiko malnutrisi pada lansia dengan cara yang praktis, cepat, namun tetap komprehensif. Alat pengkajian ini terdiri dari berbagai komponen pertanyaan dan pengamatan, seperti penurunan asupan makanan, penurunan berat badan selama tiga bulan terakhir, gangguan mobilitas, stres psikologis atau penyakit akut yang diderita lansia, gangguan neuropsikologis seperti depresi atau demensia, hingga indeks massa tubuh dan lingkaran betis lansia. Hasil akhir dari MNA akan mengklasifikasikan status gizi lansia menjadi normal, berisiko malnutrisi, atau malnutrisi, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah intervensi nutrisi yang sesuai.

Dalam konteks pengkajian status hidrasi pada lansia, pendekatan observasi klinis memiliki peranan penting. Observasi klinis ini melibatkan pengamatan langsung terhadap kondisi umum lansia yang berkaitan erat dengan status hidrasi mereka. Tenaga kesehatan perlu mengamati berbagai tanda fisik yang secara spesifik menunjukkan kondisi hidrasi lansia, seperti elastisitas kulit, kondisi selaput lendir mulut (mukosa oral), produksi urin, warna urin, serta frekuensi buang air kecil. Lansia yang mengalami dehidrasi sering kali memperlihatkan tanda klinis seperti kulit yang kehilangan elastisitasnya, bibir dan lidah yang tampak kering, penurunan produksi urin secara signifikan, atau urin yang berwarna lebih pekat dan berbau kuat. Pengamatan klinis ini memberikan informasi cepat dan penting mengenai apakah lansia mengalami kekurangan cairan atau tidak.

Selain observasi klinis, pemeriksaan laboratorium juga menjadi bagian penting dalam pengkajian hidrasi lansia secara lebih akurat dan objektif. Pemeriksaan laboratorium biasanya dilakukan melalui analisis darah dan urin, yang bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan elektrolit, kadar kreatinin dan ureum darah, serta osmolalitas serum yang dapat mencerminkan tingkat hidrasi lansia secara spesifik. Misalnya, peningkatan kadar natrium (hipernatremia) atau kadar ureum darah yang

tinggi sering kali menjadi indikator bahwa lansia mengalami dehidrasi. Demikian pula pemeriksaan urin yang menunjukkan peningkatan berat jenis (specific gravity) dan penurunan volume urin secara signifikan menguatkan diagnosis bahwa lansia sedang mengalami kekurangan cairan. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium ini, tenaga kesehatan dapat menentukan intervensi hidrasi yang lebih tepat dan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut akibat dehidrasi yang tidak terdeteksi.

D. Intervensi Keperawatan untuk Mengatasi Gangguan Nutrisi dan Hidrasi pada Lansia

Intervensi keperawatan yang efektif untuk mengatasi gangguan nutrisi dan hidrasi pada lansia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari kondisi medis individu hingga preferensi pribadi lansia. Intervensi tersebut bertujuan memastikan bahwa kebutuhan nutrisi dan cairan terpenuhi secara optimal, sehingga kualitas hidup lansia dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Salah satu bentuk intervensi yang penting adalah penyusunan diet khusus yang disesuaikan dengan kondisi medis lansia. Lansia sering mengalami berbagai kondisi kesehatan kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal kronik, atau gangguan gastrointestinal yang memerlukan pengaturan diet secara spesifik. Dalam hal ini, perawat bekerja sama dengan ahli gizi untuk menyusun pola makan yang tepat, mencakup jenis makanan, frekuensi makan, porsi makanan, serta pembatasan nutrisi tertentu sesuai dengan kebutuhan medis lansia. Misalnya, lansia dengan hipertensi akan disarankan menjalani diet rendah garam, sementara lansia dengan diabetes mellitus memerlukan pengaturan diet rendah gula dan kaya serat. Diet khusus yang disusun tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas kondisi medis lansia tetapi juga mempertimbangkan selera dan preferensi lansia sehingga tetap menarik dan menyenangkan bagi mereka untuk menjalani diet tersebut.

Selain menyusun pola makan khusus, pendampingan dan pemantauan asupan cairan harian lansia juga merupakan intervensi yang sangat penting. Lansia sering kali tidak menyadari pentingnya konsumsi cairan yang cukup, atau mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan cairan karena gangguan mobilitas atau lupa akibat penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, perawat harus secara aktif mendampingi lansia dalam memenuhi kebutuhan cairannya, misalnya dengan mengingatkan lansia secara rutin untuk minum, menyediakan air minum yang mudah dijangkau, serta mencatat jumlah cairan yang dikonsumsi setiap hari. Pendampingan ini juga melibatkan edukasi kepada keluarga atau caregiver mengenai cara memantau tanda-tanda dehidrasi serta pentingnya menjaga asupan

cairan harian yang cukup, sehingga mereka dapat turut serta membantu dalam memastikan kebutuhan hidrasi lansia terpenuhi.

Intervensi keperawatan yang berbasis bukti juga sangat diperlukan dalam mengatasi gangguan makan yang sering ditemukan pada lansia, seperti anoreksia dan disfagia. Anoreksia atau hilangnya nafsu makan pada lansia bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti efek samping obat, gangguan penciuman atau pengecap, depresi, atau kondisi medis tertentu. Dalam mengatasi anoreksia, perawat harus menerapkan pendekatan yang komprehensif, seperti menyajikan makanan dalam porsi kecil tetapi sering, meningkatkan daya tarik makanan melalui variasi warna, aroma, dan tekstur, serta menciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan. Pendekatan ini didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa presentasi makanan yang menarik secara visual serta lingkungan makan yang nyaman dapat meningkatkan nafsu makan lansia secara signifikan.

Sementara itu, disfagia atau gangguan menelan merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan lansia mengalami risiko tinggi terhadap malnutrisi, aspirasi, dan pneumonia aspirasi. Dalam menghadapi kasus disfagia, perawat bersama tenaga kesehatan lainnya seperti ahli terapi wicara dan ahli gizi akan menerapkan intervensi khusus berupa modifikasi tekstur makanan dan cairan, latihan menelan, serta penggunaan posisi makan tertentu yang lebih aman. Misalnya, lansia dengan disfagia sering kali disarankan mengonsumsi makanan dengan tekstur lembut atau makanan cair yang telah dikentalkan untuk mengurangi risiko aspirasi. Selain itu, lansia juga diajarkan teknik-teknik menelan yang aman seperti posisi duduk tegak selama makan dan setelah makan untuk mengurangi kemungkinan aspirasi cairan ke dalam paru-paru.

Aspek terakhir dalam intervensi keperawatan yang efektif untuk mengatasi gangguan nutrisi dan hidrasi pada lansia adalah kolaborasi multidisiplin. Kolaborasi ini merupakan kunci keberhasilan dalam manajemen nutrisi dan hidrasi, karena permasalahan yang dialami lansia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek kesehatan. Dalam pendekatan multidisiplin ini, perawat tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dengan dokter, ahli gizi, ahli terapi wicara, fisioterapis, psikolog, serta pekerja sosial. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan dapat mengatasi permasalahan nutrisi dan hidrasi secara menyeluruh, dari aspek medis hingga psikososial. Pertemuan tim multidisiplin dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi perkembangan lansia, mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan nutrisi dan hidrasi, serta merancang intervensi lanjutan yang tepat sasaran.

E. Edukasi Keluarga tentang Pola Makan Sehat dan Kebutuhan Hidrasi Lansia

Edukasi kesehatan kepada keluarga tentang pola makan sehat dan pemenuhan kebutuhan hidrasi pada lansia menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup lansia secara optimal. Pemahaman yang baik dari pihak keluarga tentang prinsip nutrisi dan hidrasi dapat membantu memastikan lansia mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang serta cairan yang cukup, sehingga mereka terhindar dari berbagai risiko kesehatan yang serius seperti malnutrisi dan dehidrasi.

Prinsip dasar nutrisi seimbang pada lansia merupakan konsep penting yang harus diketahui oleh keluarga. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan nutrisi lansia mengalami perubahan yang signifikan akibat adanya penurunan fungsi fisiologis tubuh, perubahan metabolisme, serta berbagai kondisi medis yang umum ditemukan pada usia lanjut. Prinsip dasar nutrisi seimbang untuk lansia menekankan pentingnya pemilihan jenis makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, serat, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat sesuai kebutuhan tubuh lansia. Misalnya, konsumsi protein tinggi kualitas seperti telur, ikan, dan kacang-kacangan sangat dianjurkan untuk menjaga massa otot lansia, sementara asupan serat yang cukup dari sayur dan buah-buahan diperlukan untuk menjaga fungsi pencernaan dan mencegah sembelit, yang merupakan masalah umum pada lansia. Selain itu, keluarga juga perlu memahami pentingnya membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh yang dapat memperburuk kondisi kesehatan kronis lansia seperti diabetes dan hipertensi.

Selain memahami prinsip dasar nutrisi, keluarga juga perlu diberikan edukasi mengenai teknik praktis dalam pengaturan menu dan jadwal makan lansia. Keterampilan ini sangat membantu keluarga dalam memastikan bahwa pola makan lansia teratur, mencukupi kebutuhan nutrisi, dan tetap menarik untuk dikonsumsi. Sebagai contoh, keluarga dapat diajarkan bagaimana membuat jadwal makan yang rutin dengan interval waktu yang konsisten, seperti tiga kali makan utama yang diselingi dua kali makanan ringan. Jadwal yang konsisten membantu menjaga stabilitas kadar gula darah dan mencegah lansia mengalami rasa lapar berlebih yang bisa menyebabkan lansia mengalami kekurangan energi atau asupan yang tidak teratur. Dalam mengatur menu, keluarga juga didorong untuk memvariasikan jenis makanan setiap harinya agar lansia tidak bosan serta memberikan menu dengan tekstur dan rasa yang sesuai preferensi lansia, terutama bagi mereka yang mengalami penurunan fungsi penciuman atau pengecap. Teknik praktis seperti memotong makanan menjadi ukuran kecil, memasak makanan dengan cara dikukus atau direbus untuk mempertahankan kandungan nutrisinya, serta menyediakan

camilan sehat yang mudah dikonsumsi seperti yoghurt atau buah segar juga penting diterapkan oleh keluarga dalam mendukung pola makan sehat lansia.

Strategi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan cairan secara teratur juga menjadi fokus utama dalam edukasi keluarga. Pemenuhan hidrasi yang baik pada lansia seringkali terabaikan, padahal dehidrasi merupakan kondisi yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan lansia, seperti menyebabkan gangguan ginjal, infeksi saluran kemih, konstipasi, bahkan delirium. Dalam hal ini, keluarga dapat diajarkan berbagai strategi sederhana yang efektif, seperti menyediakan air minum dalam botol atau gelas yang mudah dijangkau oleh lansia di berbagai tempat dalam rumah, seperti di ruang tamu, kamar tidur, dan meja makan. Selain itu, keluarga juga dapat menerapkan strategi pemberian cairan secara rutin dengan mengingatkan lansia untuk minum setiap 1-2 jam sekali, atau menyediakan cairan tambahan dalam bentuk sup, jus buah alami, atau minuman lain yang disukai lansia. Penggunaan alat bantu seperti botol minum dengan takaran juga bisa membantu keluarga memantau jumlah cairan yang dikonsumsi lansia setiap harinya, sehingga memastikan kebutuhan cairan harian lansia terpenuhi dengan baik.

Peran keluarga juga sangat vital dalam mengawasi tanda-tanda adanya gangguan nutrisi dan hidrasi pada lansia. Dalam edukasi ini, keluarga perlu dibekali pengetahuan tentang tanda-tanda awal gangguan nutrisi, seperti penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu singkat, penurunan nafsu makan, kelemahan fisik yang tidak biasa, kulit yang pucat, atau perubahan perilaku emosional yang menunjukkan depresi atau apatis. Di sisi lain, keluarga juga harus memahami tanda-tanda dehidrasi pada lansia, seperti mulut dan bibir yang kering, urin yang berwarna gelap dan berbau menyengat, rasa lelah yang ekstrem, pusing, kebingungan, hingga penurunan kesadaran dalam kasus dehidrasi yang berat. Dengan mengenali tanda-tanda tersebut, keluarga dapat bertindak cepat dalam memberikan respon berupa peningkatan asupan nutrisi dan cairan, atau segera menghubungi tenaga kesehatan profesional jika kondisi lansia memburuk atau memerlukan intervensi lebih lanjut.

F. Pencegahan Malnutrisi dan Dehidrasi pada Lansia di Rumah dan Komunitas

Upaya pencegahan malnutrisi dan dehidrasi pada lansia, baik di lingkungan rumah maupun komunitas, merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah munculnya berbagai komplikasi serius. Dengan bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehari-hari, sehingga diperlukan pendekatan yang proaktif dan integratif untuk memastikan kondisi tersebut dapat dicegah secara efektif.

Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan modifikasi lingkungan rumah yang ditujukan untuk memudahkan lansia dalam mengakses makanan dan minuman. Lingkungan rumah yang ramah lansia dapat dirancang dengan cara sederhana, seperti meletakkan persediaan makanan ringan sehat dan minuman dalam jangkauan lansia. Misalnya, makanan dan minuman dapat ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau tanpa harus lansia membungkuk atau menaiki kursi, serta menggunakan wadah makanan yang mudah dibuka oleh lansia yang memiliki keterbatasan kekuatan atau gerakan. Selain itu, penataan rumah juga dapat dilakukan dengan menambahkan peralatan bantu seperti meja kecil atau troli khusus yang bisa digunakan lansia untuk membawa makanan dan minuman secara lebih mudah dan aman. Langkah-langkah tersebut secara signifikan akan membantu lansia tetap mandiri dan aktif dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehari-hari, sehingga dapat mencegah risiko malnutrisi atau dehidrasi yang sering terjadi akibat kesulitan dalam mengakses makanan dan minuman secara mandiri.

Di tingkat komunitas, program edukasi yang berfokus pada pentingnya nutrisi dan hidrasi bagi lansia perlu digalakkan secara intensif dan terstruktur. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama keluarga dan orang-orang terdekat lansia, tentang dampak serius yang dapat muncul jika lansia mengalami kekurangan nutrisi dan hidrasi dalam jangka panjang. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti seminar, lokakarya, atau kelompok diskusi yang melibatkan keluarga lansia serta anggota komunitas lainnya. Materi edukasi yang diberikan perlu mencakup pemahaman tentang kebutuhan nutrisi khusus lansia, cara menyiapkan makanan yang sehat dan menarik bagi lansia, serta teknik praktis dalam memastikan lansia rutin mengonsumsi cairan secara teratur. Dengan adanya program edukasi yang berkelanjutan ini, komunitas diharapkan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya manajemen nutrisi dan hidrasi yang efektif, sehingga mampu mencegah masalah kesehatan terkait malnutrisi dan dehidrasi di kalangan lansia secara luas.

Selain edukasi, skrining rutin terhadap status gizi dan hidrasi lansia yang dilakukan secara terjadwal oleh tenaga kesehatan komunitas merupakan aspek penting lainnya dalam strategi pencegahan ini. Melalui kegiatan skrining tersebut, tenaga kesehatan dapat melakukan evaluasi dini terhadap kondisi lansia dengan menggunakan berbagai metode yang akurat, seperti pemeriksaan fisik, antropometri, dan instrumen pengkajian status nutrisi seperti Mini Nutritional Assessment (MNA). Demikian pula untuk aspek hidrasi, tenaga kesehatan dapat mengamati tanda-tanda klinis yang mengindikasikan kondisi hidrasi lansia, seperti elastisitas kulit, kondisi mulut dan bibir, serta pemeriksaan urin secara sederhana.

Dengan skrining rutin ini, masalah nutrisi dan hidrasi pada lansia bisa dideteksi secara dini sebelum berkembang menjadi kondisi serius, sehingga intervensi yang tepat dapat segera diberikan. Selain itu, hasil skrining juga dapat menjadi bahan informasi penting yang bisa diberikan kepada keluarga untuk lebih waspada terhadap kondisi lansia di rumah.

Langkah terakhir yang sangat efektif dalam pencegahan malnutrisi dan dehidrasi adalah melalui kolaborasi erat antara komunitas dengan tenaga kesehatan profesional dalam melakukan intervensi dini. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan rumah secara rutin oleh perawat komunitas, penyuluhan kesehatan yang dilakukan secara berkala, serta pembentukan tim multidisiplin yang terdiri dari perawat, dokter, ahli gizi, dan pekerja sosial untuk menangani lansia yang terdeteksi memiliki risiko tinggi mengalami malnutrisi atau dehidrasi. Tim ini bekerja sama secara erat dalam menyusun rencana intervensi khusus berdasarkan kebutuhan masing-masing lansia, mulai dari memberikan rekomendasi diet khusus, latihan fisik ringan, hingga pendampingan emosional dan psikologis. Peran komunitas dalam kolaborasi ini juga sangat vital, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif untuk memantau dan mendukung lansia dalam menjalankan intervensi tersebut.

G. Evaluasi Keberhasilan Manajemen Nutrisi dan Hidrasi Lansia

Evaluasi keberhasilan manajemen nutrisi dan hidrasi pada lansia merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pengelolaan kesehatan lansia secara menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi yang telah diberikan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, seperti memperbaiki status gizi, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Tanpa evaluasi yang komprehensif, tenaga kesehatan dan keluarga tidak akan mampu mengetahui efektivitas dari intervensi yang dilakukan, sehingga sulit untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat jika ditemukan ketidaksesuaian hasil dengan target yang telah ditentukan.

Salah satu aspek krusial dalam evaluasi ini adalah menentukan indikator keberhasilan intervensi nutrisi dan hidrasi pada lansia. Indikator keberhasilan yang digunakan harus mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kondisi fisik, fungsional, serta kualitas hidup lansia. Dari segi fisik, indikator keberhasilan mencakup perubahan positif pada berat badan lansia menuju rentang ideal, peningkatan nilai indeks massa tubuh (IMT), serta membaiknya hasil pemeriksaan laboratorium seperti albumin serum, kadar hemoglobin, atau status elektrolit tubuh. Secara fungsional, indikator keberhasilan terlihat dari meningkatnya kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti makan dan

minum tanpa kesulitan, meningkatnya tingkat energi atau stamina, serta menurunnya keluhan terkait gangguan nutrisi dan hidrasi seperti anoreksia, mual, atau konstipasi. Selain itu, indikator keberhasilan juga mencakup aspek emosional dan psikologis, di mana lansia tampak lebih aktif, ceria, dan memiliki semangat hidup yang lebih baik akibat status nutrisi dan hidrasi yang optimal.

Untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut dapat dipantau secara efektif, diperlukan teknik evaluasi rutin yang dilakukan secara kolaboratif oleh keluarga dan tenaga kesehatan. Evaluasi rutin ini bisa dilaksanakan melalui kunjungan berkala ke rumah lansia atau melalui pemantauan langsung oleh keluarga dalam kehidupan sehari-hari lansia. Keluarga dapat melakukan pemantauan sederhana, seperti pencatatan berat badan secara rutin setiap minggu atau bulan, pencatatan asupan makanan dan cairan harian, serta mengamati perubahan-perubahan perilaku lansia yang berkaitan dengan nutrisi dan hidrasi, misalnya peningkatan nafsu makan atau berkurangnya keluhan sulit menelan makanan. Hasil pemantauan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan saat kunjungan berkala atau konsultasi rutin, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan metode-metode ilmiah yang lebih terstandar, seperti pemeriksaan antropometri yang mencakup pengukuran lingkaran lengan atas, IMT, hingga pemeriksaan laboratorium yang mendetail terkait status nutrisi dan hidrasi lansia.

Selain evaluasi rutin yang dilakukan oleh keluarga dan tenaga kesehatan, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah wawancara mendalam secara berkala dengan lansia dan keluarganya. Melalui wawancara ini, tenaga kesehatan bisa memperoleh informasi kualitatif mengenai bagaimana lansia dan keluarga merasakan perubahan setelah intervensi nutrisi dan hidrasi diberikan. Lansia dapat menyampaikan pengalaman mereka, seperti peningkatan rasa nyaman saat makan, perasaan lebih segar akibat kecukupan cairan tubuh, serta perasaan senang karena mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa merasa terlalu lelah atau lesu. Keluarga pun bisa memberikan pandangan mereka tentang perubahan nyata yang terjadi pada lansia, baik dari segi fisik maupun emosional, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya terlihat dari pemeriksaan medis semata.

Setelah evaluasi rutin tersebut dilakukan dan hasilnya dianalisis secara mendalam, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan strategi adaptasi intervensi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Adaptasi ini merupakan proses kritis yang memastikan bahwa intervensi yang diberikan tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan lansia secara aktual. Strategi adaptasi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penyesuaian jenis makanan atau minuman yang lebih disukai atau lebih mudah dikonsumsi lansia, perubahan

jadwal atau frekuensi pemberian makanan dan cairan agar lebih sesuai dengan pola aktivitas lansia, hingga penyesuaian metode pendampingan lansia dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehari-hari.

Sebagai contoh, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa lansia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan cairan harian, maka adaptasi intervensi bisa dilakukan dengan menambahkan variasi minuman yang lebih menarik bagi lansia, seperti jus buah segar, kaldu hangat, atau minuman herbal dengan rasa yang disukai lansia. Demikian pula, jika lansia mengalami masalah seperti anoreksia atau kehilangan nafsu makan, maka strategi adaptasi dapat berupa pemberian porsi makanan kecil tetapi sering, penggunaan makanan dengan tekstur yang lembut dan mudah ditelan, atau kolaborasi dengan ahli gizi untuk menyusun menu khusus yang lebih menggugah selera lansia. Tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan frekuensi kunjungan untuk memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada lansia, yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan lansia terhadap intervensi yang diberikan.

Di samping itu, strategi adaptasi intervensi juga mencakup penguatan kolaborasi multidisiplin, di mana hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk diskusi antar anggota tim yang terdiri dari perawat, dokter, ahli gizi, psikolog, serta keluarga lansia. Melalui diskusi ini, tim dapat menghasilkan rencana intervensi lanjutan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kondisi nutrisi dan hidrasi lansia secara menyeluruh.

H. Studi Kasus Implementasi Manajemen Nutrisi dan Hidrasi yang Efektif pada Lansia

Implementasi manajemen nutrisi dan hidrasi yang efektif pada lansia dapat dipahami secara mendalam melalui analisis kasus nyata, di mana kasus ini akan memberikan gambaran konkret mengenai pentingnya intervensi yang tepat serta evaluasi rutin yang dilakukan secara komprehensif. Studi kasus berikut ini melibatkan seorang lansia perempuan berusia 76 tahun bernama Ibu Siti, yang mengalami gangguan nutrisi dan hidrasi cukup serius. Ibu Siti tinggal bersama keluarga di rumahnya, namun belakangan menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi kesehatan secara signifikan. Keluarga melaporkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, Ibu Siti sering menolak makan, tampak lesu, kehilangan berat badan, serta mengalami gangguan konsentrasi dan kebingungan yang diduga disebabkan oleh dehidrasi.

Pengkajian awal yang dilakukan oleh tim keperawatan menunjukkan bahwa Ibu Siti mengalami malnutrisi ringan hingga sedang berdasarkan hasil Mini

Nutritional Assessment (MNA). Berat badannya turun sebanyak 6 kg dalam kurun waktu tiga bulan, indeks massa tubuhnya menurun drastis, serta pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar albumin serum rendah, tanda adanya defisiensi nutrisi. Selain itu, melalui observasi klinis ditemukan pula bahwa kulit Ibu Siti tampak kering, turgor kulit menurun, mukosa mulut kering, dan hasil laboratorium menunjukkan tanda-tanda dehidrasi dengan peningkatan nilai hematokrit yang mengindikasikan kekurangan cairan tubuh yang serius.

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim keperawatan menyusun rencana intervensi secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan ahli gizi, dokter, serta keluarga Ibu Siti secara aktif. Intervensi pertama yang dilakukan adalah menyusun diet khusus tinggi kalori dan protein untuk meningkatkan status gizi Ibu Siti, dengan makanan yang disajikan dalam porsi kecil namun frekuensi lebih sering, sebanyak lima hingga enam kali sehari. Makanan juga diolah dalam bentuk lembut atau semi-padat seperti bubur, sup kental, atau makanan yang mudah dikunyah dan ditelan agar Ibu Siti lebih nyaman dan tidak kesulitan makan.

Selain intervensi nutrisi, perhatian serius juga diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan hidrasi Ibu Siti. Tim keperawatan bersama keluarga menyusun jadwal khusus pemberian cairan, di mana keluarga membantu memastikan bahwa Ibu Siti menerima setidaknya 1,5 hingga 2 liter cairan per hari melalui air putih, jus buah segar, sup, dan minuman lainnya yang menarik bagi lansia. Keluarga dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal dehidrasi, seperti kebingungan, pusing, atau kelelahan ekstrem, agar segera bisa memberikan intervensi tambahan berupa pemberian cairan oral secara cepat.

Selama proses intervensi berlangsung, tim keperawatan secara rutin melakukan evaluasi, yakni setiap dua minggu sekali dalam tiga bulan pertama. Evaluasi ini mencakup pemantauan berat badan, status gizi menggunakan MNA, serta evaluasi laboratorium untuk melihat perkembangan kadar albumin dan hematokrit dalam tubuh Ibu Siti. Selain evaluasi fisik, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan wawancara mendalam kepada keluarga dan lansia untuk memahami bagaimana dampak psikologis dan emosional dari intervensi yang diberikan.

Setelah tiga bulan intervensi rutin dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan perbaikan signifikan pada kondisi Ibu Siti. Berat badan Ibu Siti mengalami peningkatan secara bertahap sebanyak 4 kg, status gizi berdasarkan hasil MNA berubah dari kategori malnutrisi sedang ke kategori normal, serta pemeriksaan laboratorium memperlihatkan kadar albumin kembali normal dan nilai hematokrit menunjukkan kondisi hidrasi yang membaik secara nyata. Keluarga juga melaporkan

bahwa Ibu Siti mulai lebih bersemangat, aktif mengikuti aktivitas ringan sehari-hari, serta tidak lagi menunjukkan gejala kebingungan atau konsentrasi yang buruk.

Selain hasil positif secara fisik, keluarga juga merasakan manfaat secara emosional, yaitu berkurangnya stres dan kecemasan mereka dalam merawat lansia yang sebelumnya mengalami berbagai gangguan nutrisi dan hidrasi. Keluarga merasa lebih percaya diri dalam memberikan perawatan sehari-hari, terutama setelah mendapatkan edukasi yang intensif mengenai pengaturan pola makan, pemenuhan cairan, serta deteksi dini tanda-tanda gangguan nutrisi dan hidrasi pada lansia.

Dari studi kasus implementasi ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil sebagai rekomendasi praktik terbaik dalam manajemen nutrisi dan hidrasi pada lansia. Pertama, pendekatan intervensi yang komprehensif dan kolaboratif antar disiplin ilmu kesehatan sangat krusial dalam mencapai hasil optimal. Kolaborasi aktif antara perawat, dokter, ahli gizi, serta keluarga memastikan intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik lansia. Kedua, intervensi berbasis bukti (*evidence-based practice*) seperti penyusunan diet khusus yang mempertimbangkan kondisi medis dan preferensi pribadi lansia memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan lansia terhadap pola makan sehat.

Ketiga, evaluasi rutin yang sistematis dan terstruktur memegang peranan sentral dalam mengukur efektivitas intervensi yang telah diberikan. Evaluasi yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek emosional dan sosial, memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai keberhasilan intervensi. Keempat, edukasi dan keterlibatan aktif keluarga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam manajemen nutrisi dan hidrasi lansia di rumah. Ketika keluarga memiliki pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang baik dalam memberikan perawatan, maka peluang lansia mengalami peningkatan status nutrisi dan hidrasi akan semakin besar.

I. Simpulan

Manajemen nutrisi dan hidrasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya menjaga kualitas hidup lansia secara optimal. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti penurunan massa otot (*sarkopenia*), gangguan fungsi pencernaan, serta penurunan sensitivitas rasa haus, yang secara langsung memengaruhi kebutuhan nutrisi dan cairan mereka. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, lansia dapat mengalami berbagai konsekuensi serius seperti malnutrisi, dehidrasi kronis, hingga berbagai komplikasi kesehatan fisik maupun mental.

Teknik pengkajian yang sistematis menjadi langkah awal penting untuk mengidentifikasi risiko dan kondisi malnutrisi serta dehidrasi pada lansia. Pengkajian meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri, penggunaan instrumen khusus seperti Mini Nutritional Assessment (MNA), observasi klinis, serta pemeriksaan laboratorium. Data hasil pengkajian menjadi dasar dalam menyusun intervensi keperawatan yang tepat, seperti penyusunan diet khusus yang disesuaikan dengan kondisi medis lansia, pendampingan dalam pemenuhan cairan harian, serta intervensi khusus untuk mengatasi anoreksia dan disfagia. Kolaborasi antar disiplin ilmu kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain sangat penting dalam menjamin keberhasilan intervensi tersebut.

Keluarga memainkan peran sentral dalam manajemen nutrisi dan hidrasi lansia di lingkungan rumah. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga tentang pola makan sehat, teknik pengaturan menu dan jadwal makan, serta cara memastikan kecukupan cairan secara teratur menjadi hal yang krusial. Keluarga juga perlu dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan nutrisi dan hidrasi agar intervensi dini dapat dilakukan dengan cepat.

Di tingkat komunitas, upaya pencegahan malnutrisi dan dehidrasi lansia melibatkan modifikasi lingkungan rumah agar memudahkan akses makanan dan minuman, program edukasi rutin kepada masyarakat, skrining status nutrisi dan hidrasi secara berkala, serta kolaborasi erat dengan tenaga kesehatan dalam melakukan intervensi dini. Evaluasi rutin terhadap keberhasilan intervensi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi dan hidrasi lansia terpenuhi dengan baik, serta untuk melakukan adaptasi strategi intervensi yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

J. Referensi

- Abdelhamid, A., Bunn, D., Copley, M., Cowap, V., Dickinson, A., Gray, L., Howe, A., Killett, A., Lee, J., Li, F., Poland, F., Potter, J. F., Richardson, K., Smithard, D., Fox, C., & Hooper, L. (2021). Effectiveness of interventions to directly support food and drink intake in people with dementia: Systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatrics*, 21(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02020-9>
- Alhamdan, A. A., Alsaif, M. A., & Alzaben, K. A. (2022). Nutrition and hydration status assessment among elderly: A critical review. *Clinical Interventions in Aging*, 17, 1343-1360. <https://doi.org/10.2147/CIA.S376298>
- Cederholm, T., Jensen, G. L., Correia, M. I. T. D., Gonzalez, M. C., Fukushima, R., Higashiguchi, T., Baptista, G. A., Barazzoni, R., Blaauw, R., Coats, A. J. S., Crivelli, A., Evans, D. C., Gramlich, L., Fuchs-Tarlovsky, V., Keller, H., Llido, L. O., Malone, A., Mogensen, K. M., Morley, J. E., ... GLIM Core Leadership Committee. (2019). GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the

global clinical nutrition community. *Clinical Nutrition*, 38(1), 1-9.
<https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.002>

Cheng, F. W., Gao, X., Bao, L., Mitchell, D. C., Wood, C., Still, C. D., & Rolston, D. D. K. (2021). Protein intake and muscle health in old age: from biological plausibility to clinical outcomes. *Nutrients*, 13(4), 1367.
<https://doi.org/10.3390/nu13041367>

Corish, C. A., & Bardon, L. A. (2019). Malnutrition in older adults: Screening and determinants. *Proceedings of the Nutrition Society*, 78(3), 372-379.
<https://doi.org/10.1017/S0029665118002628>

Keller, H. H., Carrier, N., Slaughter, S., Lengyel, C., Steele, C. M., Duizer, L., Morrison, J., Brown, K. S., Chaudhury, H., & Duncan, A. M. (2019). Prevalence and determinants of poor food intake of residents living in long-term care. *Journal of the American Medical Directors Association*, 20(9), 1162-1168.
<https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.01.011>

Khadka, J., Visvanathan, R., & Theou, O. (2020). Assessing nutrition and hydration status in older adults: A systematic review of assessment tools. *Nutrients*, 12(11), 3365. <https://doi.org/10.3390/nu12113365>

Morley, J. E. (2020). Dehydration, hypernatremia, and hyponatremia in older adults. *Journal of the American Medical Directors Association*, 21(9), 1257-1259.
<https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.07.017>

Saka, B., Kaya, O., & Ozturk, G. B. (2020). Malnutrition in older adults: Importance of nursing interventions. *Journal of Gerontological Nursing*, 46(11), 23-29.
<https://doi.org/10.3928/00989134-20201013-03>

Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., Hooper, L., Kiesswetter, E., Maggio, M., Raynaud-Simon, A., Sieber, C. C., Sobotka, L., van Asselt, D., Wirth, R., & Bischoff, S. C. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 38(1), 10-47.
<https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024>

K. Glosarium

Sarkopenia

Kondisi penurunan massa otot secara signifikan yang umum dialami lansia, disebabkan oleh proses penuaan yang menyebabkan berkurangnya kekuatan dan fungsi fisik tubuh.

Malnutrisi

Kondisi kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh yang berakibat buruk terhadap kesehatan, khususnya menyebabkan melemahnya sistem imun, anemia, osteoporosis, dan gangguan fungsi organ.

Dehidrasi Kronis

Kondisi kurangnya cairan dalam tubuh secara terus-menerus yang tidak segera ditangani, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan ginjal, gangguan elektrolit, hingga gangguan fungsi kognitif seperti delirium.

Mini Nutritional Assessment (MNA)

Instrumen penilaian status nutrisi khusus untuk lansia yang terdiri dari berbagai pertanyaan dan pengamatan klinis guna menentukan apakah lansia memiliki status nutrisi normal, berisiko malnutrisi, atau mengalami malnutrisi.

Antropometri

Teknik pengukuran tubuh yang digunakan untuk menilai status nutrisi, meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, lingkaran betis, serta indeks massa tubuh (IMT).

Disfagia

Gangguan kesulitan menelan makanan atau minuman yang sering dialami lansia, meningkatkan risiko aspirasi makanan ke paru-paru yang dapat menyebabkan pneumonia aspirasi dan malnutrisi.

Anoreksia (pada lansia)

Hilangnya nafsu makan secara signifikan yang sering dialami lansia akibat berbagai faktor seperti perubahan fisiologis, gangguan penciuman dan pengecap, efek samping obat, depresi, atau kondisi medis tertentu.

Elektrolit

Mineral dalam cairan tubuh yang memiliki muatan listrik, seperti natrium, kalium, dan kalsium, yang penting untuk menjaga fungsi normal sel-sel tubuh. Ketidakseimbangan elektrolit sering terjadi akibat dehidrasi atau kondisi medis lainnya pada lansia.

Hipotensi Ortostatik

Kondisi medis berupa penurunan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba saat seseorang bangkit berdiri, sering dialami oleh lansia akibat dehidrasi atau gangguan sistem kardiovaskular, dan meningkatkan risiko terjatuh.

Delirium

Gangguan akut yang ditandai dengan kebingungan, hilangnya orientasi, kesulitan konsentrasi, serta perubahan tingkat kesadaran. Kondisi ini sering muncul sebagai akibat dehidrasi berat, infeksi, atau ketidakseimbangan elektrolit pada lansia.

CHAPTER 8

PENCEGAHAN CEDERA DAN KESELAMATAN LANSIA

Ns. Deli Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

A. Pendahuluan

Jatuh merupakan penanda kerapuhan, imobilitas, dan gangguan kesehatan akut maupun kronis pada lansia. Jatuh pada gilirannya mengurangi fungsi tubuh dengan menyebabkan cedera, keterbatasan aktivitas, rasa takut jatuh, dan hilangnya mobilitas. Sebagian besar cedera pada lansia disebabkan oleh jatuh; fraktur pinggul, lengan bawah, humerus, dan pelvis biasanya disebabkan oleh efek gabungan jatuh dan osteoporosis.

Pencegahan jatuh mencakup spektrum usia dan kondisi kesehatan pada populasi lansia dan mengatasi beragam penyebab jatuh tanpa mengorbankan kualitas hidup dan kemandirian. Faktor risiko intrinsik berisiko dan lansia dengan berbagai gangguan kesehatan berada pada risiko terbesar, namun lansia sehat juga berpotensi untuk hal tersebut.

B. Konsep dasar pencegahan cedera pada lansia

1. Konsep cedera/jatuh

Gaya berjalan normal dihasilkan dari koordinasi efektif komponen saraf berikut: sistem batang otak ganglia basal, tonus otot yang teregulasi, dan pemrosesan fungsional informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, dan *proprioepsi*.

Seiring bertambahnya usia, biasanya terjadi gaya berjalan yang melebar, disertai penurunan kecepatan berjalan, panjang langkah, dan kekuatan tungkai bawah. Jatuh paling sering terjadi akibat interaksi antara faktor predisposisi (penggunaan medikasi, penyakit) dan faktor lingkungan.

Risiko jatuh meningkat seiring bertambahnya jumlah faktor risiko. Risiko jatuh dalam 1 tahun berlipat ganda untuk setiap faktor risiko yang bertambah. Risiko ini dimulai dari 8% tanpa faktor risiko dan meningkat hingga 78% dengan empat faktor risiko.

2. Faktor penyebab

Jatuh dapat dijelaskan dalam beberapa fase.

- a. Fase pertama adalah peristiwa pemicu yang menggeser pusat massa tubuh melampaui dasar tumpuannya.

Peristiwa pemicu melibatkan faktor ekstrinsik seperti bahaya lingkungan; faktor intrinsik seperti sendi yang tidak stabil, kelemahan otot, dan refleks postural yang tidak dapat diandalkan; serta aktivitas fisik yang sedang berlangsung pada saat jatuh.

- b. Fase kedua, melibatkan kegagalan sistem untuk mempertahankan postur tegak guna mendeteksi dan mengoreksi pergeseran ini tepat waktu untuk menghindari jatuh.

Kegagalan ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor intrinsik individu, seperti hilangnya fungsi sensorik, gangguan pemrosesan sentral, dan kelemahan otot.

- c. Fase ketiga adalah benturan tubuh pada permukaan lingkungan, biasanya lantai atau tanah, yang mengakibatkan transmisi gaya ke jaringan dan organ tubuh. Potensi cedera merupakan fungsi dari besarnya dan arah gaya serta kerentanan jaringan dan organ terhadap kerusakan.
- d. Fase keempat, meskipun bukan bagian dari jatuh, menyangkut dampak medis, psikologis, dari jatuh dan cedera yang menyertainya. Sekuel ini mempengaruhi tingkat kerusakan dan kecacatan akibat jatuh. Pendekatan untuk mencegah jatuh dan konsekuensinya harus berfokus pada faktor-faktor yang terkait dengan masing-masing fase ini.

Faktor fungsional yang mempengaruhi kondisi muskuloskeletal

- a. Tingkat aktivitas fisik yang rendah (kurang olahraga) merupakan risiko yang paling umum terjadi pada semua lansia, mulai dari lansia yang sehat hingga mereka yang lemah atau sakit parah.

Hal ini khususnya berkaitan dengan promosi kesehatan karena intervensi untuk meningkatkan aktivitas fisik pada lansia memiliki manfaat yang luas, tidak hanya untuk meningkatkan fungsi muskuloskeletal secara keseluruhan dan mencegah jatuh.

- b. Kurangnya ambulasi selama rawat inap dikaitkan dengan peningkatan risiko yang signifikan.
- c. Hilangnya kemampuan fungsional
- d. Penurunan kualitas hidup
- e. Efek negatif pada semua sistem tubuh
- f. Defisit nutrisi merupakan faktor risiko penting dalam penurunan kinerja muskuloskeletal secara keseluruhan dan risiko jatuh dan patah tulang.

Asupan kalsium, protein, dan vitamin D yang memadai dalam makanan sangat berkaitan tidak hanya dengan fungsi muskuloskeletal yang sehat secara keseluruhan, tetapi juga dengan pencegahan jatuh, patah tulang, osteoporosis, dan sarkopenia

Selain faktor fungsional muskuloskeletal yang bermasalah, faktor yang mempengaruhi kondisi seorang lansia berpotensi untuk resiko cedera atau jatuh adalah:

Faktor instrinsik

- a. Gaya berjalan dan stabilitas postural yang normal bergantung pada fungsi sistem sensorik, neuromuskular, dan muskuloskeletal yang tepat.

Input *proprioseptif* dan taktil pada anggota gerak, input visual, dan input vestibular sangat penting untuk menjaga pusat gravitasi tubuh dalam basis tumpuannya, dan jalur sensorik ini dapat terganggu oleh usia dan penyakit.

- b. Gangguan terkait usia. Pengaturan dan integrasi neurologis sentral fungsi sensorik dan motorik dapat mempengaruhi kecepatan, efektivitas, dan keandalan refleks postural, yang menyebabkan jatuh.

Perlambatan refleks postural terkait usia dapat meningkatkan kekuatan otot yang diperlukan untuk respons yang efektif terhadap gangguan postural, tetapi kekuatan otot rangka yang terlibat dalam kontrol postural dan berjalan menurun seiring bertambahnya usia.

Otot yang lemah dan sendi yang tidak stabil atau nyeri juga dapat memicu gangguan postural selama gerakan volunter.

- c. Nokturia
- d. Masalah tidur,
- e. Perubahan gaya berjalan,
- f. Hipotensi ortostatik,
- g. Penurunan kekuatan otot, dan
- h. Perubahan sistem saraf pusat.
- i. Gangguan penglihatan, merupakan risiko independen untuk jatuh dan rasa takut jatuh karena dampaknya terhadap mobilitas, keseimbangan, keamanan, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
- j. Kondisi patologis dapat menyebabkan gangguan fungsional yang memengaruhi penglihatan, keseimbangan, atau mobilitas.
- k. Depresi dan gangguan kognitif.

Depresi dan gangguan kognitif dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama jika dikombinasikan dengan faktor risiko lainnya. Misalnya, lansia demensia maupun depresi berpotensi pada berkurangnya kesadaran seseorang terhadap lingkungan, sehingga dapat mengganggu kemampuan untuk memproses informasi tentang stimulus lingkungan.

Lansia yang mengalami depresi memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi akibat perubahan gaya berjalan, efek samping obat, dan penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi dan merespons faktor lingkungan

- I. Konsumsi obat (*polifarmasi*) : Antikolinergik, Antikonvulsan, Antidepresan, Antihistamin, Antihipertensi, Antipsikotik, Benzodiazepin, Diuretik, Insulin dan hipoglikemik oral. Narkotika. Hipnotik sedatif, Glukokortikoid sistemik

Faktor ekstrinsik

- a. Faktor perilaku

Faktor perilaku, kognitif, dan psikologis mempengaruhi/ bagaimana seseorang mempersepsi dan beradaptasi dengan kesesuaian yang dinamis dan berubah antara kemampuannya dan tuntutan lingkungan.

- b. Psikososial

- c. Aktivitas

Aktivitas yang berisiko seperti memanjat tangga, terburu buru atau berlari. Jatuh sering terjadi diluar rumah.

Jatuh pada lansia yang mengalami gangguan kesehatan terjadi saat ambulasi, dan maunver transfer rutin. Hal ini terjadi di dalam rumah.

- d. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu hal penting dalam penyebab jatuh dan berhubungan dengan faktor risiko intrinsik yang kemungkinan memperberat. Misalnya, dari faktor lingkungan terdapat bahaya lingkungan aspeknya ringan, mudah diatasi oleh individu yang sehat. Namun dapat menjadi hambatan besar bagi pergerakan dan keselamatan bagi lansia yang memiliki gaya berjalan atau keseimbangan.

Secara umum, tuntutan fisik dari aktivitas atau tugas tertentu dapat melebihi kompetensi individu, yang mengakibatkan jatuh.

Bahaya lingkungan yang berpotensi meliputi desain tangga yang buruk dan rusak, pencahayaan yang tidak memadai, ketinggian tempat tidur dan kursi yang tidak sesuai, lantai licin; keset dan karpet yang tidak aman, serta kurangnya permukaan antiselip di kamar mandi.

Faktor lingkungan, diduga berkontribusi terhadap sepertiga hingga setengah dari kasus jatuh, tetapi sebagian besar studi tidak membandingkan paparan bahaya lingkungan pada mereka yang jatuh dengan kelompok kontrol.

Kontribusi faktor lingkungan terhadap jatuh bergantung pada faktor risiko intrinsik dan variabel situasional lainnya, tetapi relevansinya kurang dipahami. Penyandang disabilitas fungsional sangat rentan terhadap lingkungan yang berantakan, desain yang tidak kondusif, atau pencahayaan yang buruk.

Selain itu, stabilitas postur pada orang lanjut usia dapat dipengaruhi oleh lingkungan kondusif seperti pencahayaan serta desain visual dan spasial.

C. Teknik pengkajian risiko cedera di lingkungan rumah

1. Morse Fall Scale (MFS)

Skala ini mudah digunakan dan dinilai

Tabel 8.1
Morse Fall Scale

NO	KOMPONEN	SKALA	PENILAIAN
1	Riwayat terjatuh; baru atau dalam 3 bulan terakhir	• Tidak : 0 • Ya : 25	
2	Diagnosis sekunder	• Tidak : 0 • Ya : 15	
3	Bantuan berjalan	• Tidak ada, tirah baring, kursi roda, bantuan perawat : 0 • Tongkat (crutch), tongkat(cane), walker : 15 • Furniture : 30	
4	IV/heparin lock	• Tidak : 0 • Ya : 20	
5	Cara berjalan/berpindah	• Normal, tirah baring, tidak bergerak : 0 • Lemah : 10 • Terganggu: 20	
6	Status Mental:	• Mengetahui kemampuan diri : 0 • Lupa keterbatasan : 15	

Intepretasi :

Tidak ada risiko	: 0-24
Risiko rendah	: 25-50
Risiko tinggi	: > 51

Keterangan:**a. Riwayat jatuh:**

Skor 25 diberikan jika pasien pernah jatuh saat masuk rumah sakit atau jika terdapat riwayat jatuh fisiologis, seperti kejang atau gangguan gaya berjalan sebelum masuk rumah sakit. Jika pasien tidak pernah jatuh, skornya 0.

Jika pasien jatuh untuk pertama kalinya, skornya langsung meningkat sebesar 25.

b. Penggunaan IV/Heparin skor : 2.**c. Diagnosis sekunder, diberi skor 15 jika lebih dari satu diagnosis medis tercantum pada rekam medis pasien; jika tidak, diberi skor 0.****d. *Gait*:**

Gait normal ditandai dengan pasien berjalan dengan kepala tegak, lengan berayun bebas di samping, dan melangkah tanpa ragu-ragu. Gait ini mendapat skor 0.

Gait yang lemah (**skor 10**), pasien bungkuk tetapi mampu mengangkat kepala sambil berjalan, tanpa kehilangan keseimbangan. Langkahnya pendek dan pasien mungkin berjalan sempoyongan.

Gait yang terganggu (**skor 20**), pasien mengalami kesulitan bangkit dari kursi, mencoba untuk bangun dengan mendorong lengan kursi/atau dengan memantul (yaitu, dengan menggunakan beberapa upaya untuk bangkit). Kepala pasien tertunduk, dan melihat tanah.

Karena keseimbangan pasien buruk, pasien berpegangan pada furnitur, orang yang mendukung, atau alat bantu jalan untuk dukungan dan tidak dapat berjalan tanpa bantuan ini.

e. Status mental

Saat menggunakan Skala ini, status mental diukur dengan memeriksa penilaian diri pasien terhadap kemampuannya untuk berjalan. Tanyakan kepada pasien, "Apakah Anda bisa pergi ke kamar mandi sendiri atau butuh bantuan?" Jika jawaban pasien mengenai kemampuannya sendiri sesuai dengan instruksi ambulasi pada form penilaian, pasien dinilai "normal" dan diberi skor 0.

Jika respon pasien tidak sesuai dengan instruksi keperawatan atau jika respon pasien tidak realistis, maka pasien dianggap melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan lupa akan keterbatasannya dan diberi skor 15. Skor kemudian dihitung dan dicatat.

Tingkat risiko dan tindakan yang direkomendasikan (misalnya, tidak diperlukan intervensi, intervensi pencegahan jatuh standar, intervensi pencegahan risiko tinggi).

2. TUG Test

Timed Up and Go Test (TUG) digunakan untuk mengukur keseimbangan dinamis dan mobilitas. Penilaian ini akan dilakukan dengan menggunakan kursi dengan sandaran tangan (tinggi tempat duduk sekitar 45 cm dengan tinggi sandaran tangan 63 cm) dan stopwatch. Peserta akan diminta untuk berdiri, berjalan 3 meter ke garis di lantai dengan kecepatan biasa dan kembali ke posisi duduk di kursi.

Lansia diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu jalan biasa yang digunakan dalam ruangan. Lansia akan dihitung waktunya mulai dari saat instruktur berkata "mulai" dan akan berhenti ketika peserta duduk kembali dengan punggung menempel bagian belakang kursi.

3. Short Physical Performance Battery (SPPB)

Saat berbagai tes kinerja fisik tersedia, SPPB direkomendasikan, karena memiliki sifat pengukuran yang unggul dan berguna di berbagai kemampuan. SPPB mengukur kinerja waktunya pada tiga tugas, masing-masing bernilai empat, untuk mendapatkan nilai dari nol (kinerja terburuk) hingga 12 (kinerja terbaik). Pertama, jelaskan setiap tes dan tanyakan apakah orang tersebut merasa mampu melakukannya. Jika tidak, berikan nilai yang sesuai dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Tes Keseimbangan: Berdiri selama 10 detik dengan kaki di masing-masing dari tiga posisi berikut. Gunakan jumlah nilai dari tiga posisi.

Tes kecepatan berjalan:

Waktu berjalan empat meter. Waktu untuk berjalan empat meter: jika <4,82 detik: 4 poin; 4,82 - 6,20 detik: 3 poin; 6,21 - 8,70 detik: 2 poin; > 8,70 detik: 1 poin, Tidak dapat menyelesaikan: 0 poin.

Tes berdiri dari kursi:

Waktu untuk bangkit dari kursi lima kali, jika <11,19 detik 4 poin 11,2 - 13,69 detik 3 poin 13,7 - 16,69 detik 2 poin 16,7 - 59,9 detik 1 poin > 60 detik atau tidak 0 poin menyelesaikan

Skor SPPB akhir = jumlah skor dari tiga tes di atas.

D. Tes Berdiri dari Kursi

Tes sederhana dapat memutuskan apakah lansia memerlukan penilaian lebih lanjut untuk mobilitas terbatas.

Petunjuk: Tanyakan, "Apakah Anda pikir akan aman bagi Anda untuk mencoba berdiri dari kursi lima kali tanpa menggunakan lengan Anda?" (Tunjukkan kepada orang tersebut.)

Jika YA, minta mereka untuk:

Waktu orang yang mengikuti tes - penilaian lebih lanjut diperlukan jika mereka tidak dapat berdiri lima kali dalam 14 detik.



Gambar 8.1.
Tes Berdiri dan Kursi (ICOPE, 2024)

1. Penilaian risiko jatuh

- a. Mencatat riwayat jatuh, termasuk mencatat rincian semua kegiatan lansia
- b. Penilaian gaya berjalan, keseimbangan, mobilitas, dan otot dan fungsi dan *fleksibilitas* sendi
- c. Penilaian kekhawatiran jatuh, penglihatan, kognisi, status kardiovaskuler dan neurologis dan urgensi urin atau *nokturia*
- d. Tinjau ulang tentang penggunaan obat (*polifarmasi*)

2. Menilai lingkungan fisik

Penilaian tersebut meliputi melihat keadaan sekitar rumah untuk menemukan kemungkinan bahaya dan menawarkan saran. Misalnya adanya karpet yang longgar, adanya gundukan lantai dan pijakan, adanya furnitur yang menghambat akses, cahaya yang minim, akses ke toilet yang sulit. Ada kesediaan tatakan menuju pintu rumah (bila menggunakan kursi roda).

E. Intervensi keperawatan dalam meningkatkan keamanan lingkungan rumah lansia

1. Menangani Faktor Risiko Intrinsik dan Ekstrinsik

Intervensi untuk menangani faktor risiko ekstrinsik, seperti kondisi lingkungan dan penggunaan alat penahan.

- a. Mengajarkan tentang penggunaan alat bantu mobilitas dan perangkat bantu lainnya yang tepat merupakan bagian penting dari program pencegahan jatuh. Karena gangguan gaya berjalan dan keseimbangan meningkatkan risiko jatuh, intervensi yang meningkatkan mobilitas bermanfaat dalam mencegah jatuh. Intervensi untuk meningkatkan mobilitas dilaksanakan terutama oleh terapis rehabilitasi, perawat, dan staf keperawatan, sering kali melalui pendekatan interdisipliner.

Perawat bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan tentang apakah lansia dapat memperoleh manfaat dari penggunaan alat bantu mobilitas dan memfasilitasi rujukan ke terapis fisik untuk evaluasi dan pengajaran.

Dalam pertemuan komunitas, perawat dapat mengajarkan lansia dan *care giver* mereka tentang ketersediaan berbagai alat bantu mobilitas, dan alat bantu lainnya yang dapat meningkatkan keselamatan. Perawat dapat menyarankan agar lanjut usia mencari bantuan profesional untuk memilih alat bantu mobilitas dan alat bantu yang tepat. Bila alat bantu mobilitas diresepkan, tanggung jawab perawat memastikan alat bantu tersebut mudah diakses, mendorong pasien untuk menggunakan alat bantu tersebut, dan memfasilitasi rujukan untuk evaluasi ulang bila timbul pertanyaan mengenai keamanan atau efektivitas alat bantu mobilitas.

- b. Selain alat mobilitas, alas kaki yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terpeleset dan jatuh. Perawat dapat memberi saran pada lansia untuk mengenakan alas kaki antiselip baik di dalam maupun di luar ruangan.

Sangat penting untuk menyarankan lansia untuk mengenakan alas kaki antiselip, suportif, dan bertumit rendah dalam kondisi basah, dingin, atau bersalju.

- c. Terapi fisik.

Hal ini dilakukan untuk latihan kekuatan dan gaya berjalan direkomendasikan untuk mengelola lansia dengan osteoporosis dan sarkopenia. Perawat juga bertanggung jawab untuk memotivasi tindak lanjut yang memadai dan konsisten dengan program latihan yang direkomendasikan.

Dalam perawatan jangka panjang, perawat umumnya mengawasi program keperawatan restoratif di mana asisten perawat membantu penghuni dengan berjalan dan rejimen latihan lainnya yang ditetapkan oleh terapis fisik.

Program aktivitas fisik kelompok yang mencakup latihan ketahanan dan keseimbangan, efektif untuk meningkatkan fungsi muskuloskeletal dan mencegah patah tulang kerapuhan di tempat perawatan masyarakat dan perawatan jangka panjang.

- d. Nutrisi

Bentuknya meliputi suplementasi kalsium, suplementasi vitamin D, modifikasi pola makan

- e. Terapi perilaku kognitif

2. Modifikasi rumah untuk mengurangi risiko jatuh

Modifikasi rumah merupakan strategi efektif untuk mengurangi peningkatan jatuh pada lansia yang tinggal di komunitas, terutama jika mereka

tergolong berisiko tinggi jatuh. Intervensi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Risiko individu harus diidentifikasi sebelum memulai program untuk menghasilkan intervensi yang tepat sasaran dan memaksimalkan efektivitasnya.

Intervensi modifikasi rumah harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam lingkungan fisik:

- a. Lantai yang sesuai (misalnya, lantai anti-selip, permukaan kering, tanpa parket atau karpet)
- b. Pencahayaan yang memadai (misalnya, lampu tidur atau lampu tambahan, mudah dinyalakan)
- c. Perabotan yang sesuai (misalnya, tempat tidur/kursi rendah, rel samping tempat tidur, kursi dengan sandaran tangan, dan pegangan tangan di kamar mandi dan lorong)
- d. Tata letak yang memadai (misalnya, ruang yang cukup untuk bergerak dan menggunakan alat bantu jalan, semua area rapi dan bersih dari bahaya tersandung)
- e. Membersihkan lorong dari barang-barang, kabel, dan furnitur yang berserakan
- f. Mengamankan karpet, keset, dan papan lantai
- g. Menyimpan barang-barang yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau
- h. Diberikan bantalan tepi keras bila ada benda yang tajam di area kamar mandi
- i. Menggunakan tempat tidur yang dapat disesuaikan ke posisi yang sangat rendah dapat mengurangi risiko cedera akibat jatuh dari tempat tidur. Matras lembut dapat diletakkan di dekat tempat tidur dan di lokasi lain yang memungkinkan orang terjatuh, tetapi harus tetap berhati-hati agar bantalan ini tidak menimbulkan risiko jatuh
- j. Efektivitas modifikasi rumah ditingkatkan melalui intervensi multifaktorial yang mencakup evaluasi risiko, edukasi kesehatan, modifikasi lingkungan, promosi alas kaki yang tepat, rekonsiliasi pengobatan, dan manajemen kontinensia

F. Program Latihan Fisik Sederhana untuk Mencegah Jatuh pada Lansia

Sebelum memberikan saran latihan fisik, tanyakan terlebih dahulu mengenai kondisi kesehatan yang akan mempengaruhi kegiatan dan intensitas kegiatan.

1. Latihan kekuatan/resistensi : membutuhkan kekuatan otot untuk bekerja dibawah beban, menggunakan beban, atau latihan duduk ke berdiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program latihan berbasis kursi meningkatkan fungsi ekstremitas atas (kekuatan genggam tangan dan uji lengkung lengan 30 detik) dan ekstremitas bawah (berdiri di kursi 30 detik).

Perubahan ini diamati dalam intervensi jangka pendek (<12 minggu) dan jangka menengah (12 minggu hingga 6 bulan).

Hasil penelitian ditemukan bahwa latihan berbasis kursi bermanfaat bagi beberapa aspek fungsi fisik pada lansia. Meliputi keseimbangan, kecepatan berjalan, kekuatan genggaman, dan beberapa pengukuran fisik lainnya sering didokumentasikan mengalami peningkatan pada individu yang melakukan latihan berbasis kursi.

Temuan ini menambah bukti yang semakin banyak untuk mendukung pentingnya aktivitas intensitas ringan bagi kesehatan dan aktivitas kekuatan serta keseimbangan untuk menjaga fungsi fisik. Pesan penting bagi lansia yang saat ini tidak aktif, latihan berbasis kursi dapat menjadi salah satu area promotif sebagai model aktivitas yang aman dan progresif bagi lansia yang lemah atau mengalami penurunan kondisi.

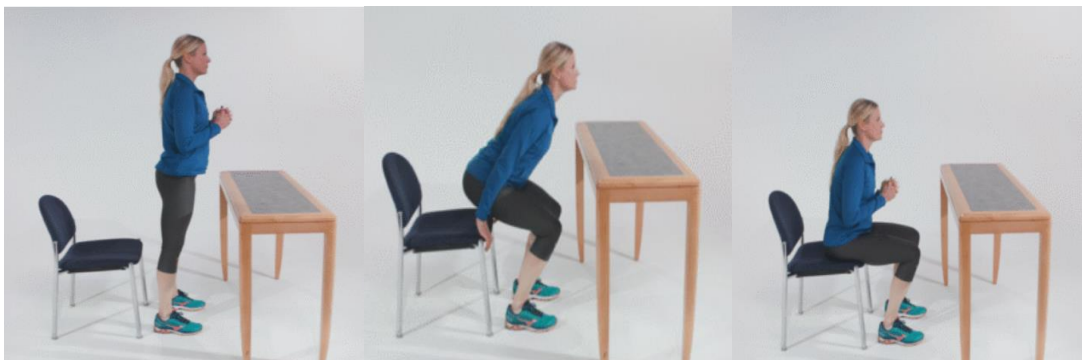
Latihan berbasis kursi harus dilakukan sebagai aktivitas yang sederhana dan mudah diimplementasikan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan serta mengimbangi efek negatif dari ketidakaktifan fisik pada lansia dan populasi rentan yang mungkin melakukan isolasi.

Prosedur:

- a. Mulailah dengan duduk di kursi yang kokoh dengan tinggi standar, dan pastikan kursi tersebut tidak bergeser atau berguling.

Lansia harus dapat duduk dengan nyaman dengan kaki rata di lantai. Siapkan permukaan penyangga yang kokoh di depan lansia, seperti meja dapur, agar dapat dipegang untuk mendapatkan dukungan jika lansia mulai merasa goyah saat berdiri. Geser tubuh lansia ke depan sehingga bokong lansia berada di depan kursi.

- b. Condongkan dada ke depan di atas jari-jari kaki, pindahkan berat badan ke depan. Kontraksikan otot gluteus lansia dan perlahan-lahan bangkitlah ke posisi berdiri yang stabil.



Gambar 8.2

Latihan duduk berdiri :<https://www.hopkinsmedicine.org/>)

- c. Perlahan duduk kembali ke posisi awal dan ulangi 10 kali.
 - d. Jika perlu, letakkan tangan lansia di lengan atau dudukan kursi dan dorong tangan lansia untuk membantu berdiri dan duduk. Tujuannya adalah untuk tidak menggunakan tangan lansia sama sekali.
 - e. Lakukan 10 repetisi, dua kali sehari. Untuk versi lanjutan, gunakan beban tangan untuk menambah resistensi.
2. Latihan aerobik seperti jalan cepat atau bersepeda yang meningkatkan denyut jantung sampai orang tersebut sedikit kehabisan nafas tetapi dapat mempertahankan percakapan.

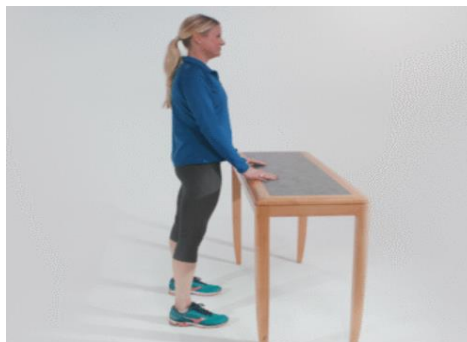
Latihan aerobik sedang dapat mencegah hilangnya massa otot pada lansia dan sangat penting bagi mereka yang sengaja mencoba menurunkan berat badan.

3. Latihan keseimbangan, yang menantang sistem keseimbangan terutama latihan statis dan dinamis.

Prosedur tahapan latihan keseimbangan :

Untuk memulai, berdirilah di sudut atau sediakan meja di depan lansia untuk memegang sesuatu jika lansia mulai kehilangan keseimbangan.

- a. Kaki terpisah: Berdirilah dengan kaki selebar bahu, mata terbuka, dan tahan selama 10 detik, lalu tingkatkan hingga 30 detik.

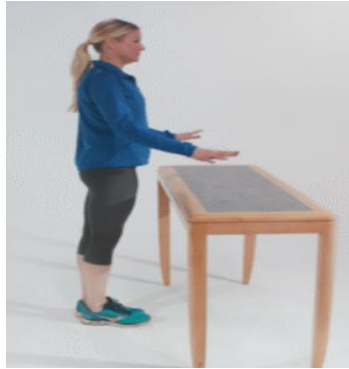


Gambar 8.3

Latihan keseimbangan : <https://www.hopkinsmedicine.org/>

Jika lansia sering bergerak/bergoyang saat berdiri, teruskan berlatih latihan ini hingga lansia dapat melakukannya dengan goyangan atau dukungan minimal. Setelah lansia dapat mempertahankan posisi ini dengan kuat selama 30 detik, lanjutkan ke latihan berikutnya.

- b. Kaki rapat: Berdirilah dengan kaki rapat, mata terbuka, dan tahan selama 10 detik, lalu tingkatkan hingga 30 detik.



Gambar 8.4

Latihan keseimbangan :<https://www.hopkinsmedicine.org/>

Setelah lansia dapat melakukan latihan ini selama 30 detik dengan sedikit goyangan atau dukungan, lanjutkan ke latihan berikutnya.

- c. Satu kaki: Berdiri dengan satu kaki, buka mata, dan tahan selama 10 detik, lanjutkan hingga 30 detik. Beralih ke kaki lainnya.



Gambar 8.5

Latihan keseimbangan :<https://www.hopkinsmedicine.org/>

- d. Mata tertutup: Jika Anda dapat melakukan tiga latihan pertama dengan aman dan dengan sedikit dukungan. Cobalah untuk melakukan masing-masing latihan dengan mata tertutup. Tahan selama 10 detik, lanjutkan hingga 30 detik.
- 4. Latihan kelenturan:** meningkatkan ekstensibilitas jaringan lunak seperti otot dan jangkauan sendi gerakan. Contohnya adalah peregangan, latihan yoga dan pilates lainnya.

G. Edukasi keluarga tentang pentingnya keamanan dan pencegahan cedera lansia di rumah

Intervensi edukasi pencegahan jatuh pada lansia memberikan dampak terhadap penurunan risiko jatuh pada lansia (Widagdo, 2024).

1. Edukasi tentang Faktor Risiko Jatuh

Jelaskan faktor-faktor risiko jatuh pada lansia, baik dari dalam diri (misalnya, penurunan fungsi tubuh, penyakit kronis, penggunaan obat-obatan tertentu) maupun dari lingkungan (lantai licin, pencahayaan kurang, perabotan tidak stabil). Tidak hanya faktor risiko jatuh, namun dampak/akibat dari jatuh merupakan hal penting. Tekankan bahwa jatuh pada lansia dapat menyebabkan cedera serius, seperti patah tulang, bahkan dapat menurunkan kualitas hidup dan kemandirian lansia.

2. Edukasi tentang Modifikasi Lingkungan Rumah

- a. Pastikan lingkungan rumah memiliki pencahayaan yang cukup, terutama di area yang sering dilalui lansia. Gunakan lampu malam atau lampu sensor gerak untuk membantu lansia melihat dengan jelas saat berjalan di malam hari.
- b. Pastikan lantai tidak licin dan tidak ada benda yang berserakan yang dapat menyebabkan tersandung. Pertimbangkan untuk menggunakan karpet anti slip di area yang rawan.
- c. Pastikan perabotan di rumah stabil dan tidak mudah bergeser. Tambahkan pegangan tangan di kamar mandi dan tangga untuk membantu lansia menjaga keseimbangan.
- d. Pastikan barang-barang yang sering digunakan lansia mudah dijangkau dan tidak perlu mengangkat terlalu tinggi atau membungkuk terlalu rendah.

3. Edukasi tentang Latihan Fisik dan Nutrisi

- a. Latihan fisik yang teratur, seperti berjalan kaki, senam lansia, atau latihan keseimbangan, latihan berbasis kursi, Tai-Chi dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan, sehingga mengurangi risiko jatuh.
- b. Pastikan lansia mendapatkan nutrisi yang seimbang dan cukup untuk menjaga kekuatan tulang dan otot. Makanan yang kaya kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang.

4. Edukasi tentang Peran Keluarga

Jelaskan pentingnya dukungan keluarga dalam mencegah jatuh pada lansia. Keluarga dapat membantu lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari,

mengingatkan untuk minum obat, dan menemani saat berjalan atau beraktivitas.

5. Edukasi tentang kesejahteraan *care giver*.

Di lingkungan rumah dan masyarakat, mencegah jatuh dan cedera akibat jatuh merupakan tanggung jawab utama bagi *caregiver* lansia yang berisiko jatuh atau memiliki riwayat jatuh. Tanggung jawab ini dapat meningkatkan stres secara signifikan bagi *care giver* karena mereka mencoba menyeimbangkan keinginan lansia untuk memiliki privasi dan kemandirian dengan risiko orang tersebut jatuh dan mengalami cedera serius.

6. Edukasi pertolongan pertama

Ajarkan keluarga atau *care giver* cara memberikan pertolongan pertama apabila lansia terjatuh

H. Kesimpulan

Pencegahan cedera, khususnya jatuh pada lansia, memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor intrinsik (seperti gangguan keseimbangan, kekuatan otot, gangguan neurologis, penglihatan, hingga depresi dan konsumsi obat) dan ekstrinsik (seperti bahaya lingkungan, perilaku berisiko, serta kondisi rumah yang tidak aman). Jatuh umumnya terjadi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara perubahan fisiologis akibat penuaan dan tantangan lingkungan.

Penilaian risiko secara menyeluruh sangat penting, mencakup aspek fisik (melalui tes seperti TUG, SPPB, dan tes berdiri dari kursi), riwayat jatuh, penggunaan obat, serta kondisi lingkungan rumah. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun intervensi pencegahan yang terarah dan efektif.

Intervensi keperawatan meliputi penanganan faktor intrinsik dan ekstrinsik berupa penguatan fisik melalui latihan, edukasi penggunaan alat bantu, pengaturan gizi, serta dukungan psikososial, modifikasi lingkungan rumah untuk menciptakan ruang yang aman dan bebas hambatan dan latihan fisik.

Pencegahan jatuh harus dilakukan secara **interdisipliner** dan **individual**, melibatkan perawat, terapis, keluarga, dan komunitas dengan pendekatan yang bersifat promotif, preventif, serta rehabilitatif.

Mengingat pentingnya keseimbangan untuk kemandirian dan keselamatan bagi lanjut usia, dan dampak dari usia, juga adanya masalah kesehatan pada kemampuan keseimbangan, latihan telah menjadi intervensi keperawatan yang meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh.

I. Referensi

- Appeadu, M. K., & Bordoni, B. (2023). Falls and Fall Prevention in Older Adults. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- CDC. (2015). *PREVENTING FALLS: A Guide to Implementing Effective Community-Based Fall Prevention Programs* (2nd Edition). Division of Unintentional Injury Prevention National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention.
- Henry, R., Sagigi, B., Miller, G., Russell, S. G., Thompson, F., Quigley, R., & Strivens, E. (2025). *The prevalence of falls and associated factors in older adults of the Torres Strait. July 2023*, 1–9. <https://doi.org/10.1111/ajag.13383>
- Klempel, N., Blackburn, N. E., McMullan, I. L., Wilson, J. J., Smith, L., Cunningham, C., Sullivan, R. O., Caserotti, P., & Tully, M. A. (2021). *The Effect of Chair-Based Exercise on Physical Function in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis*. 1–17.
- Miller, C. A. (2023). *Nursing for Wellness in Older Adults* (Ninth). Wolters Kluwer.
- US Preventive Services Task Force, Nicholson WK, Silverstein M, et al. Interventions to Prevent Falls in Community-Dwelling Older Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. 2024;332(1):51-57. doi:10.1001/jama.2024.8481
- Widagdo, W. (2024). *Pengaruh Edukasi Pencegahan Jatuh Terhadap Risiko Jatuh Pada Lanjut Usia The Effect of Fall Prevention Education on the Risk of Falls in the Elderly Abstract kondisi medis yang membutuhkan pembiayaan (World Health Organization , 2007). lansia yang tinggal di komunitas dilaporkan*. 4, 11–20. <https://doi.org/10.36082/jhcn.v4i1.1651>

CHAPTER 9

PROMOSI KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA

Ns. Arneliwati, M.Kep.

A. Pendahuluan

Indonesia sedang menghadapi fenomena transisi demografi yang signifikan, dengan populasi lansia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 29,3 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 48,2 juta jiwa atau sekitar 15,77% dari total populasi pada tahun 2035. Bahkan, Indonesia diprediksi akan memasuki era aging society pada tahun 2030, di mana proporsi lansia mencapai lebih dari 14% dari total populasi. Fenomena aging population ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sosial.

Transisi demografi ini diikuti dengan transisi epidemiologi, di mana pola penyakit bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) yang lebih dominan pada kelompok lansia. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, stroke, dan osteoporosis menjadi beban penyakit utama pada populasi lansia. Kondisi ini memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan yang berbeda, yang tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit tetapi juga pada pencegahan dan promosi kesehatan yang komprehensif.

Promosi kesehatan pada lansia memiliki karakteristik yang unik dan kompleks dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Proses penuaan membawa perubahan multidimensional yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Perubahan biologis mencakup penurunan fungsi organ tubuh, penurunan sistem imun, dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit. Perubahan psikologis meliputi adaptasi terhadap perubahan peran sosial, kehilangan orang-orang terdekat, dan penyesuaian terhadap keterbatasan fisik. Sementara itu, perubahan sosial mencakup perubahan status ekonomi, pola interaksi sosial, dan dukungan keluarga.

Konsep kualitas hidup lansia telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Paradigma lama yang hanya menekankan pada penambahan tahun hidup (adding years to life) telah bergeser menjadi penambahan

kehidupan pada tahun-tahun yang dijalani (adding life to years). Kualitas hidup lansia tidak hanya diukur dari aspek kesehatan fisik semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas termasuk kesejahteraan mental, hubungan sosial, lingkungan hidup, dan makna spiritual. Pendekatan holistik ini mengakui bahwa lansia yang sehat adalah lansia yang tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki keberfungsian optimal dalam berbagai aspek kehidupan.

World Health Organization (WHO) memperkenalkan konsep "healthy aging" sebagai proses pengembangan dan pemeliharaan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan di usia lanjut. Konsep ini menekankan pentingnya kemampuan lansia untuk melakukan hal-hal yang mereka nilai, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, belajar, tumbuh dan membuat keputusan, bergerak, membangun dan memelihara hubungan, serta berkontribusi pada masyarakat. Pendekatan ini menggeser fokus dari penyakit dan keterbatasan menuju kemampuan dan potensi yang dimiliki lansia.

Dalam konteks Indonesia, promosi kesehatan lansia memiliki tantangan tersendiri yang berkaitan dengan keragaman budaya, kondisi sosial ekonomi, dan sistem pelayanan kesehatan yang ada. Nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap orang tua memberikan modal sosial yang kuat untuk pengembangan program promosi kesehatan lansia. Namun, perubahan struktur keluarga, urbanisasi, dan modernisasi juga membawa dampak terhadap sistem dukungan tradisional untuk lansia. Oleh karena itu, pengembangan strategi promosi kesehatan lansia harus mempertimbangkan konteks budaya lokal dan memanfaatkan kearifan tradisional sambil mengintegrasikan pendekatan modern yang berbasis bukti ilmiah.

B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan pada Lansia

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Promosi kesehatan pada lansia merupakan konsep multidimensional yang didefinisikan sebagai proses pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia, sehingga dapat mencapai potensi kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Konsep ini berkembang dari paradigma biomedis tradisional yang berfokus pada penyakit menuju pendekatan yang lebih holistik yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual dalam upaya mencapai penuaan yang sehat dan bermakna.

Dalam konteks lansia, promosi kesehatan tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyakit atau memperpanjang usia hidup, tetapi lebih menekankan pada optimalisasi fungsi dan kemampuan lansia untuk menjalani kehidupan yang

bermakna dan memuaskan. Hal ini sejalan dengan konsep *successful aging* yang menekankan pada tiga komponen utama: rendahnya risiko penyakit dan kecacatan terkait penyakit, tingginya fungsi kognitif dan fisik, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap lansia memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan optimal, terlepas dari kondisi kesehatan atau keterbatasan yang mungkin dimiliki.

Ruang lingkup promosi kesehatan lansia mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Dimensi fisik meliputi pemeliharaan fungsi tubuh, pencegahan penyakit degeneratif, manajemen penyakit kronis, dan optimalisasi kemampuan fungsional untuk aktivitas sehari-hari. Dimensi mental mencakup kesehatan jiwa, fungsi kognitif, resiliensi psikologis, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam proses penuaan. Dimensi sosial berkaitan dengan interaksi sosial, dukungan keluarga dan komunitas, partisipasi dalam aktivitas sosial, dan kontribusi lansia terhadap masyarakat. Sedangkan dimensi spiritual meliputi pencarian makna hidup, kepuasan batin, dan hubungan dengan nilai-nilai transendental.

2. Prinsip-Prinsip Fundamental

Promosi kesehatan pada lansia didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang membedakannya dari pendekatan pelayanan kesehatan konvensional. Prinsip pertama adalah *person-centered care* yang menempatkan lansia sebagai pusat pelayanan dengan menghormati nilai, preferensi, dan kebutuhan individual. Prinsip ini mengakui bahwa setiap lansia adalah individu yang unik dengan pengalaman hidup, budaya, dan aspirasi yang berbeda. Implementasi prinsip ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, di mana program promosi kesehatan disesuaikan dengan karakteristik spesifik setiap lansia.

Prinsip kedua adalah *empowerment* atau pemberdayaan, yang memberikan kesempatan kepada lansia untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri lansia untuk mengelola kesehatannya sendiri. Prinsip ini juga melibatkan pengembangan kemampuan lansia untuk mengadvokasi kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan.

Prinsip ketiga adalah *family-centered approach* yang mengakui peran sentral keluarga dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan lansia. Keluarga dipandang bukan hanya sebagai penerima edukasi atau sumber informasi, tetapi sebagai mitra aktif dalam proses promosi kesehatan. Pendekatan ini melibatkan seluruh anggota keluarga dalam perencanaan dan implementasi strategi promosi

kesehatan, dengan mempertimbangkan dinamika keluarga dan sumber daya yang tersedia.

Prinsip keempat adalah *community engagement* yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan lansia. Komunitas dipandang sebagai aset yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk promosi kesehatan. Prinsip ini mendorong pembentukan kemitraan antara sektor kesehatan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan sektor swasta.

Prinsip kelima adalah *evidence-based practice* yang memastikan bahwa strategi promosi kesehatan didasarkan pada bukti ilmiah yang terkini dan relevan. Prinsip ini mencakup penggunaan penelitian dan evaluasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memodifikasi program promosi kesehatan. Selain itu, prinsip ini juga mendorong integrasi antara penelitian ilmiah dengan pengalaman praktis dan kearifan lokal dalam pengembangan intervensi yang efektif dan sesuai konteks.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lansia

Kualitas hidup lansia merupakan konstruk multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara berbagai faktor internal dan eksternal. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk mengembangkan strategi promosi kesehatan yang efektif dan tepat sasaran. World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup, serta dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian mereka.

1. Faktor Biologis dan Kesehatan Fisik

Faktor biologis merupakan determinan utama kualitas hidup lansia yang mencakup perubahan struktural dan fungsional yang terjadi sebagai bagian dari proses penuaan normal maupun patologis. Proses penuaan membawa perubahan signifikan pada berbagai sistem tubuh yang secara langsung mempengaruhi kemampuan fungsional dan kemandirian lansia. Sistem kardiovaskular mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah, peningkatan resistensi perifer, dan penurunan curah jantung yang berdampak pada kapasitas fisik dan toleransi terhadap aktivitas. Sistem muskuloskeletal mengalami sarcopenia atau penurunan massa otot, osteoporosis atau penurunan kepadatan tulang, serta degenerasi sendi yang mempengaruhi mobilitas dan keseimbangan.

Sistem saraf pusat mengalami perubahan struktural dan fungsional yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan informasi, memori, dan fungsi eksekutif. Perubahan ini dapat berdampak pada kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas kognitif kompleks dan adaptasi terhadap situasi baru. Sistem sensorik, khususnya penglihatan dan pendengaran, mengalami penurunan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi, mobilitas, dan keselamatan lansia. Gangguan penglihatan dapat meningkatkan risiko jatuh dan ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari, sementara gangguan pendengaran dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan kualitas komunikasi.

Keberadaan penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan arthritis memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup lansia. Penyakit-penyakit ini tidak hanya mempengaruhi fungsi fisik tetapi juga aspek psikologis dan sosial melalui keterbatasan aktivitas, nyeri kronis, dan kebutuhan akan perawatan jangka panjang. Polifarmasi atau penggunaan multiple medications juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan karena dapat meningkatkan risiko efek samping obat dan interaksi obat yang berdampak pada kualitas hidup.

2. Faktor Psikologis dan Kesehatan Mental

Dimensi psikologis memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup lansia dan seringkali menjadi faktor yang kurang mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan konvensional. Adaptasi psikologis terhadap proses penuaan melibatkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan perubahan peran, kehilangan, dan transisi hidup. Masa pensiun, misalnya, dapat menimbulkan krisis identitas dan kehilangan sense of purpose yang berdampak pada kesehatan mental. Kehilangan pasangan hidup, teman-teman, atau anggota keluarga dapat menyebabkan grief yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko depresi.

Perubahan fisik dan penurunan kemampuan fungsional dapat mempengaruhi konsep diri dan harga diri lansia. Stigma dan stereotip negatif terhadap penuaan yang ada dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi lansia terhadap dirinya sendiri dan menurunkan motivasi untuk tetap aktif dan produktif. Faktor kognitif seperti memori, attention, dan executive function juga berperan penting dalam kualitas hidup, karena penurunan fungsi kognitif dapat mempengaruhi kemandirian dan kemampuan untuk membuat keputusan.

Resiliensi psikologis atau kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari adversity merupakan faktor protektif yang penting bagi kualitas hidup lansia. Lansia dengan resiliensi yang tinggi cenderung memiliki strategi coping yang

efektif, pandangan hidup yang positif, dan kemampuan untuk menemukan makna dalam pengalaman hidup mereka. Faktor-faktor yang mendukung resiliensi antara lain dukungan sosial, spiritualitas, optimisme, dan self-efficacy atau kepercayaan terhadap kemampuan diri untuk mengatasi tantangan.

3. Faktor Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi

Faktor sosial memiliki pengaruh yang profound terhadap kualitas hidup lansia melalui berbagai mekanisme yang melibatkan dukungan emosional, instrumental, dan informational. Jaringan sosial yang kuat dapat memberikan sense of belonging, meningkatkan self-esteem, dan menyediakan resources untuk mengatasi stres dan tantangan hidup. Sebaliknya, isolasi sosial dan loneliness dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan bahkan mortalitas. Kualitas hubungan sosial, bukan hanya kuantitas, juga berperan penting dalam menentukan dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan.

Faktor lingkungan fisik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tempat tinggal dan komunitas lansia. Age-friendly environment yang ditandai dengan aksesibilitas fisik, keamanan, ketersediaan transportasi publik, dan fasilitas komunitas dapat mendukung lansia untuk tetap aktif dan mandiri. Sebaliknya, lingkungan yang tidak ramah lansia dapat membatasi mobilitas, mengurangi partisipasi sosial, dan meningkatkan risiko cedera. Kualitas lingkungan seperti polusi udara, kebisingan, dan kepadatan juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan lansia.

Status sosial ekonomi merupakan determinan fundamental yang mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan, nutrisi yang berkualitas, perumahan yang layak, dan opportunities for social participation. Kemiskinan pada lansia dapat menciptakan lingkaran setan di mana keterbatasan ekonomi menyebabkan akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan nutrisi yang berkualitas, yang pada gilirannya memperburuk status kesehatan dan menurunkan kualitas hidup. Selain itu, faktor budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga mempengaruhi persepsi terhadap penuaan dan treatment terhadap lansia, yang dapat berdampak pada self-perception dan well-being lansia.

D. Strategi Promosi Kesehatan untuk Lansia

1. Promosi Gaya Hidup Sehat

Promosi gaya hidup sehat merupakan fondasi utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia. Aspek nutrisi menjadi prioritas dengan penekanan pada pola makan seimbang yang mempertimbangkan kebutuhan

khusus lansia seperti asupan kalsium untuk kesehatan tulang, protein untuk mempertahankan massa otot, dan serat untuk kesehatan pencernaan.

Program aktivitas fisik disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatan lansia. Aktivitas fisik ringan hingga sedang seperti jalan santai, senam lansia, tai chi, atau yoga dapat membantu mempertahankan kekuatan otot, keseimbangan, dan fleksibilitas. Selain itu, aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga kesehatan mental dan memberikan kesempatan untuk bersosialisasi.

Manajemen stres dan kesehatan mental juga menjadi komponen penting dalam promosi gaya hidup sehat. Teknik relaksasi, meditasi, dan aktivitas rekreatif dapat membantu lansia mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Program konseling dan terapi kelompok dapat memberikan dukungan tambahan bagi lansia yang mengalami masalah psikologis.

2. Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Screening kesehatan rutin merupakan strategi penting dalam pencegahan sekunder pada lansia. Program screening meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, dan deteksi kanker sesuai dengan guidelines yang berlaku. Imunisasi juga menjadi bagian penting, terutama vaksinasi influenza dan pneumonia yang memiliki risiko tinggi pada lansia.

Edukasi tentang tanda dan gejala penyakit yang umum pada lansia perlu diberikan agar lansia dan keluarganya dapat melakukan deteksi dini. Selain itu, promosi kepatuhan terhadap pengobatan dan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan menjadi kunci keberhasilan manajemen penyakit kronis.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas

Keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung kesehatan lansia. Program edukasi keluarga mencakup pengetahuan tentang proses penuaan normal, cara merawat lansia dengan penyakit kronis, dan keterampilan komunikasi yang efektif dengan lansia. Pelatihan caregiver juga penting untuk memastikan kualitas perawatan yang optimal.

Pemberdayaan komunitas dilakukan melalui pembentukan kelompok dukungan lansia, pengembangan program lansia aktif, dan pemanfaatan kearifan lokal dalam promosi kesehatan. Kader kesehatan lansia dapat dilatih untuk menjadi ujung tombak promosi kesehatan di tingkat komunitas dengan melakukan monitoring kesehatan sederhana dan memberikan edukasi kesehatan.

E. Program-Program Promosi Kesehatan Lansia

1. Program Berbasis Fasilitas Kesehatan

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia merupakan program unggulan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan komprehensif bagi lansia.

Program ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan.

Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer mengembangkan program Geriatric Day Care yang memberikan pelayanan kesehatan holistik untuk lansia. Program ini mencakup pelayanan medis, rehabilitasi, konseling, dan aktivitas sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu lansia.

2. Program Berbasis Komunitas

Program Desa Sahabat Lansia (DSL) dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang supportif bagi lansia di tingkat desa. Program ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia, mulai dari infrastruktur fisik hingga program-program sosial kemasyarakatan.

Kelompok lansia aktif seperti kelompok senam lansia, kelompok pengajian, atau kelompok hobi memberikan wadah bagi lansia untuk tetap aktif dan bersosialisasi. Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental dan sosial lansia.

3. Program Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang baru dalam promosi kesehatan lansia. Aplikasi mobile untuk monitoring kesehatan, telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, dan wearable devices untuk monitoring aktivitas fisik dapat membantu lansia dalam self-management kesehatan.

Program edukasi kesehatan melalui media digital juga dapat menjangkau lansia yang memiliki akses terhadap teknologi. Namun, program ini perlu mempertimbangkan literasi digital lansia dan menyediakan dukungan teknis yang memadai.

F. Evaluasi dan Monitoring Program

1. Indikator Keberhasilan

Evaluasi program promosi kesehatan lansia menggunakan berbagai indikator yang mencakup aspek struktur, proses, dan outcome. Indikator struktur meliputi ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan tenaga kesehatan. Indikator proses mencakup cakupan program, kualitas pelayanan, dan partisipasi lansia. Sedangkan indikator outcome mengukur perubahan status kesehatan, kualitas hidup, dan kepuasan lansia.

Kualitas hidup dapat diukur menggunakan instrumen yang valid seperti World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) atau Short

Form-36 (SF-36). Instrumen ini mengukur berbagai domain kualitas hidup termasuk kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan.

2. Sistem Monitoring dan Feedback

Sistem monitoring yang efektif memerlukan pengumpulan data secara berkala dan analisis yang sistematis. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi. Partisipasi lansia dalam proses evaluasi penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Feedback dari hasil monitoring harus digunakan untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Mekanisme feedback yang efektif memungkinkan adaptasi program sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi lansia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Tantangan dan Peluang

1. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi program promosi kesehatan lansia menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah heterogenitas populasi lansia yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang beragam. Hal ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan individualized dalam pelaksanaan program.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kesehatan, maupun fasilitas, menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, stigma negatif terhadap penuaan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya promosi kesehatan lansia dapat menghambat partisipasi dan dukungan terhadap program.

2. Peluang Pengembangan

Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia memberikan peluang untuk mempersiapkan generasi yang akan memasuki masa lansia dengan lebih baik. Investasi dalam promosi kesehatan saat ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup lansia di masa depan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang geriatri dan gerontologi, memberikan peluang untuk pengembangan intervensi yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya healthy aging dapat menjadi momentum untuk memperkuat program promosi kesehatan lansia.

H. Kesimpulan

Promosi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup lansia merupakan tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi.

Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh faktor kesehatan fisik semata, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Strategi promosi kesehatan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik populasi lansia, dengan melibatkan partisipasi aktif lansia, keluarga, dan komunitas.

Pengembangan program promosi kesehatan lansia memerlukan kemitraan multi-sektor dan pendekatan yang berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring yang sistematis penting untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, upaya promosi kesehatan dapat berkontribusi signifikan terhadap tercapainya healthy aging dan peningkatan kualitas hidup lansia di Indonesia.

Investasi dalam promosi kesehatan lansia bukan hanya merupakan tanggung jawab moral terhadap generasi yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, promosi kesehatan lansia dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif di segala usia.

I. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS.
- Beard, J.R., Officer, A., de Carvalho, I.A., et al. (2016). The World Report on Ageing and Health: A policy framework for healthy ageing. *The Lancet*, 387(10033), 2145-2154.
- Bousquet, J., Kuh, D., Bewick, M., et al. (2015). Operational definition of active and healthy ageing (AHA): A conceptual framework. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 19(9), 955-960.
- Cesari, M., Araujo de Carvalho, I., Amuthavalli Thiyagarajan, J., et al. (2018). Evidence for the domains supporting the construct of intrinsic capacity. *The Journals of Gerontology: Series A*, 73(12), 1653-1660.
- Cosco, T.D., Prina, A.M., Perks, P., Stephan, B.C., & Brayne, C. (2013). Operational definitions of successful aging: A systematic review. *International Psychogeriatrics*, 25(3), 373-381.
- Fernández-Ballesteros, R., Benetos, A., & Robine, J.M. (2013). Positive ageing: The participation of older people in society. *Applied Psychology*, 62(2), 308-334.
- HelpAge International. (2023). *Global AgeWatch Index*. Retrieved from <https://www.helpage.org/global-agewatch/>
- Hooyman, N.R., & Kiyak, H.A. (2021). *Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective* (10th ed.). Boston: Pearson Education.

- Kane, R.L., & Kane, R.A. (2019). *Assessing Older Persons: Measures, Meaning, and Practical Applications*. New York: Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Strategi Nasional Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 2021-2025*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kirkwood, T. (2018). *The Science of Ageing Well*. London: Academic Press.
- Martinson, M., & Berridge, C. (2015). Successful aging and its discontents: A systematic review of the social gerontology literature. *The Gerontologist*, 55(1), 58-69.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pender, N.J., Murdaugh, C.L., & Parsons, M.A. (2019). *Health Promotion in Nursing Practice*. Boston: Pearson Education
- Rowe, J.W., & Kahn, R.L. (2015). Successful aging 2.0: Conceptual expansions for the 21st century. *The Journals of Gerontology: Series B*, 70(4), 593-596.
- Rowe, J.W., & Kahn, R.L. (2017). *Successful Aging 2.0: Conceptual Expansions for the 21st Century*. *The Gerontologist*, 57(2), 201-213.
- Rudnicka, E., Napierała, P., Podfigurna, A., et al. (2020). The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. *Maturitas*, 139, 6-11.
- Stephens, C., Breheny, M., & Mansvelt, J. (2015). Healthy ageing from the perspective of older people: A capability approach to resilience. *Psychology & Health*, 30(6), 715-731.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). *World Population Ageing 2019: Highlights*. New York: UN DESA
- World Health Organization. (2015). *World Report on Ageing and Health*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2020). *Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Decade of Healthy Ageing: Baseline Report*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Ageing and Health*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

J. Glosarium

Aging Population: Kondisi demografis di mana proporsi penduduk berusia lanjut (60+ tahun) dalam suatu populasi mengalami peningkatan yang signifikan.

Age-Friendly Environment: Lingkungan yang dirancang dan dikelola untuk memungkinkan lansia tetap aktif, mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan komunitas.

Chronic Care Model: Model pelayanan kesehatan yang menekankan pada perawatan proaktif, dukungan self-management pasien, dan koordinasi pelayanan untuk kondisi kronis.

Cognitive Health: Kemampuan untuk berpikir jernih, belajar, dan mengingat, yang merupakan aspek penting dari kesehatan mental secara keseluruhan.

Community-Based Care: Pelayanan kesehatan dan sosial yang diberikan di lingkungan komunitas untuk memungkinkan lansia tetap tinggal di rumah atau komunitas mereka.

Empowerment: Proses pemberdayaan individu atau kelompok untuk meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupan mereka.

Functional Capacity: Kemampuan individu untuk melakukan aktivitas yang mereka nilai, termasuk kemampuan dasar, kognitif, dan sosial.

Geriatric Assessment: Evaluasi komprehensif multidimensional untuk mengidentifikasi masalah medis, psikososial, dan fungsional pada lansia.

Healthy Aging: Proses pengembangan dan pemeliharaan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan di usia lanjut.

Multimorbidity: Keberadaan dua atau lebih kondisi kesehatan kronis pada satu individu.

Person-Centered Care: Pendekatan pelayanan yang menghormati dan merespons preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individual pasien.

Polypharmacy: Penggunaan lima atau lebih obat secara bersamaan, yang umum terjadi pada lansia dengan multiple chronic conditions.

Quality of Life: Persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai tempat mereka hidup.

Resilience: Kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari adversity, trauma, atau stres yang signifikan.

Sarcopenia: Kondisi yang ditandai dengan penurunan massa otot, kekuatan, dan fungsi yang terkait dengan proses penuaan.

Self-Management: Kemampuan individu untuk mengelola gejala, pengobatan, konsekuensi fisik dan psikososial, serta perubahan gaya hidup yang terkait dengan kondisi kronis.

Social Support: Bantuan dan dukungan yang diterima dari jaringan sosial, termasuk dukungan emosional, instrumental, dan informational.

Successful Aging: Konsep yang menekankan pada rendahnya risiko penyakit, tingginya fungsi kognitif dan fisik, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan.

Telemedicine: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh.

PROFIL PENULIS



I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., PhD., Merupakan dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Beliau adalah akademisi dan peneliti di bidang kesehatan lanjut usia. Beliau menyelesaikan pendidikan keperawatan di Universitas Indonesia, magister dan doktor filosofi keperawatan di Flinders University di Australia, dan post doktoral di University of Michigan di Amerika Serikat. Beliau adalah konsultan Asian Development Bank untuk pengembangan manajemen kasus lansia di Indonesia. Area penelitian beliau pada manajemen penyakit kronis, perawatan mandiri, epidemiologi, dan juga Delphi studi. Penulis dapat dihubungi melalui: putudarma.stikesbali@gmail.com



Annisa Febriana, S.Kep., Ns. M.Kep., Sp.Kep.Kom., Lahir di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 01 Februari 1993 dari orangtua H.Rusdiansyah dan Hj.Masitah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memiliki seorang suami Heryyanoor dan 2 orang anak yaitu Muhammad Rafli Al Hafidz dan Sheza Naira Hafizah. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Lambung Mangkurat lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi Magister dan Spesialis Keperawatan Komunitas pada tahun 2017 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2020. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan diri sebagai Dosen Keperawatan, diantaranya mengikuti kegiatan seminar nasional dan internasional, workshop, dan juga aktif dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam proses pendidikan, kegiatan pengabdian masyarakat serta penelitian. Penulis aktif dalam menulis buku dan melakukan publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi maupun scopus. Selain itu penulis juga aktif sebagai reviewer jurnal internasional dan nasional dan memiliki riwayat sebagai editor buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: annisafebriana@ulm.ac.id
Motto: "Hidup Sekali, Berkarya Sepanjang Masa."

PROFIL PENULIS



Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Menggala , 20 Desember 1990. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Mitra Indonesia tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mitra Indonesia dan lulus tahun 2015. Lalu pada tahun 2021 melanjutkan Program Profesi Ners di Universitas Mitra Indonesia lulus tahun 2022. Saat ini penulis bekerja

Universitas Mitra Indonesia mengampu mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, Proses Keperawatan Berpikir Kritis, Falsafah & Teori Keperawatan, Komunikasi Dasar Keperawatan, Kewirausahaan, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi karya ilmiah, penulis dapat dihubungi melalui e-mail resalivianica@umitra.ac.id

Motto: " Kalau Bisa Sekarang Kenapa Harus Nanti?"



Drh. Ignatius Djuniarto, S.Kep., M.M.R., Lahir di Kebumen, 26 Juni 1962. Pendidikan tinggi yang pernah penulis tempuh yaitu jenjang S1 di Fakultas kKdokteran Hewan UGM, lulus tahun 1987, tahun 2008 lulus D3 Keperawatan, dan lulus Sarjana Keperawatan pada tahun 2012. Penulis mengambil S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di UMY, lulus tahun 2018. Sebagai dosen Keperawatan di STIKES Wira Husada Yogyakarta, penulis telah melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Telah banyak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang penulis lakukan dan telah terpublikasi di jurnal terakreditasi

nasional. Penulis mengajar mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Patofisiologi, Manajemen Keperawatan, Manajemen *Patient Safety* dan Gerontik. Penulis juga aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, yaitu sebagai Ketua Komunitas Eco Enzyme Nusantara Kodya Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: ign.djuniarto@gmail.com.

PROFIL PENULIS

Ns. Riris Friandi, S.Kep, M.Kep., Lahir di Padang Sarai, 25 Desember 1986 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Perintis lulus Tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun 2014. Saat ini penulis bekerja di STIKES Bina Insani Sakti mengampu mata kuliah Keperawatan Gerontik, Manajemen Keperawatan dan Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi jurnal ilmiah di jurnal nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail endi.arbios@yahoo.com

Motto: Percayalah pada dirimu sendiri dan kemampuanmu



Imran Yaman S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Tongke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, 5 Juli 1970. Riwayat Pendidikan: D3 Keperawatan (Akper Depkes Ujung Pandang) 1991, S1 + Ners Universitas Hasanuddin 2002, Magisterv Ilmu Biomedikv Universitasv Hasanuddin, 2008, Riwayat Pekerjaan : Puskesmas Tarailu Kabp Mamuju 1992-1999. V. Dinas Kesehatan Kab. Mamuju 2000-2007
Dinas Kesehatan Kab Majene 2008-2010. Dosen DPK (L2Dikti Wilayah IX), Stikes nMarendeng Majene 2010 sampai sekarang

Penulis dapat dihubungi melalui email : imranyaman261@gmail.com

Motto ; "Mulailah dari tempatmu berada, Gunakan yang kau punya, Lakukan yang kau bisa".



Ns. Arneliwati, M.Kep., Lahir di Pekanbaru, 15 Februari 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Akademi Keperawatan (AKPER) (2000), S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Andalas - Padang (2003) Program Studi Profesi Ners Universitas Andalas - Padang (2004),. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia – Jakarta, Keperawatan Komunitas dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004

sebagai Dosen DIII Akademi Perawat (AKPER) Universitas Abdurrahman Tabrani. Saat ini penulis bekerja di Universitas Riau mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik dan Kebencanaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan aktif dalam berbagai organisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arneliwati20@gmail.com

Motto: "*Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.*"

PROFIL PENULIS



Nurhayati, SKM., MPH, Lahir di Bireuen, 16 Agustus 1965, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh mulai dari Akademi Keperawatan Padjadjaran Bandung Lulus pada Tahun 1986, Jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Aceh Lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 dan lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1984 sebagai Perawat Kamar Bedah di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Pada tahun 1986 sebagai staf Administrasi pada SPK Depkes Banda Aceh, Tahun 1993 melanjutkan pendidikan di Akper Depkes Bandung, tahun 1996 sebagai guru di SPK Depkes Banda Aceh yang selanjutnya menjadi Akbid Depkes dan menjadi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2001. Pada tahun 2007 pindah ke Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai Dosen Homepage Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (STr Kep), mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Komunikasi Terapeutik, Patofisiologi, dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti publikasi artikel, ikut seminar. Pelatihan dll. Penulis juga aktif pada organisasi PPKMI Propinsi Aceh sebagai sekretaris I, dan sebagai anggota KABA ACADEMIC SOCIETY. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurhayati_454@yahoo.com Motto Belajar hingga akhir hayat



Ns. Dely Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom., lahir di Pontianak. Penulis bertempat tinggal di Bekasi. Menyelesaikan pendidikan D-III Keperawatan di Poltekkes Cirebon (tahun 2000) kemudian melanjutkan ke jenjang S1 di STIK Sint Carolus (2004) dan Spesialis Keperawatan Komunitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (2015). Penulis memulai karir sebagai dosen tetap di Akper Yatna Yuana Lebak Rangkasbitung tahun 2004-2006, Akademi Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta (2007 – Juni 2021). Saat ini aktif di Prodi D3 Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Ners Universitas Kristen Indonesia. Penulis merupakan pengurus PW IPKKI DKI Jakarta (2017 – sekarang) dan PP IPEGRI (2024 – sekarang). Berkontribusi di dunia keperawatan dengan aktif sebagai penulis buku keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: delymaria.panggabean@uki.ac.id Motto: "Proses tidak mengingkari hasil"

Sinopsis

Buku bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan Gerontik Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" hadir sebagai panduan penting bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, dan pihak-pihak terkait dalam pelayanan kesehatan lansia. Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan berbasis bukti, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis sekaligus aplikasi praktis dalam mengelola berbagai kebutuhan perawatan lansia secara komprehensif dan holistik.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keperawatan gerontik, yang mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, serta tantangan spesifik dalam praktik keperawatan gerontik. Selanjutnya, dibahas mengenai proses keperawatan gerontik yang sistematis dan terpadu, meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Aspek penting lainnya yang disorot dalam buku ini adalah komunikasi efektif dalam keperawatan gerontik. Bab ini menyajikan strategi komunikasi khusus yang diperlukan dalam interaksi dengan lansia, untuk memastikan pesan tersampaikan secara jelas, empatik, dan menghormati kondisi psikologis lansia.

Buku ini juga menyoroti secara mendalam asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit kronis. Penanganan penyakit kronis yang kompleks seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan degeneratif lainnya, disajikan dengan pendekatan praktis berbasis bukti terbaru.

Selanjutnya, kesehatan mental pada lansia dibahas secara khusus mengingat lansia rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Strategi deteksi dini dan intervensi keperawatan berbasis bukti dijelaskan secara detail untuk mendukung kesejahteraan mental lansia.

Manajemen nutrisi dan hidrasi juga menjadi topik utama yang dikupas secara menyeluruh dalam buku ini. Pembahasan mencakup cara mengidentifikasi risiko malnutrisi dan dehidrasi, serta intervensi keperawatan praktis untuk memastikan asupan gizi dan cairan yang optimal bagi lansia.

Buku ini juga memberikan panduan praktis dalam pencegahan cedera dan keselamatan lansia, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko jatuh dan cedera lain yang dapat berdampak serius terhadap kualitas hidup lansia. Terakhir, buku ini menekankan pentingnya promosi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup lansia melalui berbagai intervensi preventif dan edukatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan Gerontik Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" hadir sebagai panduan penting bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, dan pihak-pihak terkait dalam pelayanan kesehatan lansia. Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan berbasis bukti, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis sekaligus aplikasi praktis dalam mengelola berbagai kebutuhan perawatan lansia secara komprehensif dan holistik.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keperawatan gerontik, yang mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, serta tantangan spesifik dalam praktik keperawatan gerontik. Selanjutnya, dibahas mengenai proses keperawatan gerontik yang sistematis dan terpadu, meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Aspek penting lainnya yang disorot dalam buku ini adalah komunikasi efektif dalam keperawatan gerontik. Bab ini menyajikan strategi komunikasi khusus yang diperlukan dalam interaksi dengan lansia, untuk memastikan pesan tersampaikan secara jelas, empatik, dan menghormati kondisi psikologis lansia.

Buku ini juga menyoroti secara mendalam asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit kronis. Penanganan penyakit kronis yang kompleks seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan degeneratif lainnya, disajikan dengan pendekatan praktis berbasis bukti terbaru.

Selanjutnya, kesehatan mental pada lansia dibahas secara khusus mengingat lansia rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Strategi deteksi dini dan intervensi keperawatan berbasis bukti dijelaskan secara detail untuk mendukung kesejahteraan mental lansia.

Manajemen nutrisi dan hidrasi juga menjadi topik utama yang dikupas secara menyeluruh dalam buku ini. Pembahasan mencakup cara mengidentifikasi risiko malnutrisi dan dehidrasi, serta intervensi keperawatan praktis untuk memastikan asupan gizi dan cairan yang optimal bagi lansia.

Buku ini juga memberikan panduan praktis dalam pencegahan cedera dan keselamatan lansia, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko jatuh dan cedera lain yang dapat berdampak serius terhadap kualitas hidup lansia. Terakhir, buku ini menekankan pentingnya promosi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup lansia melalui berbagai intervensi preventif dan edukatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

